

# **Buku Ajar** **KONSEP DAN PRAKTIK** **MANAJEMEN KEPERAWATAN**

Ns. Ari Sukma Nela, S.Kep., M.Kep.



# Buku Ajar

## Konsep dan Praktik Manajemen Keperawatan

Oleh:

Ns. Ari Sukma Nela, S.Kep., M.Kep.



**Optimal  
Untuk  
Negeri**

# Buku Ajar

## Konsep dan Praktik Manajemen Keperawatan

**Penulis:**

Ns. Ari Sukma Nela, S.Kep., M.Kep.

**ISBN:** 978-634-7556-87-5

**Desain Sampul** : Ivan Zumarano

**Penata Letak** : Achmad Faisal

**Cetakan Pertama:** April, 2026

**Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang**

**Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

*All Right Reserved*

**Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.**



**PT OPTIMAL UNTUK NEGERI**

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan,  
Jakarta Barat

Website : [optimaluntuknegeri.com](http://optimaluntuknegeri.com)

Instagram : @bimbel.optimal dan @optimal.penerbit

Tiktok : @bimbelukomoptimal

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

# Prakata

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan **Buku Ajar Konsep dan Praktik Manajemen Keperawatan** sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Penyusunan buku ini sebagai wujud pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Buku ini memuat berbagai konsep dan tahapan proses manajemen keperawatan yang umum diterapkan difasilitas pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit dan Faskes satu atau puskesmas perawatan. Penulis berharap kehadiran buku ini dapat menjadi rujukan yang bermanfaat bagi mahasiswa, praktisi kesehatan di bidang manajemen keperawatan, peneliti kesehatan, serta masyarakat umum.”

Buku Konsep Manajemen Keperawatan dan Praktik Manajemen Keperawatan terdiri dari:

Bab 1 Menganalisis Teori Manajemen dan Teori Kepemimpinan

Bab 2 Fungsi Manajemen

Bab 3 Pre Conference, Bedside Handover, dan Post Conference

Bab 4 Ronde Keperawatan

Bab 5 Discharge Planning

Penulis menyampaikan apresiasi yang setulusnya kepada seluruh kontributor. Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada keluarga atas dukungan yang diberikan, serta kepada semua pihak yang telah berperan dalam proses penyelesaian buku ini. Penulis berharap karya ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, akademisi, dan praktisi di bidang keperawatan pada khususnya, serta bagi tenaga kesehatan pada umumnya.

Bandar Lampung, Januari 2026

Ns. Ari Sukma Nela, S.Kep., M.Kep.

# Daftar Isi

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| <b>Prakata .....</b>    | <b>iii</b> |
| <b>Daftar Isi .....</b> | <b>iv</b>  |

## **BAB 1 Menganalisis Teori Manajemen dan Teori**

|                                                                                      |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Kepemimpinan.....</b>                                                             | <b>1</b> |
| A. Teori Manajemen Keperawatan .....                                                 | 5        |
| 1. Pengertian Manajemen Keperawatan.....                                             | 5        |
| 2. Peran Manajemen Keperawatan.....                                                  | 6        |
| 3. Fungsi Manajemen Keperawatan .....                                                | 8        |
| 4. Teori Manajemen.....                                                              | 10       |
| B. Teori Kepemimpinan .....                                                          | 13       |
| 1. Teori Great Man .....                                                             | 13       |
| 2. Teori Sifat ( <i>Trait Theory</i> ).....                                          | 14       |
| 3. Teori Perilaku ( <i>Behavioral Theory</i> ) .....                                 | 16       |
| 4. Teori Kontingensi ( <i>Contingency Theory</i> ) .....                             | 17       |
| 5. Teori Jalur Tujuan ( <i>Path–Goal Theory</i> ).....                               | 18       |
| 6. Teori Kepemimpinan Transformasional<br>( <i>Transformational Theory</i> ).....    | 19       |
| 7. Teori Kepemimpinan Pelayan ( <i>Servant Theory</i> ) .....                        | 20       |
| 8. Teori Kepemimpinan Transaksional ( <i>Transactional<br/>        Theory</i> )..... | 21       |
| C. Gaya Kepemimpinan, Perbedaan dan Penggunaannya<br>.....                           | 23       |
| D. Latihan.....                                                                      | 25       |
| E. Rangkuman Materi .....                                                            | 28       |

## **BAB 2 Fungsi Manajemen ..... 30**

|                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Manajemen Perencanaan dan Menyusun Rencana<br>Operasional Unit Ruang Rawat..... | 34 |
| 1. Konsep Dasar Perencanaan dan<br><i>Nature of Planning</i> .....                 | 34 |
| 2. Komponen Perencanaan .....                                                      | 35 |
| 3. Jenis Perencanaan.....                                                          | 36 |
| 4. Proses Perencanaan .....                                                        | 37 |

|                                                                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 5. Perencanaan dalam Manajemen Asuhan Keperawatan di Ruang Rawat Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Renop) .....           | 38 |
| B. Pengorganisasian dan Metode Pemberian Asuhan Keperawatan .....                                                      | 39 |
| 1. Pengertian Pengorganisasian, Prinsip, Budaya, dan Iklim Organisasi .....                                            | 39 |
| 2. Struktur Organisasi dalam Keperawatan .....                                                                         | 40 |
| 3. Implementasi Pengorganisasian Keperawatan di Ruang Rawat Fasilitas Pelayanan Kesehatan.....                         | 41 |
| 4. Metode Penugasan/Pemberian Asuhan Keperawatan (K/P).....                                                            | 42 |
| C. Perencanaan dan Penjadwalan Ketenagaan Keperawatan .....                                                            | 43 |
| 1. Pengertian, Pentingnya Ketenagaan yang Aman ( <i>Safe Staffing</i> ), Prinsip, Komponen, dan Tujuan Ketenagaan..... | 43 |
| 2. Pola Ketenagaan dan Faktor yang Mempengaruhi .                                                                      | 44 |
| 3. Cara Penghitungan Jumlah Tenaga dalam Suatu Shift .....                                                             | 45 |
| 4. Alokasi dan Penjadwalan Tenaga Keperawatan Setiap Shift .....                                                       | 49 |
| D. Manajemen Pengarahan dan Mempraktikkan Supervisi Manajemen .....                                                    | 50 |
| 1. Pengertian, Prinsip, Elemen Pengarahan, dan <i>Organizational Behavior</i> .....                                    | 50 |
| 2. Peran dan Fungsi Pengarahan.....                                                                                    | 51 |
| 3. Supervisi yang Efektif .....                                                                                        | 52 |
| E. Kontroling, EBNP, dan Mutu Asuhan Keperawatan Sesuai Standar .....                                                  | 53 |
| 1. Pengertian Mutu, Tujuan dan Manajemen Mutu, Model Pendekatan Mutu Termasuk Kaizen .....                             | 53 |
| 2. <i>Evidence-Based Nursing Practice</i> (EBNP) dan Mutu Asuhan Keperawatan.....                                      | 54 |
| 3. Proses Menjaga Mutu Asuhan Keperawatan di Ruang Rawat dan Analisis Masalah Mutu dengan Model RCA .....              | 55 |
| F. Latihan.....                                                                                                        | 57 |
| G. Rangkuman Materi .....                                                                                              | 61 |

### **BAB 3 Pre Conference, Bedside Handover, dan Post**

|                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Conference .....</b>                                                         | <b>64</b> |
| A. Definisi Pre Conference, Bedside Handover, dan Post Conference .....         | 67        |
| B. Tujuan Pre, Bedside Handover dan Post Conference .....                       | 68        |
| C. Syarat Pelaksanaan .....                                                     | 70        |
| D. Waktu dan Tempat Pelaksanaan .....                                           | 71        |
| E. Alur dan Tahapan Pelaksanaan .....                                           | 72        |
| F. Materi yang Disampaikan oleh Perawat Pelaksana dalam <i>Conference</i> ..... | 76        |
| G. Latihan .....                                                                | 77        |
| H. Rangkuman Materi .....                                                       | 82        |

### **BAB 4 Ronde Keperawatan..... 85**

|                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| A. Definisi Ronde Keperawatan .....                       | 88  |
| B. Tujuan Ronde Keperawatan .....                         | 89  |
| C. Prinsip Ronde Keperawatan .....                        | 90  |
| D. Jenis-Jenis Ronde Keperawatan .....                    | 92  |
| E. Peran dan Tanggung Jawab dalam Ronde Keperawatan ..... | 95  |
| F. Tahapan Pelaksanaan Ronde Keperawatan .....            | 96  |
| G. Latihan .....                                          | 97  |
| H. Rangkuman Materi .....                                 | 101 |

### **BAB 5 Discharge Planning .....105**

|                                                                                                    |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| A. Pengertian <i>Discharge Planning</i> .....                                                      | 109 |
| B. Tujuan <i>Discharge Planning</i> .....                                                          | 110 |
| C. Tahapan <i>Discharge Planning</i> .....                                                         | 111 |
| D. Upaya Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien .....                                             | 115 |
| E. Arah Pengembangan dan Inovasi <i>Discharge Planning</i> di Era Pelayanan Kesehatan Modern ..... | 116 |
| F. Latihan .....                                                                                   | 119 |
| G. Rangkuman Materi .....                                                                          | 123 |

### **Biodata Penulis ..... 127**

### **Daftar Pustaka ..... 128**

# BAB 1

## Menganalisis Teori Manajemen dan Teori Kepemimpinan

### Pendahuluan

Bab *Menganalisis Teori Manajemen dan Teori Kepemimpinan* disusun sebagai landasan konseptual dalam memahami dinamika pengelolaan organisasi dan praktik kepemimpinan dalam konteks pelayanan kesehatan, khususnya keperawatan. Manajemen dan kepemimpinan merupakan dua konsep yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam upaya mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Perkembangan ilmu pengetahuan, kompleksitas sistem pelayanan kesehatan, serta tuntutan mutu dan keselamatan pasien menuntut tenaga kesehatan, terutama perawat, untuk memiliki pemahaman teoritis yang kuat sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan peran profesionalnya.

Bab ini bertujuan untuk membekali pembaca dengan pemahaman yang komprehensif mengenai berbagai teori manajemen dan teori kepemimpinan, mulai dari teori klasik hingga teori kontemporer, serta relevansinya dalam praktik keperawatan modern. Melalui analisis teori-teori tersebut, pembaca diharapkan mampu mengidentifikasi karakteristik, kelebihan, dan keterbatasan masing-masing teori, serta mengaplikasikannya secara kontekstual sesuai dengan kebutuhan organisasi dan tingkat kompleksitas pelayanan.



Dengan demikian, bab ini tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga mendorong kemampuan berpikir kritis dan analitis.

Sasaran pembaca bab ini adalah mahasiswa program studi keperawatan, dosen, serta praktisi keperawatan yang berperan dalam fungsi manajerial dan kepemimpinan. Materi disusun secara sistematis dan terstruktur, mencakup pembahasan definisi, konsep dasar, perkembangan teori, hingga implikasi praktis dalam pengelolaan pelayanan keperawatan. Penyajian materi dirancang untuk mendukung proses pembelajaran di perguruan tinggi sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah sebagaimana diamanatkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pendekatan pembelajaran dalam bab ini mengintegrasikan kajian teoritis dengan contoh aplikatif dalam konteks nyata pelayanan keperawatan, sehingga memudahkan pembaca dalam mengaitkan konsep dengan praktik. Pembaca dianjurkan untuk mempelajari bab ini secara berurutan, mengkaji setiap konsep secara kritis, serta memanfaatkan latihan reflektif atau diskusi yang disarankan untuk memperdalam pemahaman. Dengan pendekatan tersebut, bab ini diharapkan dapat menjadi pedoman konseptual yang relevan dan aplikatif dalam membentuk kompetensi manajerial dan kepemimpinan perawat yang profesional.

## **CPMK dan Sub-CPMK**

### **Untuk Teori Manajemen Keperawatan**

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) pada bab ini adalah agar mahasiswa memiliki pemahaman dan penguasaan dan aplikasi terhadap berbagai teori manajemen keperawatan.

Adapun Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK) dirumuskan sebagai berikut:

1. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengertian, peran, fungsi dan teori manajemen.
2. Mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan teori manajemen keperawatan.

Untuk mendukung pencapaian CPMK dan Sub-CPMK tersebut, berikut disajikan petunjuk pembelajaran yang perlu diperhatikan agar mahasiswa dapat menguasai materi yang dibahas dalam bab ini secara optimal, mahasiswa mampu:

- Mahasiswa membaca dan memahami CPMK, Sub-CPMK, serta pendahuluan sebagai acuan pembelajaran.
- Mahasiswa membaca materi pokok pembelajaran secara sistematis dan cermat.
- Mahasiswa mencermati konsep utama, istilah kunci, dan definisi penting teori kepemimpinan.
- Mahasiswa mengaitkan materi dengan penerapan kepemimpinan dalam praktik profesional.
- Mahasiswa melakukan diskusi untuk memperdalam pemahaman dan berpikir kritis.
- Mahasiswa mengerjakan tugas, latihan, atau refleksi pada akhir bab.
- Mahasiswa memanfaatkan sumber belajar tambahan yang relevan.

### **Untuk Teori Kepemimpinan**

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) pada bab ini adalah agar mahasiswa memiliki pemahaman dan penguasaan dan aplikasi terhadap berbagai teori kepemimpinan.

Adapun Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK) dirumuskan sebagai berikut:

1. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Teori Great Man.
2. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Teori Sifat (*Trait Theory*).
3. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Teori Perilaku (*Behavioral Theory*)
4. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Teori Kontingensi (*Contingency Theory*).
5. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Teori Jalur Tujuan (*Path-Goal Theory*).
6. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Teori Kepemimpinan Transformasional (*Transformational Theory*).

7. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Teori Kepemimpinan Pelayan (*Servant Theory*).
8. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Teori Kepemimpinan Transaksional (*Transactional Theory*).

Untuk mendukung pencapaian CPMK dan Sub-CPMK tersebut, berikut disajikan petunjuk pembelajaran yang perlu diperhatikan agar mahasiswa dapat menguasai materi yang dibahas dalam bab ini secara optimal.

- Mahasiswa membaca dan memahami CPMK, Sub-CPMK, serta pendahuluan sebagai acuan pembelajaran.
- Mahasiswa membaca materi pokok pembelajaran secara sistematis dan cermat.
- Mahasiswa mencermati konsep utama, istilah kunci, dan definisi penting teori kepemimpinan.
- Mahasiswa mengaitkan materi dengan penerapan kepemimpinan dalam praktik profesional.
- Mahasiswa melakukan diskusi untuk memperdalam pemahaman dan berpikir kritis.
- Mahasiswa mengerjakan tugas, latihan, atau refleksi pada akhir bab.
- Mahasiswa memanfaatkan sumber belajar tambahan yang relevan.

# Uraian Materi

---

## A. Teori Manajemen Keperawatan

### 1. Pengertian Manajemen Keperawatan

Manajemen keperawatan merupakan suatu proses sistematis dalam mengelola dan menyelesaikan pekerjaan melalui anggota staf keperawatan dengan menerapkan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan secara efektif, efisien, serta rasional. Proses ini berjalan seiring dan terintegrasi dengan proses keperawatan yang meliputi pengumpulan data, identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, sebagai upaya untuk memberikan asuhan keperawatan yang profesional dan komprehensif. Melalui pemanfaatan sumber daya yang optimal, manajemen keperawatan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan bio-psiko-sosial-spiritual individu, keluarga, dan masyarakat, baik dalam kondisi sehat maupun sakit, guna mencapai tujuan pelayanan keperawatan yang telah ditetapkan (Nursalam, 2013).

Manajemen keperawatan merupakan suatu proses pengoordinasian dan pengintegrasian berbagai sumber daya keperawatan melalui penerapan fungsi-fungsi manajemen untuk mencapai tujuan organisasi serta meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan asuhan dan pelayanan keperawatan. Proses manajemen tersebut meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan sumber daya manusia dan sarana, pengarahan, serta pengendalian secara sistematis. Dalam pelaksanaannya, manajer keperawatan memiliki peran strategis dalam memastikan seluruh fungsi manajemen terlaksana secara efektif, termasuk optimalisasi pengelolaan sumber daya material dan

tenaga keperawatan (Meylda & Izzati, 2025). Manajer yang mampu menjalankan fungsi kepemimpinan dengan baik akan memotivasi perawat untuk menerapkan standar mutu pelayanan yang tinggi.

Selain itu, dukungan pimpinan turut memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap pengembangan profesional perawat, sehingga keterlibatan aktif perawat dalam pelaksanaan tugas dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas profesionalisme keperawatan secara menyeluruh (Nela, 2025).

## **2. Peran Manajemen Keperawatan**

Ada banyak pendapat ahli manajemen terkait peran manajemen keperawatan, diantaranya :

### **a. Huber (*Nursing Leadership and Management*)**

Huber menegaskan bahwa manajemen keperawatan berperan:

- Mengelola sumber daya manusia, sarana, dan prasarana keperawatan.
- Menjamin mutu pelayanan melalui penerapan standar praktik profesional.
- Mengembangkan staf melalui pendidikan, pelatihan, dan pembinaan profesional.
- Menjaga kesinambungan pelayanan melalui perencanaan, koordinasi, dan evaluasi.

Dengan demikian, manajer keperawatan bertanggung jawab memastikan pelayanan yang berkualitas, aman, dan berfokus pada pasien.

### **b. Marquis & Huston**

Marquis dan Huston menyatakan bahwa peran manajemen keperawatan mencakup:

- Peran sebagai pemimpin (*Leadership Role*): mengarahkan dan memengaruhi staf agar mencapai tujuan organisasi.

- Peran sebagai manajer (*Management Role*): memastikan pelaksanaan asuhan keperawatan berjalan sesuai kebijakan, prosedur, dan standar mutu.
  - Peran sebagai pengambil keputusan: menentukan strategi pelayanan, menangani masalah, serta mengambil keputusan berbasis bukti.
  - Peran sebagai motivator dan fasilitator: mendorong keterlibatan perawat dalam praktik profesional dan peningkatan mutu layanan.
- c. Swansburg
- Swansburg menekankan bahwa manajemen keperawatan berperan dalam:
- Menjamin efisiensi dan efektivitas pelayanan keperawatan.
  - Mengelola tenaga keperawatan agar produktif dan profesional.
  - Mengoptimalkan penggunaan sumber daya organisasi.
  - Mengarahkan praktik keperawatan agar sesuai standar etik, legal, dan profesional.
- (Ii & Pustaka, 2012)

Dapat disimpulkan, menurut para ahli manajemen dan pakar keperawatan, peran manajemen keperawatan mencakup pengaturan sumber daya, kepemimpinan, pengambilan keputusan, pengembangan profesional perawat, serta pengendalian mutu pelayanan. Melalui peran tersebut, manajemen keperawatan berfungsi memastikan pelayanan keperawatan berjalan efektif, efisien, aman, dan berkualitas sesuai tujuan organisasi kesehatan (Nela, 2025).

### 3. Fungsi Manajemen Keperawatan

Manajemen keperawatan merupakan proses sistematis yang bertujuan untuk mengatur, mengarahkan, dan memastikan penyelenggaraan pelayanan keperawatan berjalan efektif, efisien, aman, dan berkualitas. Dalam praktiknya, manajemen keperawatan menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengaturan sumber daya manusia, pengarahan/pelaksanaan, dan pengendalian. Pelaksanaan fungsi tersebut menjadi dasar bagi keberhasilan organisasi pelayanan kesehatan dalam mencapai tujuan pelayanan keperawatan.

Menurut (Gillies, 1989) fungsi manajemen sebagai berikut:

#### a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan fungsi awal dalam manajemen keperawatan yang dilakukan untuk menentukan arah, tujuan, serta strategi pelaksanaan pelayanan keperawatan. Dalam tahap ini, manajer keperawatan menetapkan tujuan pelayanan, mengidentifikasi kebutuhan sumber daya, memetakan prioritas, serta menyusun langkah operasional yang sistematis. Perencanaan mencakup perencanaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dengan mempertimbangkan visi, misi, dan kebijakan organisasi kesehatan.

Pada konteks pelayanan keperawatan, perencanaan mencakup penentuan kebutuhan tenaga keperawatan, penyusunan standar operasional prosedur, pengaturan beban kerja, serta penetapan indikator mutu pelayanan. Perencanaan yang baik akan membantu organisasi mewujudkan pelayanan yang efektif, aman, dan sesuai standar profesional.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian merupakan proses penataan struktur organisasi keperawatan untuk memastikan setiap tugas, wewenang, dan tanggung jawab terdistribusi secara jelas. Pada tahap ini, manajer keperawatan menetapkan pola struktur organisasi, membagi tugas sesuai kompetensi perawat, serta menetapkan hubungan kerja antar individu maupun antar unit. Fungsi pengorganisasian bertujuan untuk menciptakan keteraturan kerja, memperjelas alur koordinasi, serta menghindari tumpang tindih peran. Dalam konteks keperawatan, pengorganisasian mencakup penentuan sistem penugasan (seperti tim, primer, atau fungsional), pengaturan alur komunikasi pelayanan, serta pengaturan mekanisme pelaporan. Dengan demikian, pengorganisasian berperan sebagai landasan tata kelola pelayanan keperawatan.

c. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (*Staffing*)

Pengelolaan sumber daya manusia menjadi fungsi penting dalam manajemen keperawatan karena tenaga keperawatan berperan sebagai komponen utama penyelenggara pelayanan. Fungsi ini mencakup perencanaan kebutuhan tenaga, rekrutmen, seleksi, penempatan, orientasi, pembinaan, pengembangan kompetensi, serta evaluasi kinerja perawat. Manajer keperawatan bertanggung jawab memastikan tenaga keperawatan memiliki kompetensi yang sesuai standar, mendapatkan pelatihan berkelanjutan, serta memperoleh dukungan dalam pengembangan profesional. Pengelolaan sumber daya manusia yang optimal akan meningkatkan kinerja, kepuasan kerja, dan mutu pelayanan keperawatan.



d. Pengarahan/Pelaksanaan (*Directing/Actuating*)

Pengarahan merupakan fungsi manajemen yang berfokus pada upaya memimpin, memotivasi, membimbing, dan mengarahkan tenaga keperawatan agar melaksanakan tugas sesuai tujuan organisasi. Pada tahap ini, manajer keperawatan berperan dalam membangun komunikasi yang efektif, memberikan instruksi kerja yang jelas, menciptakan iklim kerja kondusif, serta menumbuhkan motivasi dan komitmen staf. Selain itu, pengarahan juga mencakup penerapan kepemimpinan yang adaptif, pengambilan keputusan, penyelesaian konflik, serta pembinaan kinerja. Fungsi ini sangat menentukan keberhasilan implementasi pelayanan keperawatan karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas di lapangan.

e. Pengendalian atau Pengawasan (*Controlling*)

Pengendalian merupakan fungsi manajemen yang bertujuan memastikan seluruh kegiatan pelayanan keperawatan berjalan sesuai rencana, standar, dan kebijakan organisasi. Pengendalian dilakukan melalui proses pemantauan, pengukuran kinerja, evaluasi hasil, serta tindakan koreksi apabila ditemukan penyimpangan. Dalam praktik keperawatan, pengendalian meliputi audit mutu keperawatan, supervisi klinik, evaluasi kinerja staf, pemantauan keselamatan pasien, serta evaluasi pemenuhan standar pelayanan. Hasil pengendalian digunakan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan sehingga mutu pelayanan keperawatan dapat terus ditingkatkan.

#### **4. Teori Manajemen**

Melalui teori manajemen keperawatan, perawat manajer memperoleh kerangka berpikir yang jelas dalam menjalankan peran kepemimpinan, pengelolaan sumber daya, serta pengambilan keputusan yang berorientasi

pada mutu pelayanan keperawatan. Menurut Huber (2014) teori manajemen keperawatan dibagi menjadi beberapa:

a. Teori Manajemen Klasik

Teori manajemen klasik menjadi dasar dalam pengembangan manajemen keperawatan modern. Henri Fayol menyatakan bahwa manajemen merupakan proses yang melibatkan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengendalian. Dalam konteks keperawatan, teori ini menekankan pentingnya perencanaan pelayanan, pembagian tugas yang jelas, penetapan struktur organisasi keperawatan, serta pelaksanaan supervisi dan evaluasi secara sistematis. Melalui pendekatan ini, pelayanan keperawatan dapat berjalan dengan teratur, terstruktur, dan sesuai standar.

b. Teori Birokrasi Weber

Max Weber memperkenalkan teori birokrasi yang menekankan pentingnya struktur organisasi yang formal, jelas, dan rasional. Dalam pelayanan keperawatan, teori ini menekankan adanya pembagian kerja yang tegas, hierarki kewenangan yang jelas, penerapan aturan dan prosedur standar, serta pengelolaan pelayanan berbasis regulasi. Penerapan teori ini membantu organisasi keperawatan dalam menjaga konsistensi pelayanan, menjamin keselamatan pasien, serta memastikan setiap tenaga keperawatan bekerja sesuai standar operasional prosedur.

c. Teori Hubungan Manusia (*Human Relations Theory*)

Elton Mayo menekankan bahwa keberhasilan manajemen bukan hanya bergantung pada struktur organisasi, tetapi juga pada aspek psikologis dan sosial tenaga kerja. Dalam keperawatan, teori ini menegaskan pentingnya motivasi, kepuasan kerja,

komunikasi efektif, hubungan interpersonal, dan dukungan emosional terhadap perawat. Manajer keperawatan perlu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, menghargai kontribusi staf, serta membangun kerja tim yang harmonis untuk meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan.

d. Teori Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan

Teori perilaku organisasi memandang bahwa perilaku individu dan kelompok memengaruhi efektivitas organisasi. Dalam keperawatan, teori ini menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan, pengambilan keputusan, persepsi, sikap, dan komitmen perawat sangat menentukan keberhasilan pelayanan. Pemimpin keperawatan diharapkan mampu menerapkan kepemimpinan yang partisipatif, suportif, dan transformasional agar mampu mengembangkan potensi perawat dan meningkatkan mutu pelayanan.

e. Teori Sistem dalam Manajemen Keperawatan

Teori sistem memandang organisasi sebagai suatu kesatuan yang terdiri atas komponen saling terkait. Dalam konteks keperawatan, unit pelayanan keperawatan merupakan bagian dari sistem rumah sakit yang berinteraksi dengan berbagai komponen seperti dokter, tenaga kesehatan lain, pasien, keluarga, serta kebijakan organisasi. Manajemen keperawatan harus mampu mengintegrasikan seluruh komponen sistem agar proses pelayanan berjalan efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan pasien.

f. Teori Kontingensi

Teori kontingensi menyatakan bahwa tidak ada satu pendekatan manajemen yang paling tepat untuk semua situasi. Manajemen keperawatan harus disesuaikan dengan kondisi organisasi, karakteristik tenaga keperawatan, beban kerja, budaya organisasi, serta situasi pelayanan kesehatan. Dengan demikian,

pemimpin keperawatan perlu bersikap fleksibel, adaptif, dan mampu membuat keputusan yang disesuaikan dengan dinamika organisasi dan kebutuhan pelayanan.

g. Teori Manajemen Mutu dalam Keperawatan

Dalam perkembangan modern, manajemen keperawatan menekankan pentingnya mutu pelayanan. Konsep manajemen mutu seperti Total Quality Management (TQM) dan Continuous Quality Improvement (CQI) diterapkan untuk menjamin keselamatan pasien, peningkatan mutu layanan, standar akreditasi, serta kepuasan pasien. Manajer keperawatan berperan memastikan penerapan standar praktik, audit mutu, supervisi klinis, serta evaluasi berkelanjutan.

## B. Teori Kepemimpinan

### 1. Teori Great Man

a. Pengertian

Teori Great Man merupakan salah satu pendekatan klasik dalam kajian kepemimpinan yang berasumsi bahwa pemimpin besar *dilahirkan* dengan seperangkat sifat unggul, bukan dibentuk oleh proses pembelajaran atau pengalaman. Tokoh utama yang mempopulerkan konsep ini adalah Thomas Carlyle pada pertengahan abad ke-19, yang menyatakan bahwa sejarah dunia dibentuk oleh individu-individu luar biasa yang memiliki bakat alami sebagai pemimpin. Teori ini menekankan bahwa kemampuan memimpin merupakan warisan biologis dan bawaan sejak lahir, sehingga tidak semua orang dapat menjadi pemimpin.

b. Asumsi Teori

Teori Great Man berlandaskan beberapa asumsi utama berikut:

- 1) Kepemimpinan bersifat bawaan (*innate*).  
Individu tertentu memiliki bakat kepemimpinan sejak lahir (*natural born leaders*).
- 2) Pemimpin muncul pada situasi kritis  
Pemimpin besar biasanya tampil pada situasi kompleks, krisis, atau kondisi yang menuntut pengambilan keputusan besar.
- 3) Memiliki sifat dan karakter Istimewa  
Karakter seperti keberanian, karisma, kecerdasan, dominasi, ketegasan, dan kepercayaan diri dianggap melekat secara alamiah pada diri seorang pemimpin.
- 4) Bersifat elitis  
Tidak semua orang dapat menjadi pemimpin karena kepemimpinan dianggap sebagai anugerah alamiah, bukan hasil pelatihan.

Teori Great Man menempatkan kepemimpinan sebagai suatu anugerah alamiah yang hanya dimiliki individu tertentu sejak lahir. Walaupun memberikan fondasi awal dalam kajian kepemimpinan dan menjelaskan munculnya tokoh besar dalam sejarah, teori ini memiliki keterbatasan karena kurang mempertimbangkan aspek pendidikan, pelatihan, budaya, serta dinamika organisasi modern. Dalam konteks keperawatan dan kesehatan, teori ini lebih tepat dipahami sebagai landasan historis perkembangan teori kepemimpinan, bukan sebagai satu-satunya pendekatan yang digunakan pada praktik kepemimpinan masa kini.

## 2. Teori Sifat (*Trait Theory*)

Menjelaskan bahwa efektivitas kepemimpinan ditentukan oleh seperangkat sifat atau karakteristik pribadi yang dimiliki individu. Sifat tersebut meliputi kecerdasan,

kepercayaan diri, integritas, tanggung jawab, stabilitas emosional, keberanian dalam mengambil keputusan, kemampuan komunikasi, serta orientasi yang kuat terhadap tujuan. Teori ini berasumsi bahwa pemimpin berbeda dari individu pada umumnya karena memiliki kombinasi sifat unggul yang relatif konsisten dan berpengaruh terhadap gaya kepemimpinan serta keberhasilan dalam memengaruhi orang lain (Nichols et al., 2025).

Dalam perspektif manajemen modern, teori sifat banyak dimanfaatkan untuk mengidentifikasi, menyeleksi, dan mengembangkan calon pemimpin melalui pengamatan dan pengukuran sifat pribadi. Walaupun teori ini tidak sepenuhnya menekankan peran pelatihan, teori sifat tetap memiliki relevansi penting karena membantu organisasi memahami karakter dasar yang dibutuhkan untuk mewujudkan kepemimpinan yang efektif. Oleh karena itu, teori ini menjadi landasan bagi berbagai model evaluasi kepemimpinan dan pengembangan sumber daya manusia, baik pada organisasi pendidikan, pemerintahan, maupun pelayanan kesehatan.

Contoh penerapan teori sifat dapat dilihat dalam proses rekrutmen kepala ruangan atau manajer keperawatan di rumah sakit. Calon pemimpin tidak hanya dinilai berdasarkan kompetensi teknis, tetapi juga dievaluasi sifat-sifat kepemimpinannya, seperti integritas, stabilitas emosional, kemampuan komunikasi, ketegasan, empati, serta tanggung jawab moral. Individu yang memiliki sifat kepemimpinan kuat cenderung mampu membangun kepercayaan tim, mengambil keputusan secara tepat, menjaga iklim kerja yang kondusif, serta meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

### 3. Teori Perilaku (*Behavioral Theory*)

Teori Perilaku (*Behavioral Theory*) menjelaskan bahwa kepemimpinan tidak semata-mata ditentukan oleh sifat bawaan, tetapi dapat dipelajari melalui pembentukan perilaku. Teori ini menekankan bahwa perilaku pemimpin yang tampak dalam tindakan sehari-hari, seperti cara memimpin, berkomunikasi, mengambil keputusan, dan membangun hubungan kerja, merupakan faktor utama yang menentukan efektivitas kepemimpinan. Dengan demikian, seseorang dapat menjadi pemimpin yang efektif apabila mampu mempelajari dan menerapkan perilaku kepemimpinan yang tepat sesuai tuntutan organisasi (Dr. Ahmad Azmy, 2021).

Dalam pengembangannya, teori perilaku memperkenalkan beberapa pendekatan penting, antara lain hasil studi Ohio State University yang mengemukakan dua dimensi utama kepemimpinan, yaitu *consideration* (perhatian pada hubungan manusia) dan *initiating structure* (penekanan pada struktur tugas). Selain itu, studi Michigan membedakan pemimpin menjadi *employee-centered leadership* dan *production-centered leadership*, sedangkan Rensis Likert memperkenalkan sistem kepemimpinan mulai dari otoriter hingga partisipatif. Keseluruhan konsep ini menegaskan bahwa perilaku pemimpin dapat dikaji, dievaluasi, dan dibentuk melalui pendidikan, pelatihan, serta pengalaman manajerial.

Contoh penerapan teori perilaku dalam manajemen keperawatan dapat dilihat pada peran kepala ruangan dalam mengelola tim. Seorang kepala ruangan yang menunjukkan perilaku *consideration* akan memberikan dukungan emosional, membangun komunikasi yang baik, serta memperhatikan kesejahteraan perawat. Pada saat yang sama, ia juga menerapkan *initiating structure* dengan menetapkan prosedur kerja yang jelas, membagi tugas secara sistematis, dan memastikan standar

pelayanan dipatuhi. Kombinasi perilaku tersebut akan menciptakan kinerja tim yang optimal, meningkatkan kepuasan kerja perawat, dan berdampak pada peningkatan mutu pelayanan serta keselamatan pasien.

#### **4. Teori Kontingensi (*Contingency Theory*)**

Teori Kontingensi (*Contingency Theory*) menjelaskan bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang paling efektif untuk semua situasi organisasi. Efektivitas kepemimpinan bergantung pada kesesuaian antara gaya memimpin dengan kondisi lingkungan kerja, karakteristik bawahan, jenis tugas, serta struktur organisasi. Teori ini menekankan bahwa pemimpin perlu memahami konteks situasional sebelum menentukan pendekatan kepemimpinan yang akan digunakan, sehingga kepemimpinan tidak bersifat kaku, tetapi adaptif dan responsif terhadap dinamika organisasi (Gillies, 1989).

Salah satu model yang paling dikenal dalam teori ini adalah model kontingensi yang dikemukakan oleh Fred Fiedler. Dalam model tersebut, efektivitas pemimpin dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu hubungan pemimpin dengan anggota, struktur tugas, dan kekuasaan posisi. Berdasarkan variabel tersebut, gaya kepemimpinan dapat bersifat tugas (*task-oriented*) atau hubungan (*relationship-oriented*), dan pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya sesuai kebutuhan situasi yang dihadapi.

Contoh penerapan teori kontingensi dalam manajemen keperawatan dapat dilihat pada situasi kerja di rumah sakit. Pada kondisi krisis atau keadaan gawat darurat, kepala ruangan atau manajer keperawatan perlu menerapkan gaya kepemimpinan yang lebih direktif dan berorientasi pada tugas agar keputusan dapat diambil cepat dan tepat. Namun, pada situasi kerja yang stabil



dan tim memiliki kompetensi baik, pemimpin dapat menggunakan gaya kepemimpinan yang lebih partisipatif dan berorientasi pada hubungan untuk meningkatkan motivasi, kolaborasi, serta kepuasan kerja perawat. Dengan demikian, teori kontingensi membantu pemimpin memilih gaya yang paling sesuai dengan tuntutan situasi untuk mencapai efektivitas organisasi.

## **5. Teori Jalur Tujuan (*Path-Goal Theory*)**

Teori ini menjelaskan bahwa tugas utama pemimpin adalah membantu bawahan dalam mencapai tujuan organisasi dengan cara memperjelas jalur yang harus ditempuh, menghilangkan hambatan yang mungkin timbul, serta memberikan dukungan yang diperlukan. Pemimpin berperan sebagai fasilitator yang memastikan bawahan memahami tujuan kerja, mengetahui langkah yang harus dilakukan, serta merasa termotivasi untuk mencapai hasil yang diharapkan. Dengan demikian, keberhasilan kepemimpinan dalam teori ini diukur dari sejauh mana pemimpin mampu meningkatkan motivasi, kepuasan kerja, dan kinerja bawahan.

Menurut Robert House sebagai penggagas teori ini, terdapat beberapa gaya kepemimpinan yang dapat diterapkan sesuai kebutuhan situasi, yaitu *directive leadership*, *supportive leadership*, *participative leadership*, dan *achievement-oriented leadership*. Gaya direktif digunakan ketika bawahan membutuhkan arahan yang jelas terhadap tugas; gaya suportif diterapkan untuk memberikan dukungan emosional dan meningkatkan kenyamanan kerja; gaya partisipatif digunakan ketika bawahan perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan; sedangkan gaya berorientasi prestasi diterapkan untuk mendorong bawahan mencapai standar kinerja yang lebih tinggi. Fleksibilitas dalam memilih gaya kepemimpinan menjadi inti dari teori ini (Gillies, 1989)

Contoh penerapan teori jalur–tujuan dalam manajemen keperawatan dapat dilihat pada peran kepala ruangan dalam memimpin tim keperawatan di rumah sakit. Pada kondisi kerja dengan tugas yang kompleks dan membutuhkan kejelasan, kepala ruangan dapat menggunakan gaya kepemimpinan direktif dengan memberikan instruksi yang sistematis dan prosedural. Pada saat yang sama, ia juga dapat menerapkan gaya suportif untuk meningkatkan kenyamanan psikologis perawat, serta gaya partisipatif ketika diperlukan masukan dalam penyusunan kebijakan pelayanan. Melalui kombinasi gaya kepemimpinan yang tepat, pemimpin mampu meningkatkan motivasi kerja, memperkuat kerjasama tim, dan memastikan mutu pelayanan serta keselamatan pasien tetap terjaga.

## **6. Teori Kepemimpinan Transformasional (Transformational Theory)**

Teori Kepemimpinan Transformasional (*Transformational Leadership Theory*) menjelaskan bahwa pemimpin tidak hanya berfokus pada pencapaian target operasional, tetapi juga bertujuan mengubah, menginspirasi, dan memberdayakan bawahan untuk mencapai kinerja yang lebih tinggi. Pemimpin transformasional membangun visi masa depan yang jelas, menumbuhkan motivasi, memperkuat nilai, serta meningkatkan komitmen organisasi. Dalam teori ini, kepemimpinan dipahami sebagai proses yang mampu membangkitkan semangat perubahan positif melalui keteladanan, inspirasi, dan hubungan emosional yang kuat antara pemimpin dan pengikut.

Menurut Burns dan Bass (2006) kepemimpinan transformasional memiliki empat dimensi utama, yaitu *idealized influence*, *inspirational motivation*, *intellectual stimulation*, dan *individualized consideration*.

*Idealized influence* menggambarkan pemimpin sebagai teladan yang berintegritas; *inspirational motivation* berkaitan dengan kemampuan memberikan inspirasi dan harapan; *intellectual stimulation* mendorong pengikut berpikir kritis dan inovatif; sedangkan *individualized consideration* menekankan perhatian terhadap kebutuhan, potensi, dan pengembangan individu. Keempat dimensi ini menjadikan kepemimpinan transformasional berperan penting dalam membangun budaya organisasi yang visioner, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan mutu.

Contoh penerapan kepemimpinan transformasional dalam manajemen keperawatan dapat dilihat pada peran kepala ruangan atau manajer keperawatan yang tidak hanya mengawasi pelaksanaan tugas, tetapi juga menginspirasi perawat untuk memberikan pelayanan terbaik. Pemimpin memberikan visi tentang mutu pelayanan dan keselamatan pasien, membuka ruang inovasi dalam praktik keperawatan, memberikan bimbingan, serta memperhatikan kesejahteraan dan pengembangan profesional perawat. Melalui pendekatan ini, terjadi peningkatan motivasi kerja, kepuasan profesi, kolaborasi tim, serta perbaikan mutu pelayanan kesehatan secara berkelanjutan.

## **7. Teori Kepemimpinan Pelayan (*Servant Theory*)**

Teori Kepemimpinan Pelayan (*Servant Leadership Theory*) menjelaskan bahwa pemimpin pada hakikatnya adalah pelayan bagi orang yang dipimpinnya. Pemimpin mendahulukan kebutuhan, kesejahteraan, dan perkembangan bawahan sebelum memikirkan kepentingan pribadi atau jabatan. Kepemimpinan menurut teori ini menekankan nilai kemanusiaan, empati, kepedulian, keadilan, dan tanggung jawab moral. Dengan pendekatan tersebut, pemimpin tidak hanya mengarahkan, tetapi juga menghadirkan makna,

ketulusan, dan dukungan yang memungkinkan anggota organisasi berkembang secara optimal (Gillies, 1989).

Dalam teori ini, pemimpin pelayan berfokus pada pengembangan manusia, pemberdayaan, serta penciptaan lingkungan kerja yang suportif dan etis. Pemimpin berperan sebagai fasilitator, pendamping, dan teladan dalam praktik nilai-nilai kemanusiaan di organisasi. Pendekatan ini tidak hanya membangun hubungan kerja yang harmonis, tetapi juga meningkatkan komitmen, loyalitas, kepercayaan, dan motivasi bawahan. Dengan demikian, kepemimpinan pelayan berkontribusi pada terbentuknya budaya organisasi yang inklusif, kolaboratif, dan berorientasi pada pelayanan yang bermakna.

Contoh penerapan kepemimpinan pelayan dalam manajemen keperawatan dapat dilihat pada perilaku kepala ruangan atau manajer keperawatan yang menempatkan kesejahteraan tim sebagai prioritas. Pemimpin secara aktif mendengarkan kebutuhan perawat, memberikan dukungan emosional, memperjuangkan fasilitas kerja yang layak, memastikan keadilan beban kerja, serta mendorong pengembangan kompetensi profesional. Sikap ini menciptakan suasana kerja yang positif, meningkatkan motivasi dan rasa memiliki, serta berdampak pada peningkatan mutu asuhan keperawatan dan keselamatan.

## **8. Teori Kepemimpinan Transaksional (*Transactional Theory*)**

Teori Kepemimpinan Transaksional (*Transactional Leadership Theory*) menjelaskan bahwa hubungan antara pemimpin dan bawahan didasarkan pada pertukaran (transaksi) yang bersifat formal dan fungsional. Pemimpin memberikan penghargaan kepada bawahan yang mampu memenuhi standar kinerja dan target organisasi,

serta memberikan sanksi bagi yang tidak patuh. Kepemimpinan ini menekankan kepatuhan terhadap aturan, struktur organisasi, kejelasan tugas, dan pengawasan yang sistematis. Dengan demikian, keberhasilan kepemimpinan transaksional diukur melalui pencapaian tujuan operasional, kedisiplinan, dan stabilitas kerja (Gillies, 1989).

Dalam perspektif manajemen modern, kepemimpinan transaksional memiliki peran penting dalam organisasi yang memerlukan keteraturan, efisiensi, dan kepastian prosedur. Pemimpin bertindak sebagai pengontrol dan pengarah pelaksanaan tugas berdasarkan regulasi yang berlaku. Pendekatan ini efektif diterapkan pada situasi yang membutuhkan ketegasan, kejelasan instruksi, dan hasil kerja yang terukur. Walaupun tidak berfokus pada transformasi nilai atau perubahan budaya organisasi, kepemimpinan transaksional tetap relevan karena memastikan organisasi berjalan secara tertib, terstruktur, dan sesuai standar.

Contoh penerapan kepemimpinan transaksional dalam manajemen keperawatan dapat dilihat pada peran kepala ruangan atau manajer keperawatan dalam mengatur pelaksanaan tugas klinis. Pemimpin menetapkan target pelayanan, memastikan kepatuhan terhadap standar prosedur operasional, memberikan penghargaan bagi perawat yang berkinerja baik, serta memberikan teguran atau sanksi bagi pelanggaran disiplin. Pada situasi darurat atau pelayanan yang menuntut ketepatan prosedur, gaya kepemimpinan ini membantu menjaga kedisiplinan tim, meningkatkan kinerja, memastikan keselamatan pasien, serta mempertahankan mutu pelayanan keperawatan.

## **C. Gaya Kepemimpinan, Perbedaan dan Penggunaannya**

Gaya kepemimpinan merupakan pola perilaku yang ditunjukkan pemimpin dalam memengaruhi, mengarahkan, serta berinteraksi dengan bawahan. Gaya kepemimpinan tidak hanya menggambarkan cara pemimpin mengambil keputusan, tetapi juga mencerminkan cara pemimpin membangun komunikasi, memberikan motivasi, mengelola konflik, serta mengatur pelaksanaan tugas. Setiap gaya kepemimpinan memiliki karakteristik, kelebihan, dan keterbatasan tersendiri sehingga pemimpin perlu memahami perbedaan di antara berbagai gaya kepemimpinan yang ada. Pemahaman ini penting agar pemimpin mampu memilih pendekatan yang tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi dan karakteristik sumber daya manusia yang dipimpinnya.

Menurut Supervisi (2011) secara umum, gaya kepemimpinan dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk utama, antara lain:

1. **Kepemimpinan otoriter**

Kepemimpinan otoriter menekankan pengendalian penuh dari pemimpin dan cocok digunakan pada situasi yang membutuhkan keputusan cepat dan kepatuhan tinggi.

2. **Demokratis dan partisipatif**

Kepemimpinan demokratis dan partisipatif menekankan keterlibatan bawahan dalam proses pengambilan keputusan sehingga mampu meningkatkan rasa memiliki, motivasi, dan kerja sama tim.

3. **Transaksional**

Kepemimpinan transaksional berfokus pada pengaturan tugas melalui sistem penghargaan dan sanksi.

#### 4. Transformasional

Kepemimpinan transformasional berorientasi pada inspirasi, perubahan, dan pengembangan sumber daya manusia.

#### 5. Situasional

Kepemimpinan situasional menekankan fleksibilitas pemimpin sesuai tingkat kesiapan bawahan.

#### 6. Kepemimpinan pelayan

Kepemimpinan pelayan menempatkan kesejahteraan serta kebutuhan bawahan sebagai prioritas utama.

Penggunaan gaya kepemimpinan harus disesuaikan dengan kondisi organisasi, kompleksitas tugas, tingkat kedewasaan bawahan, budaya kerja, serta tuntutan situasi. Pada kondisi darurat atau situasi yang membutuhkan keputusan cepat, gaya kepemimpinan otoriter atau direktif lebih efektif diterapkan. Pada situasi kerja yang stabil dan tim memiliki kompetensi baik, gaya kepemimpinan demokratis, partisipatif, atau transformasional lebih sesuai untuk meningkatkan kreativitas, komitmen, dan kepuasan kerja. Dalam konteks manajemen keperawatan, kepala ruangan atau manajer keperawatan perlu menerapkan gaya kepemimpinan yang adaptif: direktif saat kondisi gawat darurat, transaksional untuk memastikan kepatuhan prosedur, dan transformasional atau pelayan untuk membangun motivasi, kolaborasi, serta peningkatan mutu pelayanan (Cuya, 2022). Dengan kemampuan memilih dan menggunakan gaya kepemimpinan yang tepat, pemimpin dapat mencapai efektivitas organisasi secara optimal.

## D. Latihan

Latihan ini bertujuan untuk menguji pemahaman, kemampuan analisis, serta penerapan konsep teori manajemen dan kepemimpinan dalam konteks pelayanan keperawatan. Kerjakan setiap soal secara cermat sesuai dengan materi yang telah dipelajari. Bentuk latihan meliputi soal pilihan ganda dan esai analitis. Melalui latihan ini, diharapkan mahasiswa mampu mengidentifikasi konsep kunci, membedakan berbagai teori dan gaya kepemimpinan, serta mengaplikasikannya secara tepat dalam praktik manajemen keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan.

### Soal Kasus Pilihan Ganda

1. Seorang kepala ruangan menghadapi kondisi kekurangan perawat pada shift malam, sementara jumlah pasien meningkat. Kepala ruangan kemudian melakukan penyesuaian jadwal dan redistribusi tugas berdasarkan kompetensi perawat.  
Fungsi manajemen yang dominan dilakukan adalah ...  
A. Perencanaan  
B. Pengorganisasian  
C. Pengarahan  
D. Pengawasan  
E. Evaluasi
2. Seorang kepala ruangan menemukan bahwa pembagian tugas perawat tidak seimbang sehingga beberapa perawat mengalami kelelahan kerja. Kepala ruangan kemudian menyusun ulang jadwal dinas dan pembagian pasien berdasarkan tingkat ketergantungan pasien.  
Fungsi manajemen yang dominan dilakukan adalah ...  
A. Perencanaan  
B. Pengorganisasian  
C. Pengarahan  
D. Pengawasan  
E. Evaluasi



3. Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan, kepala ruangan secara rutin melakukan supervisi dan memberikan umpan balik langsung kepada perawat pelaksana. Tindakan tersebut merupakan penerapan fungsi manajemen ...
- A. Perencanaan
  - B. Pengorganisasian
  - C. Pengarahan
  - D. Pengawasan
  - E. Koordinasi
4. Seorang manajer keperawatan melibatkan perawat pelaksana dalam pengambilan keputusan terkait perubahan alur pelayanan keperawatan. Gaya kepemimpinan yang diterapkan adalah ...
- A. Otoriter
  - B. Demokratis
  - C. Transaksional
  - D. Laissez-faire
  - E. Autokratis
5. Di sebuah ruang rawat inap terjadi konflik antar perawat yang berdampak pada komunikasi tim. Kepala ruangan memfasilitasi diskusi terbuka dan mendorong setiap perawat menyampaikan pendapatnya untuk mencapai kesepakatan bersama. Pendekatan kepemimpinan yang paling tepat adalah ...
- A. Otoriter
  - B. Demokratis
  - C. Transaksional
  - D. Laissez-faire
  - E. Karismatik
6. Manajer keperawatan memberikan penghargaan kepada perawat yang mencapai target kinerja dan memberikan sanksi kepada perawat yang melanggar aturan. Pendekatan kepemimpinan yang diterapkan adalah ...
- A. Transformasional
  - B. Visioner
  - C. Transaksional
  - D. Situasional
  - E. Partisipatif

7. Pada awal shift, kepala ruangan melakukan briefing untuk menjelaskan kondisi pasien, pembagian tugas, dan target pelayanan hari itu. Fungsi manajemen yang dilakukan adalah ...
- A. Perencanaan
  - B. Pengorganisasian
  - C. Pengarahan
  - D. Pengawasan
  - E. Evaluasi
8. Dalam evaluasi bulanan, manajer keperawatan menggunakan indikator mutu untuk menilai kepatuhan perawat terhadap SPO dan merencanakan tindak lanjut perbaikan. Kegiatan ini mencerminkan fungsi ...
- A. Perencanaan dan pengorganisasian
  - B. Pengarahan dan koordinasi
  - C. Pengawasan dan evaluasi
  - D. Perencanaan dan pengarahan
  - E. Pengorganisasian dan supervisi
9. Seorang kepala ruangan menghadapi perawat baru dengan pengalaman kerja yang masih terbatas. Kepala ruangan memberikan instruksi yang jelas, pendampingan intensif, dan pengawasan ketat. Gaya kepemimpinan yang paling sesuai adalah ...
- A. Demokratis
  - B. Laissez-faire
  - C. Transformasional
  - D. Situasional
  - E. Partisipatif
10. Dalam penerapan manajemen keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan, tanggung jawab utama manajer keperawatan adalah ...
- A. Melaksanakan seluruh tindakan keperawatan secara langsung
  - B. Menentukan diagnosis medis pasien
  - C. Mengelola sumber daya keperawatan untuk menjamin mutu dan keselamatan pasien
  - D. Menggantikan peran pimpinan rumah sakit
  - E. Mengawasi seluruh tindakan medis dokter

### Soal Esai Analitik

Sebutkan dua tanggung jawab utama manajer keperawatan dalam menjaga mutu pelayanan di ruang rawat inap.

### Kunci Jawaban Soal Pilihan Ganda

- |      |       |
|------|-------|
| 1. B | 6. C  |
| 2. B | 7. C  |
| 3. D | 8. C  |
| 4. B | 9. D  |
| 5. B | 10. C |

## E. Rangkuman Materi

Teori manajemen dan teori kepemimpinan merupakan landasan konseptual yang penting dalam pengelolaan pelayanan keperawatan. Teori manajemen berfokus pada proses sistematis dalam mencapai tujuan organisasi melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya secara efektif dan efisien. Sementara itu, teori kepemimpinan menekankan kemampuan individu dalam memengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Pemahaman terhadap kedua teori ini membantu perawat, khususnya perawat profesional, dalam menjalankan peran manajerial dan kepemimpinan secara tepat sesuai dengan tuntutan organisasi pelayanan kesehatan.

Fungsi dan prinsip manajemen keperawatan menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas manajer keperawatan di unit pelayanan. Fungsi manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan yang dilaksanakan secara berkesinambungan untuk menjamin mutu asuhan keperawatan. Prinsip manajemen, seperti pembagian tugas, kesatuan perintah, dan koordinasi, mendukung terciptanya kerja tim yang efektif. Dalam hal ini, manajer keperawatan memiliki peran dan tanggung jawab

untuk mengelola sumber daya manusia, sarana prasarana, serta lingkungan kerja guna mendukung keselamatan pasien dan pencapaian tujuan organisasi.

Gaya kepemimpinan menggambarkan pola perilaku pemimpin dalam berinteraksi dengan staf dan mengambil keputusan. Berbagai gaya kepemimpinan, seperti otoriter, demokratis, transaksional, dan transformasional, memiliki karakteristik dan keunggulan masing-masing. Pemilihan gaya kepemimpinan perlu disesuaikan dengan situasi, tingkat kompetensi staf, serta kondisi lingkungan kerja. Dengan penerapan gaya kepemimpinan yang tepat, pemimpin keperawatan dapat meningkatkan motivasi, kinerja, dan kepuasan kerja perawat, sehingga berdampak positif terhadap mutu pelayanan keperawatan.

Penerapan teori kepemimpinan dan manajemen di fasilitas pelayanan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan dan menjamin mutu asuhan keperawatan. Integrasi antara fungsi manajemen dan gaya kepemimpinan yang sesuai memungkinkan terciptanya koordinasi yang baik, pengambilan keputusan yang tepat, serta pengelolaan sumber daya yang optimal. Oleh karena itu, penguasaan teori manajemen dan kepemimpinan menjadi kompetensi penting bagi perawat dalam menghadapi kompleksitas pelayanan kesehatan dan tuntutan profesionalisme di era pelayanan kesehatan modern.

## **Glosarium**

|     |                                         |
|-----|-----------------------------------------|
| CQI | : <i>Continuous Quality Improvement</i> |
| TQM | : <i>Total Quality Management</i>       |

# BAB 2

## Fungsi Manajemen

### Pendahuluan

Bab ini membahas fungsi-fungsi manajemen sebagai fondasi utama dalam pengelolaan pelayanan keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya di unit ruang rawat. Fungsi manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, manajemen ketenagaan, pengarahan, dan pengendalian yang dilaksanakan secara sistematis untuk menjamin efektivitas, efisiensi, mutu, dan keselamatan pasien. Pemahaman yang komprehensif terhadap fungsi manajemen menjadi kompetensi esensial bagi perawat, terutama dalam menjalankan peran profesional sebagai pelaksana asuhan, koordinator pelayanan, dan manajer keperawatan di tingkat unit (Kozier, 2004).

Bab ini disusun dengan tujuan membekali pembaca kemampuan konseptual dan aplikatif dalam menerapkan fungsi manajemen keperawatan secara nyata di ruang rawat. Pembahasan diawali dengan manajemen perencanaan, termasuk penyusunan rencana operasional unit (Renop), dilanjutkan dengan manajemen pengorganisasian melalui pengembangan struktur organisasi dan metode pemberian asuhan keperawatan. Selanjutnya, bab ini menguraikan manajemen ketenagaan yang mencakup perhitungan kebutuhan perawat, pola ketenagaan, serta penyusunan jadwal penugasan.

Fungsi pengarahan dan pengendalian juga dibahas secara terintegrasi dengan supervisi manajemen, penerapan Evidence-Based Nursing Practice (EBNP), serta analisis mutu pelayanan keperawatan sesuai standar. Sasaran pembaca bab ini adalah mahasiswa keperawatan, mahasiswa profesi Ners, dosen, serta praktisi keperawatan yang menjalankan fungsi manajerial di fasilitas pelayanan kesehatan. Materi disajikan secara sistematis dan

terstruktur, mengintegrasikan konsep teoritis, prinsip manajemen, dan contoh aplikatif yang relevan dengan praktik keperawatan di ruang rawat. Penyusunan bab ini mengacu pada capaian pembelajaran mata kuliah dan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana diamanatkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi, sehingga mendukung proses pembelajaran akademik dan praktik profesional secara berkesinambungan.

Pendekatan pembelajaran dalam bab ini dirancang untuk mendorong pembelajaran aktif dan kontekstual melalui uraian materi, ilustrasi penerapan di lapangan, latihan, serta analisis kasus. Pembaca dianjurkan mempelajari bab ini secara berurutan, mencermati setiap konsep kunci, dan mengaitkannya dengan pengalaman praktik atau simulasi manajerial di ruang rawat. Dengan pendekatan tersebut, Bab 2 diharapkan menjadi pedoman konseptual dan praktis dalam membentuk kemampuan perawat yang kompeten dalam menerapkan fungsi manajemen keperawatan secara profesional, bertanggung jawab, dan berorientasi pada mutu pelayanan.

Manajemen keperawatan merupakan proses sistematis yang diterapkan dalam pengelolaan pelayanan keperawatan guna mencapai tujuan organisasi pelayanan kesehatan secara efektif dan efisien. Pelayanan keperawatan yang bermutu menuntut adanya pengelolaan sumber daya manusia, sarana, dan proses asuhan keperawatan yang terencana, terorganisasi, terarah, dan terkontrol. Oleh karena itu, pemahaman terhadap fungsi manajemen keperawatan menjadi landasan utama bagi perawat, khususnya perawat manajer, dalam menjamin terselenggaranya asuhan keperawatan yang aman, bermutu, dan berorientasi pada kebutuhan pasien.

Fungsi manajemen keperawatan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang saling berkaitan dan berlangsung secara berkesinambungan. Setiap fungsi memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa pelayanan keperawatan berjalan sesuai dengan standar profesi, kebijakan organisasi, serta prinsip keselamatan pasien. Penerapan fungsi manajemen yang tepat memungkinkan perawat manajer mengoptimalkan kinerja tim keperawatan, meningkatkan koordinasi antarprofesi, serta meminimalkan risiko terjadinya masalah dalam pelayanan keperawatan.

Pembahasan fungsi manajemen keperawatan dalam buku ajar ini bertujuan untuk memberikan pemahaman konseptual dan aplikatif kepada mahasiswa dan praktisi keperawatan. Pemahaman tersebut diharapkan mampu meningkatkan kompetensi manajerial perawat dalam mengelola pelayanan keperawatan secara profesional, akuntabel, dan berkelanjutan, sehingga berdampak pada peningkatan mutu asuhan keperawatan dan pencapaian tujuan pelayanan kesehatan secara menyeluruh.

## **CPMK dan Sub-CPMK**

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) pada bab ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan fungsi manajemen dengan menekankan pada manajemen perencanaan serta mampu menyusun rencana operasional unit ruang rawat secara sistematis, rasional, dan aplikatif dalam konteks manajemen asuhan keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Adapun Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK) dirumuskan sebagai berikut:

1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, tujuan, pendekatan, prinsip, pentingnya perencanaan, dan nature of planning dalam manajemen keperawatan.
2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan komponen-komponen perencanaan dalam pengelolaan unit ruang rawat.
3. Mahasiswa mampu menganalisis dan membedakan jenis-jenis perencanaan dalam manajemen keperawatan.
4. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan tahapan proses perencanaan manajemen keperawatan secara sistematis.
5. Mahasiswa mampu menerapkan konsep perencanaan dalam penyusunan rencana operasional (Renop) manajemen asuhan keperawatan di ruang rawat fasilitas pelayanan kesehatan.

Untuk mendukung pencapaian CPMK dan Sub-CPMK tersebut, berikut disajikan petunjuk pembelajaran yang perlu diperhatikan agar mahasiswa dapat menguasai materi yang dibahas dalam bab ini secara optimal.

- Mahasiswa membaca dan memahami CPMK, Sub-CPMK, serta pendahuluan sebagai acuan pembelajaran.
- Mahasiswa membaca materi pokok pembelajaran secara sistematis dan cermat.
- Mahasiswa mencermati konsep utama, istilah kunci, dan definisi penting fungsi manajemen.

- Mahasiswa mengaitkan materi dengan penerapan fungsi manajemen dalam praktik profesional.
- Mahasiswa melakukan diskusi untuk memperdalam pemahaman dan berpikir kritis.
- Mahasiswa mengerjakan tugas, latihan, atau refleksi pada akhir bab.
- Mahasiswa memanfaatkan sumber belajar tambahan yang relevan.



# Uraian Materi

---

## A. Manajemen Perencanaan dan Menyusun Rencana Operasional Unit Ruang Rawat

### 1. Konsep Dasar Perencanaan dan *Nature of Planning*

Perencanaan merupakan proses awal dalam fungsi manajemen yang berperan menentukan arah, strategi, dan langkah yang akan dilakukan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan disusun melalui tahapan sistematis mulai dari pengumpulan data, identifikasi masalah, analisis kebutuhan, penentuan prioritas, hingga penyusunan langkah operasional. Dalam manajemen keperawatan, perencanaan menjadi dasar bagi pelaksanaan kegiatan pelayanan, pengelolaan sumber daya manusia, optimalisasi sarana dan prasarana, serta penjaminan mutu pelayanan. Perencanaan yang baik memastikan setiap aktivitas pelayanan berjalan efektif, efisien, dan terukur.

Tujuan utama perencanaan adalah memberikan arah kerja yang jelas, meningkatkan koordinasi, mengurangi ketidakpastian, serta membantu pemimpin dalam mengambil keputusan rasional. Perencanaan memungkinkan organisasi untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan, meminimalkan risiko, serta menyiapkan strategi mitigasi terhadap kendala yang mungkin terjadi. Pendekatan perencanaan dapat dilakukan melalui pendekatan rasional, pendekatan partisipatif, pendekatan berbasis kebutuhan, serta pendekatan berbasis data dan bukti (*evidence-based planning*). Pemilihan pendekatan dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik organisasi, sumber daya yang tersedia, serta kondisi lingkungan kerja.

Perencanaan memiliki prinsip-prinsip penting yang harus diperhatikan, antara lain realistis, sistematis, fleksibel, relevan, berbasis prioritas, dapat diukur, serta terdokumentasi dengan baik. Perencanaan dianggap penting karena merupakan fondasi bagi pelaksanaan fungsi manajemen lainnya seperti pengorganisasian, pengarahan, serta pengawasan. Dalam *nature of planning*, perencanaan dipahami sebagai proses yang bersifat berkelanjutan, dinamis, dan adaptif. Artinya, perencanaan tidak berhenti setelah disusun, tetapi perlu dievaluasi, diperbarui, dan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan organisasi dan perubahan lingkungan pelayanan kesehatan.

## **2. Komponen Perencanaan**

Perencanaan terdiri atas beberapa komponen penting yang saling berkaitan. Komponen tersebut meliputi penetapan visi dan tujuan, identifikasi masalah, analisis kebutuhan, penentuan prioritas, penyusunan strategi, perumusan program kerja, penentuan sumber daya, penjadwalan kegiatan, serta mekanisme evaluasi. Tujuan perencanaan harus dirumuskan secara spesifik, jelas, realistis, terukur, relevan, dan memiliki kerangka waktu yang jelas (Nursalam, 2002). Dengan tujuan yang jelas, setiap kegiatan yang dilaksanakan akan terarah dan memiliki indikator keberhasilan yang konkret.

Komponen selanjutnya adalah strategi dan program kerja yang berfungsi sebagai penerjemah tujuan menjadi tindakan operasional. Pada tahap ini ditentukan jenis kegiatan yang akan dilakukan, langkah-langkah pelaksanaan, pembagian tugas, kebutuhan tenaga, sarana, alat kesehatan, serta alokasi anggaran. Setiap kegiatan juga harus didukung dengan SOP, standar mutu, serta panduan pelaksanaan agar proses berjalan konsisten dengan standar organisasi dan kebijakan

pelayanan kesehatan yang berlaku. Dengan demikian, setiap anggota tim memahami perannya dan bekerja sesuai tanggung jawab masing-masing.

Komponen lain yang tidak kalah penting adalah penjadwalan dan evaluasi. Penjadwalan yang baik memastikan kegiatan berjalan sesuai alur waktu yang ditetapkan dan tidak tumpang tindih. Sementara itu, evaluasi disiapkan sejak tahap perencanaan melalui penetapan indikator keberhasilan yang jelas. Evaluasi bertujuan menilai tingkat ketercapaian tujuan, mengidentifikasi kendala, serta memberikan umpan balik bagi peningkatan mutu perencanaan berikutnya. Dengan adanya komponen-komponen tersebut, perencanaan dapat dilaksanakan secara sistematis, efektif, dan akuntabel.

### **3. Jenis Perencanaan**

Jenis perencanaan dapat diklasifikasikan berdasarkan jangka waktu, tingkat pengambilan keputusan, serta lingkup kegiatan. Berdasarkan jangka waktu, perencanaan terdiri atas perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka panjang biasanya berorientasi pada visi strategis organisasi, mencakup pengembangan pelayanan, kebijakan besar, serta arah masa depan organisasi. Perencanaan jangka menengah mendukung pelaksanaan strategi tersebut, sedangkan perencanaan jangka pendek bersifat operasional untuk memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai sasaran yang telah ditentukan.

Berdasarkan tingkat kewenangan, perencanaan dibagi menjadi perencanaan strategis, taktis, dan operasional. Perencanaan strategis disusun oleh manajemen puncak untuk menentukan arah kebijakan organisasi. Perencanaan taktis disusun oleh manajemen menengah

untuk menjabarkan kebijakan strategis ke dalam rencana kerja yang lebih teknis. Sementara itu, perencanaan operasional disusun oleh manajemen pelaksana untuk memastikan kegiatan sehari-hari berlangsung efektif. Ketiga level perencanaan ini saling berkaitan dan membentuk kesinambungan dalam pelaksanaan fungsi organisasi.

Berdasarkan lingkup kegiatan, jenis perencanaan dapat meliputi perencanaan pelayanan klinis, perencanaan administrasi, perencanaan sumber daya manusia, perencanaan keuangan, perencanaan logistik, serta perencanaan mutu dan keselamatan pasien. Dalam manajemen keperawatan, seluruh perencanaan ini harus terintegrasi karena berpengaruh langsung terhadap pelayanan asuhan keperawatan. Dengan pemahaman yang baik mengenai jenis-jenis perencanaan, pemimpin keperawatan mampu memilih dan menyusun perencanaan yang paling sesuai dengan kebutuhan unit pelayanan.

#### **4. Proses Perencanaan**

Proses perencanaan dimulai dengan kegiatan pengumpulan data dan analisis situasi. Tahap ini meliputi pengkajian kondisi unit, identifikasi masalah, analisis kebutuhan pasien, pemetaan sumber daya, serta penilaian kemampuan organisasi. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan ilmiah untuk memastikan perencanaan disusun berdasarkan fakta dan bukan asumsi. Hasil analisis situasi akan menentukan prioritas masalah yang harus ditangani melalui perencanaan.

Tahap selanjutnya adalah penetapan tujuan, penyusunan alternatif strategi, dan pemilihan strategi terbaik. Tujuan ditetapkan secara jelas agar mudah diukur tingkat pencapaiannya. Alternatif strategi disusun untuk memberikan berbagai pilihan tindakan yang

memungkinkan organisasi mencapai tujuan yang diinginkan. Setelah strategi dipilih, disusunlah rencana operasional yang lebih rinci, yang meliputi program kerja, langkah pelaksanaan, pembagian tugas, penjadwalan, serta kebutuhan sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan anggaran.

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. Pada tahap pelaksanaan, rencana dijalankan sesuai jadwal dan prosedur yang telah disusun. Pengendalian dilakukan untuk memastikan pelaksanaan berjalan sesuai rencana, serta mendeteksi bila terjadi penyimpangan. Evaluasi dilaksanakan untuk menilai ketercapaian tujuan, efektivitas program, serta memberikan rekomendasi perbaikan. Dengan proses perencanaan yang terstruktur, organisasi memiliki arah kerja yang jelas dan mampu mencapai tujuan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

## **5. Perencanaan dalam Manajemen Asuhan Keperawatan di Ruang Rawat Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Renop)**

Perencanaan dalam manajemen asuhan keperawatan di ruang rawat merupakan bagian integral dari pengelolaan pelayanan keperawatan profesional. Rencana operasional (Renop) disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pelayanan harian, bulanan, dan tahunan yang meliputi pengaturan tenaga keperawatan, pembagian tugas, penataan beban kerja, penyediaan sarana prasarana, serta penjaminan mutu pelayanan. Renop membantu kepala ruangan dan manajer keperawatan memastikan seluruh kegiatan pelayanan berjalan terkoordinasi, terukur, dan sesuai standar keselamatan pasien.

Penyusunan Renop dilakukan melalui analisis kebutuhan pasien, beban kerja unit, jumlah dan kompetensi perawat, ketersediaan sarana prasarana, serta kebijakan rumah

sakit. Perencanaan ini melibatkan pendekatan partisipatif sehingga perawat memiliki rasa memiliki terhadap rencana yang disusun. Selain itu, Renop harus disusun secara fleksibel agar dapat disesuaikan dengan dinamika pelayanan seperti peningkatan jumlah pasien, perubahan tingkat keparahan kasus, maupun situasi kedaruratan.

Perencanaan yang baik dalam manajemen asuhan keperawatan memberikan banyak manfaat, antara lain meningkatkan efektivitas kerja tim, memperkuat koordinasi antar tenaga kesehatan, menjamin kesinambungan pelayanan, serta meningkatkan mutu dan keselamatan pasien. Renop juga membantu organisasi dalam melakukan evaluasi kinerja, audit mutu, serta pengembangan pelayanan kesehatan secara berkelanjutan. Dengan demikian, perencanaan bukan hanya dokumen administratif, melainkan instrumen strategis dalam mencapai pelayanan keperawatan yang profesional, humanis, dan berkualitas.

## **B. Pengorganisasian dan Metode Pemberian Asuhan Keperawatan**

### **1. Pengertian Pengorganisasian, Prinsip, Budaya, dan Iklim Organisasi**

Pengorganisasian merupakan fungsi manajemen yang berfokus pada pengaturan struktur, pembagian tugas, koordinasi tanggung jawab, serta pengaturan hubungan kerja antar individu dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam manajemen keperawatan, pengorganisasian bertujuan memastikan setiap tenaga keperawatan memahami peran, kedudukan, serta tanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan kesehatan. Proses pengorganisasian melibatkan penetapan struktur

organisasi, pembagian tugas, penetapan alur komunikasi, dan pengaturan wewenang agar sistem kerja berjalan efektif dan efisien.

Karakteristik pengorganisasian meliputi adanya kejelasan struktur, pembagian kerja yang proporsional, koordinasi antar bagian, serta adanya mekanisme pengawasan. Pengorganisasian menjadi sangat penting karena membantu rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan menghindari tumpang tindih pekerjaan, memperjelas rantai komando, meningkatkan efisiensi kerja, serta memperkuat akuntabilitas. Prinsip pengorganisasian meliputi keselarasan dengan tujuan organisasi, kesesuaian antara beban kerja dan kemampuan, kejelasan tugas dan wewenang, fleksibilitas, serta orientasi pada mutu pelayanan.

Selain itu, keberhasilan pengorganisasian sangat dipengaruhi oleh budaya dan iklim organisasi. Budaya organisasi mencakup nilai, norma, dan keyakinan yang dianut dalam lingkungan kerja, sedangkan iklim organisasi mencerminkan suasana psikologis yang dirasakan tenaga keperawatan dalam menjalankan tugas. Budaya dan iklim organisasi yang positif akan membentuk perilaku kerja yang profesional, meningkatkan motivasi, memperkuat kerjasama tim, serta mendukung terciptanya pelayanan keperawatan yang bermutu dan berorientasi pada keselamatan pasien.

## **2. Struktur Organisasi dalam Keperawatan**

Struktur organisasi dalam keperawatan disusun untuk menetapkan susunan jabatan, alur tanggung jawab, dan koordinasi kerja di dalam unit pelayanan. Struktur organisasi pada keperawatan umumnya dibagi dalam beberapa bentuk, antara lain struktur organisasi lini, struktur fungsional, dan struktur matriks. Struktur lini menekankan pada alur komando vertikal dari pimpinan ke

bawahan secara langsung, sedangkan struktur fungsional membagi tugas berdasarkan bidang tugas dan keahlian. Struktur matriks menggabungkan unsur struktural dan fungsional sehingga memungkinkan koordinasi lebih fleksibel.

Dalam praktik keperawatan modern, struktur organisasi sering disusun secara hirarkis mulai dari direktur keperawatan, manajer keperawatan, kepala ruangan, ketua tim, hingga perawat pelaksana. Penyusunan struktur organisasi harus memperhatikan ukuran unit, jumlah tenaga keperawatan, kompleksitas pelayanan, serta jenis fasilitas pelayanan kesehatan. Struktur organisasi yang jelas akan mempermudah komunikasi, memperkuat koordinasi, serta memastikan setiap kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif di unit pelayanan.

Selain itu, struktur organisasi juga memengaruhi pola pengambilan keputusan, kecepatan respon pelayanan, serta efektivitas supervisi. Struktur yang terlalu kaku dapat menghambat inovasi, sedangkan struktur yang terlalu longgar dapat menimbulkan ketidakjelasan tanggung jawab. Oleh karena itu, rumah sakit atau fasilitas kesehatan perlu menyusun struktur organisasi yang seimbang antara keteraturan, fleksibilitas, dan kebutuhan pelayanan keperawatan.

### **3. Implementasi Pengorganisasian Keperawatan di Ruang Rawat Fasilitas Pelayanan Kesehatan**

Implementasi pengorganisasian keperawatan di ruang rawat dimulai dengan penetapan struktur organisasi unit, penentuan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), serta pembagian tanggung jawab berdasarkan kompetensi tenaga keperawatan. Kepala ruangan berperan sebagai pemimpin yang mengoordinasikan seluruh tenaga keperawatan, mengatur alur kerja, serta memastikan pelayanan berjalan sesuai standar operasional.



Implementasi juga mencakup pengaturan jumlah tenaga, pola dinas, pembagian beban kerja, serta penetapan mekanisme pelaporan.

Selain pembagian tugas, pengorganisasian juga diwujudkan melalui pengaturan komunikasi dan koordinasi. Komunikasi dilakukan melalui briefing, rapat rutin, handover, supervisi, dan evaluasi kinerja. Dengan sistem komunikasi yang baik, setiap anggota tim memiliki pemahaman yang sama terhadap tujuan pelayanan, kebijakan unit, serta kondisi pasien. Hal ini penting untuk menjamin kesinambungan pelayanan, mencegah kesalahan, dan meningkatkan keselamatan pasien.

Implementasi pengorganisasian keperawatan juga memastikan terselenggaranya kolaborasi antar tenaga kesehatan, integrasi pelayanan dengan profesi lain, serta penguatan peran kepemimpinan klinis. Melalui pengorganisasian yang baik, ruang rawat dapat beroperasi secara efektif, tenaga keperawatan bekerja sesuai standar profesional, dan mutu pelayanan dapat dipertahankan. Dengan demikian, pengorganisasian bukan sekadar pembagian tugas, tetapi merupakan proses manajerial yang memastikan sistem pelayanan berjalan optimal dan berkelanjutan.

#### **4. Metode Penugasan/Pemberian Asuhan Keperawatan (K/P)**

Metode penugasan atau pemberian asuhan keperawatan merupakan pendekatan yang digunakan untuk membagi tugas keperawatan kepada tenaga perawat dalam suatu unit pelayanan. Beberapa metode yang umum digunakan antara lain metode fungsional, metode tim (*team nursing*), metode primer (*primary nursing*), dan metode modular. Metode fungsional membagi tugas berdasarkan jenis pekerjaan, sedangkan metode tim membagi pasien dalam kelompok yang dikelola oleh ketua tim dan

anggota tim. Metode primer memberikan tanggung jawab penuh kepada seorang perawat terhadap pasien tertentu, sedangkan metode modular merupakan variasi dari metode tim yang membagi wilayah kerja dalam kelompok kecil.

Pemilihan metode penugasan dipengaruhi oleh jumlah tenaga keperawatan, tingkat kompetensi, kondisi pasien, beban kerja, serta karakteristik unit pelayanan. Setiap metode memiliki kelebihan dan keterbatasan sehingga pemimpin keperawatan perlu memilih metode yang paling sesuai dengan kebutuhan pelayanan. Misalnya, metode tim efektif untuk meningkatkan komunikasi dan kerjasama, sedangkan metode primer sangat mendukung kesinambungan asuhan dan kualitas hubungan perawat-pasien.

Secara aplikatif, metode penugasan memengaruhi mutu asuhan keperawatan, efisiensi kerja, kepuasan perawat, serta keselamatan pasien. Metode yang tepat akan memastikan tugas terbagi secara proporsional, beban kerja terkelola, dokumentasi berjalan baik, dan pelayanan bersifat menyeluruh. Dengan demikian, metode pemberian asuhan keperawatan menjadi bagian penting dalam pengorganisasian layanan yang berkualitas, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan pasien.

## **C. Perencanaan dan Penjadwalan Ketenagaan Keperawatan**

### **1. Pengertian, Pentingnya Ketenagaan yang Aman (*Safe Staffing*), Prinsip, Komponen, dan Tujuan Ketenagaan**

Manajemen ketenagaan merupakan rangkaian kegiatan pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup perencanaan, pengadaan, penempatan, pengembangan, serta pengendalian tenaga keperawatan untuk memastikan pelayanan kesehatan

berjalan efektif dan bermutu. Dalam konteks ruang rawat, manajemen ketenagaan memiliki peran strategis karena tenaga keperawatan merupakan garda terdepan yang berinteraksi langsung dengan pasien selama 24 jam (Aditama, 2004). Oleh karena itu, pengelolaan tenaga keperawatan harus dilakukan secara sistematis, rasional, dan berbasis kebutuhan pelayanan.

Ketenagaan yang aman (*safe staffing*) berarti jumlah tenaga perawat yang tersedia sesuai dengan standar kebutuhan pelayanan, tingkat keparahan pasien, serta beban kerja unit. *Safe staffing* sangat penting untuk menjamin keselamatan pasien, meningkatkan mutu asuhan, mencegah kelelahan kerja perawat, serta menekan angka kesalahan pelayanan. Jika jumlah tenaga tidak mencukupi, risiko terjadinya insiden keselamatan pasien, keterlambatan tindakan, *burn out*, serta penurunan mutu pelayanan akan meningkat.

Prinsip manajemen ketenagaan meliputi kecukupan jumlah, kesesuaian kompetensi, distribusi yang proporsional, efisiensi, fleksibilitas, dan keadilan dalam penugasan. Komponen ketenagaan mencakup jumlah tenaga, kualifikasi pendidikan, kompetensi klinis, pengalaman kerja, serta kemampuan adaptasi terhadap beban kerja. Tujuan utama manajemen ketenagaan adalah memastikan pelayanan yang aman, efektif, berkelanjutan, serta mendukung kesejahteraan tenaga keperawatan. Dengan pengelolaan ketenagaan yang baik, organisasi dapat mencapai kinerja optimal dan pelayanan pasien yang berkualitas.

## **2. Pola Ketenagaan dan Faktor yang Mempengaruhi**

Pola ketenagaan menggambarkan cara pengaturan jumlah, distribusi, serta susunan tenaga perawat dalam suatu unit pelayanan. Pola ketenagaan dapat disusun berdasarkan tingkat pelayanan, kebutuhan pasien, jenis

ruangan (intensif, rawat inap, gawat darurat), serta kebijakan institusi. Pola ini juga mencakup pembagian level perawat seperti kepala ruangan, ketua tim, perawat pelaksana, dan tenaga pendukung keperawatan. Pengaturan pola ketenagaan yang tepat memastikan kesinambungan pelayanan, keseimbangan beban kerja, dan efektivitas kinerja tim.

Faktor yang memengaruhi pola ketenagaan antara lain jumlah pasien, tingkat keparahan (acuity level), tingkat ketergantungan pasien, jenis tindakan yang dilakukan, serta standar pelayanan yang ditetapkan. Selain itu, ketersediaan tenaga, tingkat kompetensi, tingkat pengalaman, serta kebijakan rumah sakit juga sangat memengaruhi pola ketenagaan. Perubahan kondisi pelayanan seperti lonjakan pasien, keadaan darurat, atau situasi bencana juga menuntut fleksibilitas dalam pengaturan ketenagaan.

Selain faktor klinis, faktor organisasi seperti budaya kerja, model pembiayaan, kebijakan nasional tenaga kesehatan, serta regulasi profesional turut berperan. Di Indonesia, standar ketenagaan keperawatan juga mengacu pada kebijakan Kementerian Kesehatan, standar akreditasi rumah sakit, serta pedoman keselamatan pasien. Dengan mempertimbangkan seluruh faktor tersebut, pengelolaan pola ketenagaan dapat disusun secara komprehensif untuk mendukung kualitas pelayanan keperawatan.

### **3. Cara Penghitungan Jumlah Tenaga dalam Suatu Shift**

Penghitungan jumlah tenaga keperawatan dalam suatu shift dilakukan untuk menentukan berapa jumlah perawat yang dibutuhkan agar pelayanan tetap aman, efektif, dan sesuai standar. Perhitungan ini umumnya didasarkan pada jumlah pasien, tingkat ketergantungan pasien, beban kerja, serta waktu yang dibutuhkan untuk

memberikan asuhan keperawatan. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah berdasarkan rasio perawat terhadap pasien (*nurse to patient ratio*) atau berdasarkan total jam pelayanan keperawatan (*nursing care hours*).

Dalam praktik keperawatan, kebutuhan tenaga pada setiap shift dapat disesuaikan dengan kondisi puncak pelayanan, misalnya pada jam-jam tertentu jumlah pasien dan aktivitas klinis lebih tinggi. Oleh karena itu, shift pagi umumnya memiliki jumlah tenaga lebih banyak dibanding shift sore dan malam. Perhitungan tenaga juga mempertimbangkan faktor ketersediaan tenaga pengganti, kebutuhan cuti, pelatihan, serta kemungkinan adanya kejadian insidental yang membutuhkan tenaga tambahan.

Selain perhitungan matematis, aspek profesional seperti kompetensi perawat, kemampuan klinis, pengalaman kerja, dan kemampuan bekerja dalam tim juga dipertimbangkan. Dengan perhitungan tenaga yang tepat, beban kerja menjadi seimbang, risiko kelelahan kerja dapat dikurangi, serta pelayanan keperawatan dapat diberikan secara optimal. Hal ini menjadi dasar penting dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

Ada banyak menghitung jumlah ketenagaan perawat tiap shift diantaranya: metode Gillies (*Patient Classification System/Nursing Care Hours*) yang menghitung berdasarkan tingkat ketergantungan pasien, WHO-WISN (*Workload Indicators of Staffing Need*) yang berbasis beban kerja nyata, NHPPD/HPPD (*Nursing Hours Per Patient Day*) yang menghitung jam keperawatan per pasien per hari, rasio perawat-pasien dengan standar tetap sesuai jenis unit, metode FTE (*Full Time Equivalent*) yang menghitung berdasarkan jam kerja tahunan, *acuity-*

*based staffing* berbasis tingkat keparahan pasien secara dinamis, serta sistem khusus seperti RAFAELA atau TISS untuk ICU; di Indonesia juga digunakan pendekatan sesuai standar Kemenkes RI dan Nursalam yang mengombinasikan jumlah pasien, beban kerja, tingkat ketergantungan, dan jam kerja efektif sehingga secara umum terdapat sekitar tujuh hingga delapan metode yang diakui dan digunakan luas dalam perencanaan ketenagaan keperawatan. Namun dalam buku ini penulis membuat contoh dari salah satu metode saja dan metode yang diambil adalah metode yang paling mudah dipahami dan paling umum digunakan.

Menurut Gillies (1994), perhitungan kebutuhan tenaga keperawatan dilakukan berdasarkan tingkat ketergantungan pasien serta jumlah jam keperawatan yang dibutuhkan dalam 24 jam. Penghitungan dimulai dengan mengelompokkan pasien ke dalam kategori tingkat ketergantungan, yaitu pasien dengan ketergantungan minimal, sedang, tinggi, hingga total atau kompleks. Setiap kategori pasien memiliki standar kebutuhan jam pelayanan keperawatan yang berbeda, misalnya dua jam per hari untuk pasien ketergantungan rendah, tiga jam per hari untuk ketergantungan sedang, empat jam per hari untuk ketergantungan tinggi, dan enam jam per hari untuk pasien total care. Seluruh kebutuhan jam pelayanan dari masing-masing kategori selanjutnya dijumlahkan untuk memperoleh total jam keperawatan yang dibutuhkan dalam satu hari.

Setelah diperoleh total jam keperawatan, langkah berikutnya adalah menentukan jumlah tenaga perawat yang diperlukan dalam satu hari dengan membagi total jam keperawatan tersebut dengan jam kerja efektif perawat per hari, umumnya delapan jam. Hasil perhitungan ini kemudian dibagi ke dalam distribusi shift kerja sesuai kebutuhan pelayanan, yaitu umumnya 50%

kebutuhan dialokasikan pada shift pagi, 30% pada shift sore, dan 20% pada shift malam. Pembagian ini mempertimbangkan bahwa aktivitas pelayanan dan kebutuhan intervensi keperawatan lebih tinggi pada pagi hari dibandingkan sore dan malam hari.

Langkah terakhir adalah menambahkan faktor cadangan (*allowance factor*) sekitar 10–15 persen untuk mengantisipasi ketidakhadiran perawat karena cuti, sakit, pelatihan, serta kebutuhan pelayanan yang tidak terduga. Dengan demikian, hasil akhir perhitungan mencerminkan jumlah tenaga keperawatan yang realistis dan aman (*safe staffing*) untuk menjamin mutu pelayanan serta keselamatan pasien. Pendekatan yang dikemukakan Gillies ini memberikan dasar ilmiah yang kuat dalam perencanaan ketenagaan keperawatan dan banyak digunakan dalam praktik manajemen keperawatan modern. Perhitungan ini dianggap paling mudah diikuti karena berdasarkan tingkat ketergantungan pasien:

| Kualifikasi Pasien     |                     | jumlah kebutuhan Tenaga |          |          |
|------------------------|---------------------|-------------------------|----------|----------|
| Tingkat Ketergantungan | Jumlah Pasien/Klien | Pagi                    | Sore     | Malam    |
| Minimal                | —                   | _ x 0,17                | _ x 0,14 | _ x 0,07 |
| Parsial                | —                   | _ x 0,27                | _ x 0,15 | _ x 0,10 |
| Total                  | —                   | _ x 0,36                | _ x 0,30 | _ x 0,20 |
| Jumlah                 | —                   | —                       | —        | —        |

**Tabel 2.1 Klasifikasi Pasien  
untuk Perhitungan Kebutuhan Tenaga Perawat  
(Douglas–Gillies, 1994)**

#### **4. Alokasi dan Penjadwalan Tenaga Keperawatan Setiap Shift**

Alokasi dan penjadwalan tenaga keperawatan merupakan proses pengaturan pembagian tenaga dalam setiap shift pelayanan agar kebutuhan unit tetap terpenuhi selama 24 jam. Penjadwalan dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah tenaga yang tersedia, beban kerja, kebutuhan pasien, serta tetap memperhatikan keseimbangan antara tuntutan pelayanan dan kesejahteraan tenaga keperawatan. Jadwal dinas umumnya dibagi menjadi shift pagi, sore, dan malam dengan distribusi tenaga yang disesuaikan dengan karakteristik aktivitas pelayanan.

Dalam penyusunan jadwal, kepala ruangan atau manajer keperawatan harus memperhatikan prinsip keadilan, pemerataan beban kerja, kepatuhan terhadap regulasi jam kerja, serta kebutuhan individu perawat. Penjadwalan yang baik akan mengurangi kelelahan, meningkatkan motivasi, serta memperkuat kepuasan kerja tenaga keperawatan. Selain itu, jadwal harus fleksibel agar dapat disesuaikan dengan situasi tidak terduga seperti ketidakhadiran mendadak, peningkatan jumlah pasien, atau keadaan gawat darurat.

Secara operasional, penyusunan jadwal diperlukan koordinasi yang baik, dokumentasi yang jelas, serta adanya sistem monitoring dan evaluasi. Jadwal yang disusun harus dikomunikasikan kepada seluruh tenaga secara terbuka dan terdokumentasi dengan baik. Dengan alokasi dan penjadwalan tenaga yang terencana, ruang rawat mampu menjalankan pelayanan secara efektif, menjamin kesinambungan asuhan, serta menjaga mutu dan keselamatan pasien secara berkelanjutan.



## **D. Manajemen Pengarahan dan Mempraktikkan Supervisi Manajemen**

### **1. Pengertian, Prinsip, Elemen Pengarahan, dan *Organizational Behavior***

Pengarahan merupakan salah satu fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha pemimpin dalam memengaruhi, membimbing, memotivasi, dan menggerakkan seluruh anggota organisasi untuk bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks manajemen keperawatan, pengarahan tidak hanya mencakup instruksi kerja, tetapi juga meliputi pembinaan, pemberdayaan, dan pendampingan tenaga keperawatan dalam melaksanakan tugas profesional. Pengarahan dilakukan secara sistematis agar setiap individu memahami peran, tanggung jawab, serta standar kerja yang harus dicapai. Prinsip pengarahan meliputi kejelasan tujuan, komunikasi yang efektif, keteladanan pemimpin, pemberian motivasi, penghargaan terhadap kinerja, serta penerapan disiplin kerja yang adil dan rasional. Pengarahan yang baik harus dilakukan secara manusiawi dengan mempertimbangkan faktor psikologis, sosial, serta moral tenaga kerja. Selain itu, pengarahan harus bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi serta tuntutan pelayanan kesehatan.

Elemen penting dalam pengarahan meliputi komunikasi, motivasi, kepemimpinan, bimbingan, dan pembinaan. Pada saat yang sama, pengarahan juga terkait erat dengan perilaku organisasi (*organizational behavior*) yaitu studi mengenai perilaku individu dan kelompok dalam organisasi serta faktor yang memengaruhinya. Pemahaman terhadap perilaku organisasi memungkinkan pemimpin untuk memahami karakter bawahan, dinamika kelompok, dan budaya kerja sehingga

pengarahan dapat dilakukan secara efektif, konstruktif, dan berorientasi pada peningkatan kinerja.

## **2. Peran dan Fungsi Pengarahan**

Pengarahan memiliki peran strategis dalam menjembatani tujuan organisasi dengan pelaksanaan kerja di lapangan. Melalui fungsi pengarahan, pemimpin memastikan bahwa setiap tenaga kerja memahami visi, misi, kebijakan, dan standar pelayanan yang berlaku. Pengarahan membantu memastikan bahwa kegiatan operasional tidak hanya berjalan, tetapi berjalan dengan benar sesuai dengan prosedur dan standar kualitas yang telah ditetapkan. Dengan pengarahan yang tepat, potensi kesalahan kerja dapat diminimalkan dan efektivitas organisasi dapat ditingkatkan.

Fungsi pengarahan juga mencakup pembinaan sikap, motivasi, dan kedisiplinan kerja. Pemimpin bertugas menumbuhkan semangat kerja, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, serta memberikan dukungan emosional dan profesional kepada bawahan. Pengarahan yang baik membantu meningkatkan loyalitas, rasa memiliki terhadap organisasi, dan kepercayaan diri tenaga keperawatan dalam memberikan pelayanan. Hal ini sangat penting karena faktor manusia merupakan elemen utama dalam keberhasilan pelayanan kesehatan.

Selain itu, pengarahan berfungsi sebagai sarana komunikasi dua arah antara pimpinan dan bawahan. Melalui pengarahan, pemimpin dapat menyampaikan kebijakan, target, dan perubahan organisasi, sekaligus menerima umpan balik dari bawahan terkait hambatan dan kebutuhan yang muncul dalam pelayanan. Dengan demikian, pengarahan berperan dalam membangun koordinasi, memperkuat kerjasama tim, serta memastikan keberlangsungan pelayanan keperawatan secara efektif dan berkelanjutan.

### 3. Supervisi yang Efektif

Supervisi merupakan proses pembinaan, pengawasan, dan pendampingan yang dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahan dengan tujuan memastikan pekerjaan dilaksanakan sesuai standar profesional, prosedur operasional, dan tujuan organisasi. Dalam manajemen keperawatan, supervisi menjadi instrumen penting untuk menjamin mutu pelayanan, keselamatan pasien, serta pengembangan kompetensi tenaga keperawatan. Supervisi tidak hanya berorientasi pada pengawasan, tetapi juga pada pemberdayaan dan peningkatan kualitas kerja.

Supervisi yang efektif ditandai dengan perencanaan yang baik, pelaksanaan yang sistematis, pendekatan yang manusiawi, serta evaluasi yang objektif. Supervisor harus memiliki kompetensi manajerial, kemampuan komunikasi, ketegasan, keadilan, serta sikap empatik dalam melaksanakan tugasnya. Supervisi efektif dilakukan melalui observasi langsung, diskusi, bimbingan, koreksi konstruktif, serta pemberian umpan balik yang membangun. Dengan pendekatan tersebut, supervisi dapat meningkatkan kepatuhan terhadap standar dan meningkatkan tanggung jawab profesional.

Selain itu, supervisi yang efektif mampu menciptakan iklim kerja yang positif dan mendukung pembelajaran berkelanjutan (*continuous improvement*). Melalui supervisi, pemimpin dapat mengidentifikasi permasalahan di lapangan, menemukan penyebabnya, serta menetapkan tindakan perbaikan yang tepat. Supervisi juga mendorong staf untuk terus meningkatkan kompetensi, memperkuat etika kerja, serta mengembangkan perilaku profesional. Dengan demikian, supervisi tidak hanya menjadi alat kontrol, tetapi juga menjadi sarana pembinaan, peningkatan mutu, dan penguatan budaya kerja yang berkualitas.

## **E. Kontroling, EBNP, dan Mutu Asuhan Keperawatan Sesuai Standar**

### **1. Pengertian Mutu, Tujuan dan Manajemen Mutu, Model Pendekatan Mutu Termasuk Kaizen**

Mutu dalam pelayanan keperawatan diartikan sebagai tingkat kesesuaian pelayanan yang diberikan dengan standar profesi, standar prosedur operasional, kebutuhan pasien, serta harapan masyarakat. Mutu tidak hanya dilihat dari hasil akhir pelayanan, tetapi juga mencakup proses pelaksanaan asuhan, keselamatan pasien, kepatuhan dokumentasi, hubungan interpersonal, serta kepuasan pasien dan keluarga. Mutu pelayanan keperawatan yang baik akan mencerminkan profesionalisme tenaga keperawatan dan tingginya komitmen organisasi terhadap pelayanan kesehatan yang aman dan efektif.

Tujuan manajemen mutu dalam keperawatan adalah untuk menjamin bahwa seluruh pelayanan yang diberikan berlangsung secara konsisten, efektif, efisien, aman, dan berorientasi pada kebutuhan pasien. Melalui manajemen mutu, organisasi mampu mengidentifikasi kelemahan sistem, kesenjangan antara standar dan pelaksanaan, serta menentukan tindakan perbaikan yang diperlukan. Dengan demikian, manajemen mutu tidak hanya bertujuan mempertahankan standar yang ada, tetapi juga mendorong peningkatan mutu secara berkelanjutan. Manajemen mutu dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan terencana seperti penetapan standar, implementasi kebijakan mutu, monitoring pelaksanaan pelayanan, evaluasi mutu, serta tindak lanjut perbaikan. Dalam hal ini, controlling sebagai fungsi manajemen berperan penting memastikan bahwa pelayanan berjalan sesuai standar dan regulasi yang telah ditetapkan. Proses pengendalian mutu mencakup audit keperawatan,

supervisi klinik, pemantauan indikator mutu, serta pelaporan insiden keselamatan pasien.

Salah satu model pendekatan mutu yang banyak digunakan adalah Kaizen, yaitu konsep perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*). Kaizen menekankan bahwa peningkatan mutu tidak selalu harus melalui perubahan besar, tetapi dilakukan secara bertahap melalui perbaikan kecil yang konsisten dan melibatkan seluruh anggota organisasi. Dalam keperawatan, Kaizen diwujudkan melalui upaya peningkatan prosedur kerja, standar layanan, keselamatan pasien, dan budaya mutu yang berkelanjutan sehingga pelayanan keperawatan terus berkembang mengikuti tuntutan profesional dan perkembangan ilmu pengetahuan.

## **2. Evidence-Based Nursing Practice (EBNP) dan Mutu Asuhan Keperawatan**

*Evidence-Based Nursing Practice* (EBNP) merupakan pendekatan praktik keperawatan yang didasarkan pada bukti ilmiah terbaik yang tersedia, dipadukan dengan pengalaman klinis perawat serta nilai dan kebutuhan pasien. Konsep ini menekankan bahwa setiap tindakan keperawatan harus memiliki dasar rasional yang kuat dan tidak hanya bergantung pada kebiasaan, intuisi, atau pengalaman pribadi semata. Dengan menggunakan EBNP, perawat dapat memberikan asuhan yang lebih efektif, efisien, dan sesuai standar ilmiah.

Penerapan EBNP memiliki peran penting dalam peningkatan mutu pelayanan keperawatan. Dengan menggunakan bukti ilmiah, risiko kesalahan tindakan dapat diminimalkan, efektivitas intervensi meningkat, serta keselamatan pasien lebih terjamin. EBNP juga membantu perawat mengambil keputusan klinis yang tepat, memilih intervensi yang paling sesuai, dan

menyesuaikan tindakan berdasarkan kondisi individual pasien. Dengan demikian, EBNP merupakan dasar penting dalam praktik keperawatan profesional modern.

Dalam kaitannya dengan manajemen mutu, EBNP menjadi komponen utama dalam penetapan standar pelayanan keperawatan. Standar prosedur operasional, pedoman klinik, dan protokol tindakan disusun berdasarkan hasil penelitian mutakhir, pedoman internasional, serta kebijakan nasional kesehatan. Hal ini memastikan bahwa mutu pelayanan keperawatan tidak hanya memenuhi harapan organisasi, tetapi juga sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi di bidang kesehatan.

Selain itu, penerapan EBNP juga mendorong terciptanya budaya belajar dan penelitian dalam praktik keperawatan. Perawat didorong untuk melakukan telaah literatur, mengikuti pelatihan berbasis bukti, berpartisipasi dalam penelitian, serta terlibat dalam evaluasi mutu pelayanan. Dengan demikian, EBNP berperan penting dalam membangun profesionalisme perawat, meningkatkan mutu asuhan, dan mendukung tercapainya pelayanan kesehatan yang aman, efektif, dan berorientasi pada pasien.

### **3. Proses Menjaga Mutu Asuhan Keperawatan di Ruang Rawat dan Analisis Masalah Mutu dengan Model RCA**

Proses menjaga mutu asuhan keperawatan di ruang rawat dilakukan melalui sistem yang terstruktur dan berkesinambungan (Bakri, 2017). Tahapan menjaga mutu dimulai dari penetapan standar pelayanan keperawatan yang jelas, implementasi standar dalam praktik sehari-hari, pemantauan pelaksanaan, evaluasi hasil pelayanan, serta pelaksanaan tindakan korektif dan preventif. Seluruh proses ini memerlukan keterlibatan aktif kepala ruangan, manajer keperawatan, serta seluruh tenaga keperawatan

agar mutu pelayanan dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara konsisten. Monitoring mutu dilakukan melalui berbagai mekanisme seperti audit keperawatan, penilaian indikator mutu, observasi langsung, peninjauan dokumentasi, survei kepuasan pasien, serta pelaporan insiden keselamatan pasien. Indikator mutu dapat mencakup ketepatan tindakan keperawatan, kepatuhan dokumentasi, tingkat infeksi nosokomial, insiden jatuh, tekanan luka (*pressure injury*), serta kepuasan pasien dan keluarga. Hasil monitoring kemudian dianalisis untuk menentukan ada atau tidaknya penyimpangan terhadap standar.

Dalam menganalisis masalah mutu, salah satu pendekatan yang banyak digunakan adalah Root Cause Analysis (RCA). RCA merupakan metode analisis yang bertujuan mengidentifikasi akar penyebab terjadinya masalah mutu atau insiden keselamatan pasien. Melalui RCA, tim mutu akan menelusuri kejadian secara sistematis, mengumpulkan data, meninjau proses kerja, dan mencari faktor penyebab yang mendasari terjadinya masalah, bukan sekadar menyalahkan individu. RCA mendorong pendekatan sistem (*system-based*) sehingga perbaikan difokuskan pada perbaikan prosedur, pelatihan, komunikasi, dan sistem kerja.

Setelah akar masalah ditemukan, dilakukan penyusunan rencana perbaikan dan pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Rencana perbaikan dapat berupa revisi standar operasional, pelatihan staf, perbaikan fasilitas, peningkatan koordinasi, serta penguatan budaya keselamatan pasien. Dengan demikian, penerapan proses kontrol mutu yang baik serta pemanfaatan RCA memungkinkan organisasi menjaga dan meningkatkan mutu asuhan keperawatan secara berkelanjutan, sekaligus melindungi keselamatan pasien sebagai prioritas utama pelayanan kesehatan.

## F. Latihan

Latihan ini bertujuan untuk menguji pemahaman, kemampuan analisis, serta penerapan konsep fungsi manajemen dalam konteks pelayanan keperawatan. Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan mengintegrasikan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengawasan dalam praktik manajemen keperawatan. Kerjakan setiap soal secara cermat dan sistematis sesuai dengan materi yang telah dipelajari pada Bab Fungsi Manajemen. Bentuk latihan meliputi soal pilihan ganda dan esai analitis.

Melalui latihan ini, diharapkan mahasiswa mampu mengidentifikasi konsep kunci fungsi manajemen, menjelaskan peran masing-masing fungsi dalam pengelolaan pelayanan keperawatan, serta mengaplikasikannya secara tepat dalam praktik manajemen keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan guna menjamin mutu dan keselamatan pasien.

### Soal Kasus Pilihan Ganda

1. Seorang kepala ruangan IGD menyusun rencana kerja bulanan yang berisi jadwal dinas perawat, kebutuhan alat kesehatan, serta target peningkatan kepatuhan dokumentasi asuhan keperawatan. Kegiatan yang dilakukan kepala ruangan tersebut mencerminkan fungsi manajemen:  
A. Pengorganisasian  
B. Pengarahan  
C. Pengendalian  
D. Perencanaan  
E. Koordinasi
2. Kepala ruangan membagi tugas kepada perawat berdasarkan kompetensi klinis dan pengalaman kerja, kemudian menetapkan siapa yang bertanggung jawab



sebagai ketua tim pada setiap shift. Fungsi manajemen yang sedang diterapkan adalah:

- |                     |               |
|---------------------|---------------|
| A. Perencanaan      | D. Pengawasan |
| B. Pengorganisasian | E. Evaluasi   |
| C. Pengarahan       |               |

3. Seorang manajer keperawatan memberikan motivasi, bimbingan, dan umpan balik kepada perawat pelaksana agar mampu meningkatkan mutu pelayanan dan kepatuhan terhadap SOP. Fungsi manajemen tersebut adalah:

- |                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| A. Perencanaan      | D. Pengendalian |
| B. Pengorganisasian | E. Evaluasi     |
| C. Pengarahan       |                 |

4. Kepala ruangan melakukan audit dokumentasi keperawatan dan menemukan bahwa 30% catatan tidak lengkap. Ia kemudian menyusun rencana tindak lanjut untuk perbaikan. Fungsi manajemen yang dominan dalam kegiatan ini adalah:

- |                     |               |
|---------------------|---------------|
| A. Perencanaan      | D. Pengawasan |
| B. Pengorganisasian | E. Koordinasi |
| C. Pengarahan       |               |

5. Manajer keperawatan menetapkan tujuan unit rawat inap untuk menurunkan angka kejadian infeksi nosokomial sebesar 10% dalam 6 bulan ke depan. Tindakan ini termasuk fungsi:

- |                     |               |
|---------------------|---------------|
| A. Pengorganisasian | D. Pengawasan |
| B. Pengarahan       | E. Evaluasi   |
| C. Perencanaan      |               |

6. Kepala ruangan mengatur struktur tim keperawatan dengan menetapkan peran ketua tim, perawat primer, dan perawat pelaksana. Fungsi manajemen yang

diterapkan adalah:

- |                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| A. Perencanaan      | D. Pengendalian |
| B. Pengorganisasian | E. Evaluasi     |
| C. Pengarahan       |                 |

7. Seorang manajer keperawatan membandingkan capaian indikator mutu pelayanan dengan standar rumah sakit, lalu menyusun laporan hasil kinerja unit. Fungsi manajemen yang dilakukan adalah:

- |                     |               |
|---------------------|---------------|
| A. Perencanaan      | D. Pengawasan |
| B. Pengorganisasian | E. Koordinasi |
| C. Pengarahan       |               |

8. Kepala ruangan memberikan instruksi kerja harian dan memimpin pre conference sebelum dinas dimulai. Kegiatan tersebut mencerminkan fungsi:

- |                     |               |
|---------------------|---------------|
| A. Perencanaan      | D. Pengawasan |
| B. Pengorganisasian | E. Evaluasi   |
| C. Pengarahan       |               |

9. Manajer keperawatan menyusun kebijakan pembagian beban kerja agar setiap perawat menangani jumlah pasien yang seimbang. Fungsi manajemen yang dominan adalah:

- |                     |               |
|---------------------|---------------|
| A. Perencanaan      | D. Pengawasan |
| B. Pengorganisasian | E. Evaluasi   |
| C. Pengarahan       |               |

10. Kepala ruangan mengevaluasi pelaksanaan program peningkatan mutu dan menentukan apakah program tersebut perlu dilanjutkan atau direvisi. Fungsi manajemen yang diterapkan adalah:

- |                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| A. Perencanaan      | D. Pengendalian |
| B. Pengorganisasian | E. Evaluasi     |
| C. Pengarahan       |                 |

## Latihan Soal Essai Analisis

1. Seorang kepala ruangan rawat inap menyusun rencana operasional tahunan, membagi tugas perawat berdasarkan kompetensi, memberikan pengarahan saat pre conference, serta melakukan audit mutu dokumentasi asuhan keperawatan setiap bulan.

Pertanyaan:

- a. Identifikasilah masing-masing fungsi manajemen yang diterapkan dalam kasus tersebut.
  - b. Jelaskan peran setiap fungsi manajemen dalam meningkatkan mutu pelayanan keperawatan.
- 
2. Di sebuah unit perawatan intensif, ditemukan bahwa kepatuhan perawat terhadap SOP hand hygiene menurun. Manajer keperawatan kemudian melakukan observasi, memberikan edukasi ulang, dan menetapkan standar pemantauan harian.
- Pertanyaan:
- a. Fungsi manajemen apa saja yang terlibat dalam kasus tersebut?
  - b. Jelaskan bagaimana penerapan fungsi manajemen tersebut dapat memperbaiki kinerja perawat?

## Kunci Jawaban Pilihan Ganda

1. D
2. B
3. C
4. D
5. C
6. B
7. D
8. C
9. B
10. E

## **G. Rangkuman Materi**

Bab ini membahas secara menyeluruh konsep dan penerapan fungsi manajemen dalam pelayanan keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya di unit ruang rawat. Manajemen keperawatan dipahami sebagai suatu proses sistematis untuk mencapai tujuan pelayanan melalui pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien. Fungsi manajemen yang dikaji meliputi perencanaan, pengorganisasian, ketenagaan, pengarahan, dan pengendalian, yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan proses dalam pengelolaan pelayanan keperawatan. Pemahaman yang komprehensif terhadap fungsi-fungsi tersebut menjadi landasan penting bagi perawat profesional, terutama pada level manajerial, dalam menjamin mutu pelayanan, keselamatan pasien, serta keberlangsungan operasional unit ruang rawat.

Fungsi perencanaan dibahas sebagai tahap awal dalam manajemen yang berorientasi pada penetapan tujuan dan penyusunan langkah-langkah strategis untuk mencapainya. Perencanaan mencakup pengertian, tujuan, pendekatan, prinsip, serta karakteristik perencanaan yang menekankan orientasi masa depan, rasionalitas, dan fleksibilitas. Komponen perencanaan meliputi tujuan, kebijakan, prosedur, program kerja, dan anggaran, sedangkan jenis perencanaan mencakup perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang, serta perencanaan strategis dan operasional. Proses perencanaan dilakukan melalui analisis situasi, penetapan tujuan, pemilihan alternatif tindakan, dan evaluasi pelaksanaan rencana. Dalam konteks ruang rawat, perencanaan diwujudkan dalam bentuk rencana operasional unit (Renop) yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan manajemen asuhan keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Fungsi pengorganisasian dan ketenagaan dibahas sebagai upaya pengaturan struktur kerja dan pengelolaan sumber daya manusia keperawatan. Pengorganisasian berfokus pada pembagian tugas, penetapan wewenang, serta pengaturan hubungan kerja antarindividu melalui penyusunan struktur organisasi unit dan tugas pokok serta fungsi (tupoksi). Proses ini dipengaruhi oleh prinsip pengorganisasian, budaya organisasi, dan iklim kerja. Berbagai jenis struktur organisasi keperawatan dan metode pemberian asuhan keperawatan, seperti metode kasus, fungsional, tim, dan keperawatan primer, dijelaskan sebagai dasar pengelolaan pelayanan di ruang rawat. Manajemen ketenagaan menekankan pentingnya penyediaan tenaga yang aman (*safe staffing*) melalui penghitungan jumlah perawat berdasarkan beban kerja, tingkat ketergantungan pasien, dan standar kebutuhan tenaga. Alokasi dan penjadwalan tenaga keperawatan setiap shift disusun secara sistematis untuk menjamin kontinuitas pelayanan, pemerataan beban kerja, serta pemenuhan hak perawat.

Fungsi pengarahan dan pengendalian dibahas sebagai tahap pelaksanaan dan evaluasi dalam manajemen keperawatan. Pengarahan mencakup pemberian instruksi, komunikasi efektif, motivasi, dan pembinaan kinerja perawat yang berkaitan erat dengan perilaku organisasi (*organizational behavior*). Supervisi yang efektif dipahami sebagai bagian integral dari pengarahan yang dilakukan secara sistematis, berkesinambungan, dan berorientasi pada pembinaan. Fungsi pengendalian difokuskan pada pemantauan, pengukuran, dan evaluasi kinerja untuk memastikan bahwa pelayanan sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan. Konsep mutu pelayanan keperawatan, manajemen mutu, pendekatan Kaizen, serta penerapan Evidence-Based Nursing Practice (EBNP) dijelaskan sebagai dasar peningkatan mutu asuhan

keperawatan. Proses menjaga mutu dilakukan melalui penetapan standar, pemantauan indikator mutu, dan analisis masalah mutu menggunakan metode Root Cause Analysis (RCA) guna mewujudkan pelayanan keperawatan yang bermutu, aman, dan berorientasi pada keselamatan pasien.

## **Glosarium**

|      |                                          |
|------|------------------------------------------|
| FTE  | : <i>Full Time Equivalent</i>            |
| RCA  | : <i>Root Cause Analysis</i>             |
| EBNP | : <i>Evidence-Based Nursing Practice</i> |
| SOP  | : Standar Operasional Peosedur           |

The background of the page features a grayscale photograph of several healthcare professionals, likely nurses or doctors, in a meeting or conference setting. They are wearing white coats and ties, and are gathered around a table, possibly discussing patient care or administrative matters. The image is slightly blurred, focusing attention on the text in the foreground.

# **BAB 3**

## **Pre Conference, Bedside Handover, dan Post Conference**

### **Pendahuluan**

Pelayanan keperawatan yang bermutu menuntut terselenggaranya asuhan keperawatan yang aman, berkesinambungan, dan berorientasi pada kebutuhan pasien serta keluarga. Perawat sebagai tenaga kesehatan profesional memegang peran sentral dalam menjamin kesinambungan pelayanan melalui komunikasi yang efektif, terstruktur, dan terdokumentasi dengan baik. Komunikasi yang tidak efektif dalam praktik keperawatan berpotensi menimbulkan kesalahan tindakan, duplikasi intervensi, hingga menurunnya mutu dan keselamatan pasien.

Pre conference, bedside handover, dan post conference merupakan bagian integral dari manajemen pelayanan keperawatan di unit pelayanan, khususnya di ruang rawat. Pre conference berfungsi sebagai sarana perencanaan dan penyamaan persepsi tim keperawatan sebelum pemberian asuhan, bedside handover berperan dalam proses serah terima tanggung jawab dan informasi klinis pasien secara langsung dan akurat, sedangkan post conference digunakan sebagai media evaluasi pelaksanaan asuhan keperawatan yang telah diberikan. Ketiga kegiatan ini saling berkaitan dan membentuk satu rangkaian proses komunikasi profesional yang sistematis dalam praktik keperawatan.

Pelaksanaan pre conference, bedside handover, dan post conference yang terstruktur dan sesuai standar akan mendukung peningkatan koordinasi tim, pengambilan keputusan klinis yang tepat, serta penguatan budaya keselamatan pasien. Selain itu, penerapan kegiatan ini juga menjadi bagian dari tanggung jawab manajerial perawat dalam mengelola sumber daya manusia, waktu, dan mutu pelayanan keperawatan secara efektif dan efisien.

Oleh karena itu, materi pre conference, bedside handover, dan post conference perlu dipahami secara komprehensif oleh mahasiswa dan praktisi keperawatan sebagai bekal dalam praktik klinik maupun manajemen keperawatan. Buku ajar ini disusun untuk memberikan pemahaman konseptual dan aplikatif mengenai pengertian, tujuan, prinsip, serta tahapan pelaksanaan pre conference, bedside handover, dan post conference, sehingga pembaca diharapkan mampu menerapkannya secara profesional sesuai dengan standar pelayanan keperawatan yang berlaku.

## **CPMK dan Sub-CPMK**

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) pada bab ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan, menganalisis, dan mengaplikasikan konsep, tujuan, syarat, waktu, alur, serta materi pelaksanaan overan dan conference keperawatan secara sistematis dan profesional sebagai bagian dari manajemen keperawatan untuk menjamin kesinambungan asuhan dan keselamatan pasien, sesuai dengan standar praktik keperawatan dan ketentuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Adapun Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK) dirumuskan sebagai berikut:

1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian pre-conference, overan, dan post-conference keperawatan serta membedakan fungsi dan karakteristik masing-masing kegiatan dalam konteks manajemen keperawatan secara tepat dan sistematis.
2. Mahasiswa mampu menguraikan dan menjelaskan tujuan pelaksanaan overan, pre-conference, dan post-conference dalam menjamin kesinambungan asuhan keperawatan, meningkatkan koordinasi tim, serta mendukung mutu dan keselamatan pasien. Mahasiswa mampu menganalisis dan membedakan jenis-jenis perencanaan dalam manajemen keperawatan.



3. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan syarat-syarat pelaksanaan overan dan conference keperawatan, meliputi kesiapan sumber daya manusia, kelengkapan informasi, aspek etika, serta dokumentasi sesuai standar pelayanan keperawatan.
4. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menentukan waktu serta tempat pelaksanaan overan, pre-conference, dan post-conference yang tepat berdasarkan alur pelayanan keperawatan dan kebijakan unit pelayanan kesehatan.
5. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis alur serta tahapan pelaksanaan overan, pre-conference, dan post-conference secara runtut dan logis, serta mengaitkannya dengan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam manajemen keperawatan
6. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan materi yang harus disampaikan oleh perawat pelaksana dalam pre-conference dan post-conference, meliputi kondisi pasien, masalah keperawatan, intervensi yang telah dan akan dilakukan, serta hasil evaluasi asuhan keperawatan.

Untuk mendukung pencapaian CPMK dan Sub-CPMK tersebut, berikut disajikan petunjuk pembelajaran yang perlu diperhatikan agar mahasiswa dapat menguasai materi yang dibahas dalam bab ini secara optimal.

- Mahasiswa membaca dan memahami CPMK, Sub-CPMK, serta pendahuluan sebagai acuan pembelajaran.
- Mahasiswa membaca materi pokok pembelajaran secara sistematis dan cermat.
- Mahasiswa mencermati konsep utama, istilah kunci, dan definisi penting fungsi manajemen.
- Mahasiswa mengaitkan materi dengan penerapan fungsi manajemen dalam praktik profesional.
- Mahasiswa melakukan diskusi untuk memperdalam pemahaman dan berpikir kritis.
- Mahasiswa mengerjakan tugas, latihan, atau refleksi pada akhir bab.
- Mahasiswa memanfaatkan sumber belajar tambahan yang relevan.

# Uraian Materi

---

## **A. Definisi Pre Conference, Bedside Handover, dan Post Conference**

*Pre conference* adalah pertemuan singkat dan terencana yang dilaksanakan oleh tim keperawatan pada awal shift sebelum pemberian asuhan keperawatan kepada pasien (Swansburg, 2000). Pre-conference berfokus pada proses perencanaan, penyamaan persepsi, serta pembagian tugas perawat berdasarkan kondisi pasien, tingkat ketergantungan, dan kompetensi perawat. Kegiatan ini dipimpin oleh Perawat Penanggung Jawab Asuhan (PPJA) atau kepala ruangan sebagai bagian dari fungsi pengarahan dalam manajemen keperawatan. Pre conference bertujuan untuk membahas kondisi pasien, rencana asuhan keperawatan, pembagian tugas, serta potensi masalah yang mungkin muncul selama shift berlangsung.

*Bedside handover* adalah proses serah terima tanggung jawab dan informasi asuhan keperawatan pasien yang dilakukan di sisi tempat tidur pasien dengan melibatkan pasien dan/atau keluarga, serta berfokus pada kondisi aktual pasien, rencana perawatan, dan aspek keselamatan pasien dari perawat shift lama kepada perawat shift baru. Bedside handover/Overan dilakukan secara lisan, tertulis, atau kombinasi keduanya dengan tujuan menjamin transfer informasi yang akurat, lengkap, dan relevan terkait kondisi pasien. Bedside handover menjadi titik kritis dalam pelayanan keperawatan karena berhubungan langsung dengan keselamatan pasien dan pencegahan kesalahan tindakan.

*Post conference* adalah dilaksanakan pada akhir shift setelah seluruh tindakan keperawatan selesai dilakukan. Kegiatan ini berorientasi pada evaluasi pelaksanaan asuhan keperawatan, pencapaian tujuan, serta identifikasi masalah yang muncul selama pelayanan. *Post-conference* juga berfungsi sebagai sarana refleksi dan pembelajaran tim keperawatan untuk perbaikan mutu pelayanan di masa mendatang. *Post conference* berfokus pada evaluasi pelaksanaan asuhan, pencapaian tujuan keperawatan, hambatan yang dihadapi, serta tindak lanjut yang perlu dilakukan pada shift berikutnya. Integrasi *pre* dan *post conference* dengan *bedside handover* menjadikan proses komunikasi lebih transparan, akurat, dan berpusat pada pasien.

## **B. Tujuan Pre, Bedside Handover dan Post Conference**

Pelaksanaan *pre*, *bedside handover* dan *post conference bedside handover* memiliki tujuan yang bersifat klinis, manajerial, dan edukatif, antara lain:

1. Menjamin kesinambungan asuhan keperawatan antar shift.
2. Meningkatkan efektivitas komunikasi dan koordinasi antar anggota tim keperawatan.
3. Mengurangi risiko kesalahan tindakan dan meningkatkan keselamatan pasien.
4. Menyamakan persepsi perawat terhadap rencana asuhan keperawatan.
5. Mengevaluasi pelaksanaan asuhan keperawatan yang telah diberikan.
6. Mengidentifikasi masalah, hambatan, dan kebutuhan tindak lanjut pasien.
7. Meningkatkan akuntabilitas dan tanggung jawab profesional perawat.
8. Menjadi sarana pembelajaran klinis dan refleksi praktik keperawatan.

Secara rinci tujuan utama pelaksanaan pre-conference adalah untuk menjamin perencanaan asuhan keperawatan yang terarah, aman, dan efektif. Melalui pre-conference, tim keperawatan memiliki pemahaman yang sama mengenai kondisi pasien, prioritas masalah keperawatan, serta rencana tindakan yang akan dilaksanakan selama satu shift. Hal ini membantu perawat bekerja secara terkoordinasi dan mengurangi risiko kesalahan pelayanan.

Tujuan bedside handover adalah menjamin kesinambungan asuhan keperawatan melalui penyampaian informasi klinis yang akurat dan lengkap antar shift. Overan bertujuan memastikan bahwa perawat shift baru memahami kondisi terkini pasien, tindakan yang telah dilakukan, respons pasien, serta rencana tindak lanjut yang belum terselesaikan.

Dengan demikian, overan berperan penting dalam menjaga keselamatan pasien dan mutu pelayanan keperawatan. Pre-conference dan overan juga bertujuan meningkatkan efektivitas komunikasi dan kerja sama tim keperawatan. Komunikasi yang jelas dan terstruktur membantu membangun koordinasi yang baik antar perawat serta memperkuat akuntabilitas dalam pelaksanaan asuhan keperawatan. Selain itu, kegiatan ini mendukung penerapan praktik keperawatan profesional yang berbasis standar.

Post-conference bertujuan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan asuhan keperawatan yang telah diberikan selama satu shift. Evaluasi ini mencakup pencapaian tujuan keperawatan, efektivitas intervensi, serta kendala yang dihadapi selama pelayanan. Hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan dan pengembangan pelayanan keperawatan secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, tujuan pelaksanaan pre-conference, bedside handover, dan post-conference adalah mendukung tercapainya mutu pelayanan keperawatan yang optimal, meningkatkan keselamatan pasien, serta memperkuat fungsi manajemen keperawatan sesuai prinsip profesionalisme dan ketentuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

### **C. Syarat Pelaksanaan**

Agar *pre*, *bedside handover* dan *post conference bedside handover* dapat berjalan efektif dan optimal, beberapa syarat pelaksanaan perlu dipenuhi, yaitu:

1. Komitmen tim keperawatan, termasuk kepala ruangan dan perawat pelaksana.
2. Kehadiran seluruh perawat yang bertugas pada shift terkait.
3. Ketersediaan waktu yang cukup, meskipun bersifat singkat dan terfokus.
4. Lingkungan yang kondusif, aman, dan tidak mengganggu privasi pasien.
5. Dokumentasi asuhan keperawatan yang lengkap dan mutakhir.
6. Penggunaan komunikasi terstruktur, seperti SBAR, ISBAR dan ISOBAR.
7. Kepemimpinan yang efektif, khususnya dari perawat penanggung jawab asuhan (PPJA) atau PJ Shift.

Pelaksanaan pre conference, bedside handover dan post conference keperawatan memerlukan beberapa syarat agar dapat berjalan secara efektif dan bermutu. Salah satu syarat utama adalah kesiapan sumber daya manusia, khususnya perawat yang terlibat dalam pelayanan. Perawat harus memiliki kompetensi komunikasi, pemahaman kondisi pasien, serta tanggung jawab profesional terhadap asuhan yang diberikan.

Syarat berikutnya adalah tersedianya informasi pasien yang lengkap, akurat, dan terkini. Informasi ini meliputi data identitas pasien, kondisi klinis, diagnosis keperawatan, intervensi yang telah dilakukan, serta rencana tindak lanjut. Kelengkapan informasi menjadi faktor kunci dalam mencegah kesalahan asuhan dan menjamin kesinambungan pelayanan.

Aspek etika dan kerahasiaan pasien juga merupakan syarat penting dalam pelaksanaan *overan* dan *conference*. Informasi pasien harus disampaikan secara profesional, terbatas pada kepentingan pelayanan, serta menjaga privasi dan martabat pasien. Hal ini sejalan dengan prinsip etika keperawatan dan tanggung jawab hukum perawat. Sarana dan lingkungan yang mendukung turut menjadi syarat pelaksanaan kegiatan ini.

*Overan* dan *conference* sebaiknya dilakukan di tempat yang kondusif, minim gangguan, serta memungkinkan komunikasi yang jelas antar anggota tim. Lingkungan yang tidak mendukung dapat menghambat konsentrasi dan akurasi informasi. Selain itu, dokumentasi yang sistematis dan terstandar menjadi syarat penting dalam pelaksanaan *overan* dan *conference*. Dokumentasi berfungsi sebagai bukti akuntabilitas pelayanan dan sumber informasi tertulis yang dapat ditelusuri kembali dalam proses asuhan keperawatan.

## **D. Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

*Pre conference* dilaksanakan sebelum perawat memulai pelayanan pada awal shift, biasanya di nurse station atau ruang yang telah ditentukan. Waktu pelaksanaan berkisar antara 5–10 menit, tergantung kompleksitas kondisi pasien. Pelaksanaan bedside handover dilakukan langsung di sisi tempat tidur pasien dengan memperhatikan prinsip keselamatan, etika, dan privasi pasien. *Post conference* dilaksanakan setelah pelayanan keperawatan selesai pada akhir shift, dengan durasi yang relatif singkat namun fokus. Tempat pelaksanaan dapat dilakukan di *nurse station*.

## E. Alur dan Tahapan Pelaksanaan

### 1. Alur *Pre Conference*

Tahapan pelaksanaan pre conference meliputi:

- a. Pembukaan oleh ketua tim atau perawat penanggung jawab.
- b. Penyampaian kondisi umum pasien.
- c. Pembahasan rencana asuhan keperawatan.
- d. Identifikasi masalah potensial dan risiko keselamatan pasien.
- e. Pembagian tugas perawat secara jelas.
- f. Penegasan tanggung jawab dan target pelayanan.

### 2. Alur *Bedside handover*

#### a. Tahap Persiapan

- Perawat shift sebelumnya dan perawat shift berikutnya hadir tepat waktu
- Memastikan identitas pasien (nama, nomor rekam medis, gelang identitas)
- Mempersiapkan dokumen keperawatan (catatan asuhan, CPPT, lembar observasi)
- Meninjau kondisi umum pasien sebelum masuk ke kamar
- Menjaga privasi pasien (menutup tirai, meminta izin pasien/keluarga)
- Menentukan metode komunikasi (ISBAR/ISOBAR)

#### b. Tahap Pembukaan di Samping Tempat Tidur Pasien

- Memberi salam dan memperkenalkan perawat kepada pasien dan keluarga
- Menjelaskan tujuan pelaksanaan bedside handover
- Memastikan pasien dalam kondisi nyaman dan siap mengikuti handover
- Mengonfirmasi identitas pasien secara langsung

#### c. Tahap Penyampaian Informasi Pasien (*Inti Handover*)

Disampaikan secara sistematis, singkat, dan jelas:

- Identitas dan Kondisi Umum (Nama, usia, diagnosis medis utama, Tingkat kesadaran dan kondisi umum pasien)
  - Masalah Keperawatan (Diagnosa keperawatan utama dan aktual, Masalah prioritas yang masih berlangsung)
  - Intervensi dan Tindakan Keperawatan (Tindakan yang sudah dilakukan, Respons pasien terhadap intervensi, Terapi medis yang sedang berjalan (infus, obat, oksigen)
  - Observasi dan Monitoring (Tanda-tanda vital terakhir, Perubahan kondisi pasien selama shift, Hasil pemeriksaan penunjang penting (jika ada)
  - Risiko dan Keselamatan Pasien (Risiko jatuh, risiko infeksi, risiko dekubitus, Alat medis terpasang (kateter, drain, NGT), Status keamanan dan pencegahan cedera)
- d. Tahap Pelibatan Pasien dan Keluarga
- Memberikan kesempatan pasien/keluarga untuk menyampaikan keluhan
  - Mengklarifikasi informasi yang belum jelas
  - Memastikan pasien memahami rencana perawatan selanjutnya
  - Menghargai hak dan partisipasi pasien
- e. Tahap Klarifikasi dan Konfirmasi
- Perawat penerima mengajukan pertanyaan bila ada informasi yang belum jelas
  - Konfirmasi rencana tindakan dan prioritas perawatan shift berikutnya
  - Menyepakati hal-hal yang perlu diwaspadai
- f. Tahap Penutupan
- Menyimpulkan kondisi dan rencana perawatan pasien
  - Mengucapkan terima kasih kepada pasien dan keluarga



- Menjaga kembali privasi dan kenyamanan pasien
  - Melanjutkan handover ke pasien berikutnya
- g. Tahap Dokumentasi
- Mencatat pelaksanaan handover dalam dokumentasi keperawatan
  - Menandatangani atau mengisi kolom serah terima shift
  - Memastikan seluruh informasi terdokumentasi lengkap dan akurat

### 3. Alur *Post Conference*

*Post conference* dilaksanakan setelah perawat menyelesaikan pemberian asuhan keperawatan dalam satu shift dinas sebagai bentuk evaluasi dan refleksi terhadap praktik keperawatan yang telah dilakukan. Kegiatan ini dipimpin oleh perawat penanggung jawab asuhan atau ketua tim dengan melibatkan seluruh perawat yang bertugas pada shift tersebut untuk menjamin keseragaman informasi dan kesinambungan asuhan keperawatan.

Tahapan *post conference* meliputi:

- a. Review singkat pelaksanaan asuhan keperawatan
- Tahap pertama dalam *post conference* adalah pelaksanaan review singkat terhadap asuhan keperawatan yang telah diberikan kepada pasien. Perawat pelaksana menyampaikan secara sistematis tindakan keperawatan yang telah dilakukan, respons pasien terhadap intervensi, serta perubahan kondisi klinis yang terjadi selama dinas. Review ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh intervensi telah dilaksanakan sesuai dengan rencana asuhan keperawatan dan standar operasional prosedur yang berlaku.
- b. Evaluasi pencapaian tujuan keperawatan
- Tahap kedua adalah evaluasi pencapaian tujuan keperawatan. Perawat bersama tim menilai sejauh mana tujuan dan kriteria hasil yang telah ditetapkan dalam

rencana asuhan keperawatan dapat dicapai. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kondisi aktual pasien dengan indikator hasil yang telah dirumuskan, sehingga perawat dapat menentukan apakah tujuan keperawatan telah tercapai, tercapai sebagian, atau belum tercapai.

c. Identifikasi hambatan dan masalah yang terjadi

Tahap ketiga meliputi identifikasi hambatan dan masalah yang terjadi selama pelaksanaan asuhan keperawatan. Perawat mengemukakan kendala yang dihadapi, baik yang berkaitan dengan kondisi pasien, ketersediaan sumber daya, koordinasi tim, maupun faktor lingkungan pelayanan. Identifikasi ini dilakukan secara objektif dan konstruktif sebagai dasar perbaikan pelayanan keperawatan pada periode dinas berikutnya.

d. Diskusi tindak lanjut dan rencana perawatan selanjutnya

Tahap keempat adalah diskusi mengenai tindak lanjut dan rencana perawatan selanjutnya. Perawat bersama tim menyepakati penyesuaian atau modifikasi rencana asuhan keperawatan berdasarkan hasil evaluasi dan masalah yang ditemukan. Diskusi ini bertujuan untuk memastikan bahwa rencana perawatan selanjutnya bersifat realistis, berkesinambungan, dan berorientasi pada kebutuhan pasien.

e. Persiapan bedside handover kepada perawat shift berikutnya

Tahap terakhir dalam post conference adalah persiapan bedside handover kepada perawat pada shift berikutnya. Perawat merangkum informasi penting terkait kondisi pasien, masalah keperawatan yang belum terselesaikan, intervensi yang perlu dilanjutkan, serta perhatian khusus yang harus disampaikan. Persiapan ini dilakukan untuk menjamin kelancaran proses serah terima, menjaga keselamatan pasien, dan memastikan kontinuitas asuhan keperawatan antarshift.

Secara keseluruhan, alur pre-conference, overan, dan post-conference membentuk siklus manajemen keperawatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Penerapan alur ini secara konsisten mendukung praktik keperawatan yang profesional dan berkesinambungan.

## **F. Materi yang Disampaikan oleh Perawat Pelaksana dalam Conference**

Materi yang disampaikan dalam *pre* dan *post conference* harus bersifat relevan, sistematis, dan berfokus pada kebutuhan pasien, meliputi:

1. Identitas pasien dan diagnosis medis.
2. Masalah keperawatan utama dan prioritas.
3. Kondisi klinis terkini pasien.
4. Tindakan keperawatan yang telah dan akan dilakukan.
5. Respons pasien terhadap tindakan keperawatan.
6. Risiko keselamatan pasien (jatuh, infeksi, nyeri, dll.).
7. Rencana tindak lanjut dan edukasi pasien.
8. Hal-hal khusus yang perlu diperhatikan pada shift berikutnya.

Secara rinci dijelaskan materi yang disampaikan oleh perawat pelaksana dalam pre-conference meliputi kondisi umum pasien, tingkat ketergantungan, serta masalah keperawatan yang menjadi prioritas. Informasi ini menjadi dasar dalam perencanaan asuhan dan pembagian tugas perawat selama satu shift. Selain itu, perawat pelaksana menyampaikan rencana intervensi keperawatan yang akan dilakukan, termasuk tindakan mandiri, kolaboratif, dan edukatif. Penyampaian rencana ini bertujuan memastikan bahwa seluruh anggota tim memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam memberikan asuhan keperawatan. Dalam post-conference, materi yang disampaikan berfokus pada hasil pelaksanaan asuhan keperawatan. Perawat pelaksana melaporkan intervensi yang telah dilakukan,

respons pasien, serta pencapaian tujuan keperawatan. Informasi ini menjadi bahan evaluasi dan refleksi tim keperawatan. Perawat juga menyampaikan kendala atau masalah yang dihadapi selama pelayanan, baik yang bersifat klinis maupun manajerial. Diskusi mengenai kendala ini bertujuan menemukan solusi dan strategi perbaikan untuk pelayanan berikutnya.

Dengan demikian, materi yang disampaikan oleh perawat pelaksana dalam conference harus bersifat objektif, sistematis, dan relevan dengan asuhan keperawatan. Penyampaian materi yang baik mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan peningkatan mutu pelayanan keperawatan secara berkelanjutan.

## G. Latihan

Latihan pada bab ini disusun untuk membantu mahasiswa menguji pemahaman konseptual dan kemampuan aplikatif terkait pelaksanaan *pre conference*, *bedside handover*, dan *post conference* dalam praktik keperawatan profesional. Bentuk latihan meliputi soal pilihan ganda dan soal kasus/pemecahan masalah dalam bentuk esai. Melalui latihan ini, mahasiswa diharapkan mampu mengintegrasikan teori dengan praktik klinik secara sistematis, kritis, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar pelayanan keperawatan. Setelah mengerjakan latihan pada bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan konsep dan tujuan *pre conference*, *bedside handover*, dan *post conference*.
2. Mengidentifikasi peran dan tanggung jawab perawat dalam setiap tahapan conference.
3. Menganalisis permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan conference keperawatan.
4. Menerapkan alur *pre conference*, *bedside handover*, dan *post conference* secara tepat dalam praktik profesi ners.

### Soal Pilihan Ganda

1. Pada awal dinas pagi, PPJA memimpin *pre conference*. Salah satu pasien tiba-tiba mengalami penurunan kesadaran ringan pada malam hari dan membutuhkan observasi ketat. Fokus utama *pre conference* yang paling tepat dalam kasus tersebut adalah ...
  - A. Menyampaikan laporan umum kondisi seluruh pasien
  - B. Membagi jumlah pasien secara merata kepada perawat
  - C. Menetapkan prioritas asuhan berdasarkan risiko dan kondisi terkini pasien
  - D. Mengingatkan perawat untuk melengkapi dokumentasi
  - E. Menyampaikan aturan umum ruangan
2. *Pre conference* tidak dilaksanakan secara optimal sehingga terjadi tumpang tindih intervensi keperawatan. Fungsi *pre conference* yang paling relevan untuk mencegah masalah tersebut adalah
  - A. Media penyampaian informasi administrative
  - B. Sarana koordinasi dan penyelarasan rencana asuhan
  - C. Forum evaluasi hasil asuhan keperawatan
  - D. Wadah supervisi personal perawat
  - E. Bentuk laporan akhir dinas
3. Dalam *bedside handover*, pasien berada dalam kondisi sadar dan kooperatif. Pendekatan paling tepat sesuai prinsip praktik profesi Ners adalah ...
  - A. Menyampaikan informasi klinis secara singkat tanpa melibatkan pasien
  - B. Menjelaskan kondisi pasien dengan istilah medis lengkap
  - C. Melibatkan pasien untuk klarifikasi kondisi dan rencana perawatan
  - D. Menunda handover hingga pasien tidak berada di tempat
  - E. Menyampaikan laporan hanya berdasarkan dokumentasi

4. Seorang pasien memiliki risiko jatuh tinggi dan baru dipindahkan tempat tidur. Informasi paling prioritas yang harus disampaikan saat bedside handover adalah ...
  - A. Riwayat penyakit kronis
  - B. Hasil pemeriksaan laboratorium
  - C. Risiko keselamatan pasien dan intervensi pencegahannya
  - D. Jadwal kunjungan keluarga
  - E. Rencana edukasi kesehatan
5. Dalam post conference, ditemukan bahwa tujuan keperawatan belum tercapai meskipun intervensi telah dilaksanakan. Tindak lanjut paling tepat sesuai prinsip evaluasi asuhan keperawatan adalah ...
  - A. Melanjutkan rencana asuhan tanpa perubahan
  - B. Menghentikan intervensi yang telah dilakukan
  - C. Mengevaluasi kembali diagnosis dan menyesuaikan rencana asuhan
  - D. Menyerahkan evaluasi sepenuhnya kepada profesi lain
  - E. Mendokumentasikan hasil tanpa diskusi tim
6. Post conference dilakukan secara rutin, namun tidak menghasilkan perbaikan mutu pelayanan. Aspek paling krusial yang perlu ditingkatkan adalah ...
  - A. Durasi pelaksanaan post conference
  - B. Jumlah peserta conference
  - C. Analisis masalah dan kejelasan tindak lanjut
  - D. Lokasi pelaksanaan
  - E. Format laporan tertulis
7. Hasil evaluasi pada post conference menunjukkan adanya masalah keperawatan yang belum terselesaikan. Pemanfaatan hasil post conference yang paling tepat adalah
  - A. Disimpan sebagai arsip unit
  - B. Disampaikan secara informal kepada perawat berikutnya

- C. Menjadi dasar informasi utama pada bedside handover shift selanjutnya
  - D. Digunakan untuk evaluasi bulanan saja
  - E. Dilaporkan kepada manajemen tanpa tindak lanjut klinis
8. Keterkaitan antara pre conference dan bedside handover dalam praktik profesi Ners ditunjukkan oleh ...
- A. Kesamaan waktu pelaksanaan
  - B. Kesamaan format dokumentasi
  - C. Konsistensi rencana asuhan yang disepakati dan disampaikan antarshift
  - D. Pelaksanaan di lokasi yang sama
  - E. Keterlibatan pimpinan ruangan
9. Pelaksanaan pre conference, bedside handover, dan post conference secara konsisten akan berdampak langsung pada ...
- A. Peningkatan administrasi keperawatan
  - B. Efisiensi jadwal kerja perawat
  - C. Keselamatan pasien dan kesinambungan asuhan keperawatan
  - D. Pengurangan beban kerja perawat
  - E. Penurunan kebutuhan supervisi klinik
10. Dalam konteks Profesi Ners, conference keperawatan mencerminkan kompetensi perawat terutama pada aspek...
- A. Keterampilan teknis klinis semata
  - B. Kepatuhan terhadap kebijakan rumah sakit
  - C. Komunikasi klinis profesional dan manajemen asuhan keperawatan
  - D. Pengelolaan logistik unit
  - E. Administrasi pelayanan kesehatan

## Soal Essai Analitik

1. Pada awal dinas pagi di ruang rawat inap, ketua tim langsung membagi tugas perawat tanpa melaksanakan pre conference. Selama dinas berlangsung, terjadi ketidaksinkronan tindakan keperawatan dan beberapa intervensi tidak terdokumentasi dengan baik.

Pertanyaan:

- a. Identifikasilah masalah utama yang muncul akibat tidak dilaksanakannya pre conference.
  - b. Jelaskan peran pre conference dalam mencegah permasalahan tersebut.
  - c. Uraikan langkah-langkah pre conference yang seharusnya dilakukan oleh ketua tim.
- 
2. Saat pergantian shift sore ke malam, bedside handover dilakukan di nurse station tanpa melibatkan pasien. Setelah pergantian shift, perawat jaga malam tidak mengetahui adanya perubahan kondisi pasien yang memerlukan pemantauan ketat.

Pertanyaan:

- a. Analisis kesalahan dalam pelaksanaan bedside handover pada kasus tersebut.
- b. Jelaskan dampak bedside handover yang tidak sesuai standar terhadap keselamatan pasien.
- c. Uraikan prinsip bedside handover yang benar dalam praktik keperawatan profesional.

## Kunci Jawaban

- |      |       |
|------|-------|
| 1. C | 6. C  |
| 2. B | 7. C  |
| 3. C | 8. C  |
| 4. C | 9. C  |
| 5. C | 10. C |



## H. Rangkuman Materi

Bab ini membahas secara komprehensif konsep, tujuan, dan pelaksanaan *pre conference*, *bedside handover*, dan *post conference* sebagai bagian integral dari manajemen asuhan keperawatan di unit ruang rawat fasilitas pelayanan kesehatan. Ketiga kegiatan ini dipahami sebagai mekanisme komunikasi profesional yang terstruktur untuk menjamin kesinambungan asuhan, keselamatan pasien, serta mutu pelayanan keperawatan. *Pre conference*, *bedside handover*, dan *post conference* merupakan implementasi nyata dari fungsi pengarahan dan pengendalian dalam manajemen keperawatan, yang bertujuan menyelaraskan persepsi tim, mengoordinasikan tindakan keperawatan, serta memastikan bahwa setiap perawat memahami peran, tanggung jawab, dan kondisi klinis pasien yang menjadi tanggung jawabnya.

*Pre conference* didefinisikan sebagai pertemuan awal tim keperawatan sebelum dinas dimulai untuk membahas kondisi pasien, rencana asuhan keperawatan, pembagian tugas, serta prioritas pelayanan. *Bedside handover* merupakan proses serah terima pasien yang dilakukan di sisi tempat tidur pasien dengan melibatkan perawat yang menyerahkan dan menerima tanggung jawab asuhan, serta, bila memungkinkan, melibatkan pasien dan keluarga. *Post conference* adalah pertemuan evaluatif yang dilakukan setelah dinas berakhir untuk membahas pelaksanaan asuhan keperawatan, kendala yang dihadapi, capaian target pelayanan, serta rencana tindak lanjut. Ketiga kegiatan ini memiliki tujuan utama untuk meningkatkan efektivitas komunikasi, memperkuat koordinasi tim, menjamin kesinambungan asuhan, meminimalkan kesalahan pelayanan, serta meningkatkan keselamatan dan kepuasan pasien.

Pelaksanaan *pre conference*, *bedside handover*, dan *post conference* harus memenuhi sejumlah persyaratan agar berjalan efektif dan sesuai standar profesional. Persyaratan tersebut meliputi keterlibatan aktif seluruh anggota tim keperawatan, kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP), penggunaan bahasa yang baku dan profesional, serta penghormatan terhadap prinsip etika dan kerahasiaan pasien. *Bedside handover* harus dilakukan dengan menjaga privasi dan martabat pasien, menggunakan komunikasi yang jelas, singkat, dan terstruktur, serta memverifikasi informasi klinis yang disampaikan. Waktu pelaksanaan umumnya dilakukan pada saat pergantian shift, sedangkan tempat pelaksanaan *pre conference* dan *post conference* berada di ruang diskusi atau *nurse station*, sementara *bedside handover* dilakukan di sisi tempat tidur pasien.

Alur dan tahapan pelaksanaan dimulai dari *pre conference* yang mencakup pembukaan oleh ketua tim atau kepala ruangan, penyampaian informasi umum unit, pembahasan kondisi pasien, penetapan prioritas, serta pembagian tugas perawat. Tahap berikutnya adalah *bedside handover* yang dilakukan secara sistematis dengan menyampaikan identitas pasien, diagnosis keperawatan, kondisi terkini, intervensi yang telah dan akan dilakukan, hasil pemantauan, serta masalah potensial yang perlu diantisipasi. Tahap terakhir adalah *post conference* yang mencakup evaluasi pelaksanaan asuhan, pembahasan kendala dan insiden, refleksi kinerja tim, serta penyusunan rencana perbaikan dan tindak lanjut. Seluruh tahapan ini harus terdokumentasi dengan baik sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu pelayanan keperawatan.

Materi yang disampaikan oleh perawat pelaksana dalam setiap conference harus mencakup data klinis pasien yang relevan, rencana asuhan keperawatan, hasil intervensi, respon pasien terhadap tindakan, serta masalah atau risiko yang perlu mendapat perhatian khusus. Penyampaian materi harus dilakukan secara ringkas, akurat, dan berbasis data untuk menghindari kesalahan interpretasi. Dengan pelaksanaan pre conference, bedside handover, dan post conference yang terstruktur dan konsisten, pelayanan keperawatan dapat berlangsung secara efektif, aman, dan berkesinambungan. Bab ini menegaskan bahwa ketiga kegiatan tersebut bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan instrumen manajerial dan klinis yang strategis dalam menjamin mutu asuhan keperawatan, keselamatan pasien, serta profesionalisme tenaga keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan.

## **Glosarium**

|        |                                                                                              |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPPT   | : Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi                                                   |
| ISBAR  | : <i>Identification, Situation, Background, Assessment, Recommendation, dan Observation.</i> |
| ISOBAR | : <i>Identification, Situation, Observation ,Background, Assessment dan Recommendation</i>   |
| PPJA   | : Perawat Penanggung Jawab Asuhan                                                            |

# BAB 4

## Ronde Keperawatan

### Pendahuluan

Pelayanan keperawatan profesional menuntut terselenggaranya asuhan keperawatan yang bermutu, aman, berkesinambungan, dan berorientasi pada kebutuhan pasien. Kompleksitas masalah kesehatan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatnya tuntutan mutu pelayanan menempatkan perawat sebagai tenaga profesional yang tidak hanya berperan sebagai pelaksana asuhan, tetapi juga sebagai pengelola pelayanan keperawatan. Dalam konteks manajemen keperawatan, diperlukan suatu mekanisme yang mampu menjamin pengambilan keputusan klinis yang tepat, meningkatkan komunikasi tim, serta memastikan kesinambungan dan mutu asuhan keperawatan.

Ronde keperawatan merupakan salah satu strategi manajerial dan klinis yang berperan penting dalam peningkatan mutu pelayanan keperawatan. Ronde keperawatan dilaksanakan melalui diskusi terstruktur dan sistematis yang melibatkan perawat pelaksana, perawat penanggung jawab, serta pimpinan keperawatan untuk membahas masalah keperawatan pasien secara langsung di area perawatan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis perawat, memperkuat penerapan proses keperawatan, serta menjamin keselamatan dan kepuasan pasien. Pembahasan mengenai ronde keperawatan dalam buku ajar manajemen keperawatan menjadi penting sebagai upaya membekali mahasiswa dan praktisi keperawatan dengan pemahaman konseptual dan aplikatif.

Pemahaman yang komprehensif tentang konsep, tujuan, tahapan, dan peran ronde keperawatan diharapkan mampu mendukung pengembangan kompetensi manajerial perawat serta berkontribusi terhadap peningkatan mutu asuhan keperawatan yang profesional dan berkelanjutan.

## **CPMK dan Sub-CPMK**

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) pada bab ini adalah mahasiswa mampu menganalisis dan menerapkan konsep ronde keperawatan secara komprehensif dan profesional dalam praktik pelayanan keperawatan, meliputi pemahaman definisi, tujuan, jenis, peran dan tanggung jawab, serta tahapan pelaksanaan ronde keperawatan sesuai standar asuhan keperawatan dan prinsip keselamatan pasien.

Adapun Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK) dirumuskan sebagai berikut :

1. Mahasiswa mampu menjelaskan dan merumuskan konsep serta definisi ronde keperawatan secara tepat berdasarkan teori manajemen keperawatan dan praktik klinik profesional.
2. Mahasiswa mampu menganalisis tujuan pelaksanaan ronde keperawatan dalam meningkatkan mutu asuhan keperawatan, keselamatan pasien, komunikasi tim, dan pengambilan keputusan klinis.
3. Mahasiswa mampu mengklasifikasikan dan membedakan jenis-jenis ronde keperawatan sesuai tujuan, waktu pelaksanaan, serta peran tenaga keperawatan dalam pelayanan kesehatan.
4. Mahasiswa mampu menganalisis peran dan tanggung jawab kepala ruangan, perawat primer, perawat pelaksana, dan mahasiswa keperawatan dalam pelaksanaan ronde keperawatan secara kolaboratif dan etis.
5. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan tahapan pelaksanaan ronde keperawatan secara sistematis mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi sesuai standar prosedur operasional (SPO) keperawatan.

Untuk mendukung pencapaian CPMK dan Sub-CPMK tersebut, berikut disajikan petunjuk pembelajaran yang perlu diperhatikan agar mahasiswa dapat menguasai materi yang dibahas dalam bab ini secara optimal.

- Mahasiswa membaca dan memahami CPMK, Sub-CPMK, serta pendahuluan sebagai acuan pembelajaran.
- Mahasiswa membaca materi pokok pembelajaran secara sistematis dan cermat.
- Mahasiswa mencermati konsep utama, istilah kunci, dan definisi penting ronde keperawatan.
- Mahasiswa mengaitkan materi dengan penerapan fungsi manajemen dalam praktik profesional.
- Mahasiswa melakukan diskusi untuk memperdalam pemahaman dan berpikir kritis.
- Mahasiswa mengerjakan tugas, latihan, atau refleksi pada akhir bab.
- Mahasiswa memanfaatkan sumber belajar tambahan yang relevan.

# Uraian Materi

---

## A. Definisi Ronde Keperawatan

Ronde keperawatan merupakan suatu metode manajemen pelayanan keperawatan yang dilakukan secara sistematis dengan melibatkan perawat dan pasien untuk membahas kondisi pasien secara langsung di area perawatan. Ronde keperawatan adalah suatu kegiatan terstruktur yang dilakukan oleh perawat secara berkelompok dengan mengunjungi pasien secara langsung untuk membahas kondisi pasien, masalah keperawatan, intervensi yang telah dan akan dilakukan, serta evaluasi hasil asuhan keperawatan (Nursalam, 2013). Ronde keperawatan melibatkan proses komunikasi profesional, diskusi klinis, dan pengambilan keputusan berbasis bukti dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Ronde keperawatan bertujuan untuk mengintegrasikan proses keperawatan dengan pendekatan komunikasi terapeutik, pengambilan keputusan klinis, serta peningkatan mutu asuhan keperawatan (Kozier et al, 2004). Dalam konteks praktik profesional, ronde keperawatan menjadi sarana pembelajaran klinik dan supervisi yang efektif.

Secara konseptual, ronde keperawatan tidak hanya berfokus pada evaluasi kondisi pasien, tetapi juga menitikberatkan pada penalaran klinis perawat dalam mengidentifikasi masalah keperawatan, menentukan prioritas tindakan, serta mengevaluasi hasil asuhan yang telah diberikan. Melalui ronde, perawat dapat mengaitkan data objektif dan subjektif pasien dengan teori keperawatan yang relevan secara langsung di lapangan.

Ronde keperawatan juga dipahami sebagai bentuk komunikasi profesional antar anggota tim keperawatan yang terstruktur dan terencana. Kegiatan ini memungkinkan terjadinya diskusi terbuka, klarifikasi rencana asuhan, serta penyamaan persepsi antar perawat terkait kondisi dan kebutuhan pasien. Dengan demikian, ronde keperawatan berperan penting dalam mencegah kesalahan komunikasi dan meningkatkan keselamatan pasien.

Dari sudut pandang manajemen keperawatan, ronde keperawatan merupakan instrumen kontrol dan evaluasi mutu pelayanan. Kepala ruangan atau perawat penanggung jawab pelayanan dapat mengamati langsung penerapan standar asuhan, kepatuhan terhadap prosedur operasional, serta kompetensi perawat dalam memberikan asuhan keperawatan. Hal ini menjadikan ronde sebagai bagian integral dari fungsi pengendalian mutu.

Sebagai contoh, di ruang rawat inap penyakit dalam, kepala ruangan bersama perawat primer melakukan ronde keperawatan pada pasien dengan gagal jantung. Tim keperawatan mendiskusikan hasil pengkajian terbaru, respons pasien terhadap terapi, serta rencana intervensi lanjutan. Diskusi dilakukan di sisi tempat tidur pasien dengan tetap menjaga etika, privasi, dan keselamatan pasien.

## **B. Tujuan Ronde Keperawatan**

### **1. Tujuan Umum**

Meningkatkan mutu asuhan keperawatan melalui pendekatan kolaboratif, sistematis, dan berfokus pada kebutuhan pasien

### **2. Tujuan Khusus**

Adapun tujuan khusus ronde keperawatan antara lain:

- a. Meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan penalaran klinis perawat. Diskusi kasus yang dilakukan



secara langsung memungkinkan perawat mengaitkan teori dengan praktik, mengidentifikasi masalah aktual dan potensial, serta menentukan prioritas asuhan berdasarkan kondisi pasien yang nyata. Proses ini mendukung pembelajaran klinik yang berkelanjutan.

- b. Memperkuat komunikasi dan kolaborasi dalam tim keperawatan. Melalui pertukaran informasi yang terstruktur, setiap anggota tim memiliki pemahaman yang sama mengenai kondisi pasien, rencana asuhan, dan pembagian peran. Hal ini berkontribusi terhadap kesinambungan pelayanan dan pencegahan kesalahan klinis.
- c. Meningkatkan keselamatan dan kepuasan pasien. Keterlibatan pasien dalam ronde memungkinkan pasien memperoleh penjelasan langsung mengenai kondisi dan rencana perawatan, sehingga meningkatkan rasa aman, kepercayaan, dan partisipasi pasien dalam proses penyembuhan. Contoh aplikatif, pada pasien pasca operasi, ronde keperawatan dilakukan untuk mengevaluasi manajemen nyeri, risiko infeksi, dan mobilisasi dini. Hasil ronde menunjukkan perlunya penyesuaian intervensi nyeri nonfarmakologis dan edukasi ulang kepada pasien mengenai latihan pernapasan, sehingga luaran keperawatan dapat tercapai secara optimal.

### **C. Prinsip Ronde Keperawatan**

Pelaksanaan ronde keperawatan harus berlandaskan pada seperangkat prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam menjamin mutu pelayanan, keselamatan pasien, serta profesionalisme praktik keperawatan. Prinsip-prinsip tersebut berfungsi sebagai kerangka etik dan operasional agar ronde keperawatan tidak hanya menjadi kegiatan rutin, tetapi juga menjadi instrumen klinis dan manajerial yang bermakna

dalam peningkatan kualitas asuhan keperawatan. Adapun prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut:

1. Prinsip berfokus pada pasien, yaitu seluruh diskusi dan keputusan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dan keselamatan pasien. Setiap informasi klinis yang dibahas, intervensi yang direncanakan, serta evaluasi hasil asuhan harus mempertimbangkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual pasien. Selain itu, prinsip ini juga menekankan bahwa keselamatan pasien menjadi prioritas utama, sehingga setiap keputusan yang diambil dalam ronde keperawatan harus berorientasi pada pencegahan risiko, pengurangan potensi bahaya, dan peningkatan kualitas hidup pasien
2. Prinsip profesionalisme, yang menekankan sikap ilmiah, etika, dan tanggung jawab perawat. Perawat wajib menyampaikan informasi berdasarkan data yang akurat, bukti ilmiah, serta hasil pengkajian yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, perawat harus menjunjung tinggi kode etik keperawatan, menjaga kerahasiaan pasien, serta menunjukkan integritas dan komitmen terhadap mutu pelayanan. Prinsip ini juga mengharuskan perawat untuk bersikap objektif, terbuka terhadap masukan, dan siap melakukan refleksi serta perbaikan praktik keperawatan secara berkelanjutan.
3. Prinsip komunikasi efektif, meliputi keterbukaan, saling menghargai, dan penggunaan bahasa profesional. Setiap anggota tim keperawatan harus menyampaikan pendapat, temuan klinis, dan rekomendasi secara sistematis, ringkas, dan menggunakan bahasa profesional yang mudah dipahami. Komunikasi harus berlangsung dua arah dan bersifat konstruktif, sehingga mampu mendorong diskusi ilmiah, memperkuat koordinasi tim, serta meminimalkan kesalahpahaman. Penggunaan model komunikasi terstruktur, seperti SBAR

atau ISBAR, dianjurkan untuk meningkatkan akurasi dan kelengkapan informasi yang disampaikan.

4. Prinsip kolaborasi, yaitu keterlibatan aktif seluruh anggota tim keperawatan dan tenaga kesehatan lain yang terkait dengan pasien. Setiap anggota tim memiliki peran dan kontribusi yang setara dalam menyampaikan informasi, memberikan masukan, serta merumuskan rencana tindak lanjut. Prinsip ini menekankan pentingnya kerja sama lintas profesi, saling menghargai kompetensi masing-masing, serta pengambilan keputusan secara kolektif untuk mencapai hasil asuhan yang optimal bagi pasien.
5. Prinsip keselamatan pasien, dengan mengutamakan pencegahan kesalahan dan insiden keselamatan pasien. Setiap temuan risiko, ketidaksesuaian prosedur, atau potensi bahaya yang teridentifikasi selama ronde harus segera didiskusikan dan ditindaklanjuti secara sistematis. Prinsip ini juga menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap standar operasional prosedur, pedoman klinis, serta kebijakan keselamatan pasien yang berlaku di fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan demikian, ronde keperawatan berfungsi sebagai sarana deteksi dini risiko dan sebagai mekanisme perbaikan mutu pelayanan secara berkelanjutan.

## **D. Jenis-Jenis Ronde Keperawatan**

Ronde keperawatan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan tujuan, fokus pembahasan, serta pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya. Klasifikasi ini bertujuan untuk memberikan kerangka konseptual dan operasional bagi perawat dan manajer keperawatan dalam memilih bentuk ronde yang paling sesuai dengan kebutuhan pelayanan, kondisi pasien, serta tujuan pengembangan mutu asuhan keperawatan. Secara umum, ronde keperawatan dikelompokkan menjadi ronde keperawatan klinis, ronde

keperawatan manajerial, ronde keperawatan edukatif, dan ronde keperawatan multidisiplin

1. **Ronde Keperawatan Klinis**, yang berfokus pada pembahasan masalah keperawatan dan kondisi klinis pasien. Ronde ini bertujuan untuk meningkatkan ketepatan pengkajian, penetapan diagnosis keperawatan, perencanaan intervensi, serta evaluasi hasil asuhan keperawatan. Dalam ronde keperawatan klinis, perawat mendiskusikan kondisi aktual pasien, respons pasien terhadap intervensi yang telah diberikan, serta masalah keperawatan yang masih berlangsung. Ronde ini juga berfungsi sebagai sarana untuk mengidentifikasi risiko keselamatan pasien, menentukan prioritas masalah keperawatan, dan merumuskan rencana tindak lanjut yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Dengan demikian, ronde keperawatan klinis berperan penting dalam menjamin mutu dan kesinambungan asuhan keperawatan yang berorientasi pada pasien
2. **Ronde Keperawatan Manajerial**, yang menekankan pada pengawasan pelaksanaan asuhan, kepatuhan terhadap standar, dan manajemen sumber daya di unit pelayanan. Ronde ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelayanan keperawatan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan organisasi, standar profesi, dan prinsip keselamatan pasien. Dalam ronde keperawatan manajerial, kepala ruangan atau manajer keperawatan melakukan peninjauan terhadap dokumentasi asuhan keperawatan, alur kerja pelayanan, pemanfaatan sarana dan prasarana, serta distribusi beban kerja perawat. Ronde ini juga digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan manajerial, seperti ketidaksesuaian prosedur, keterbatasan sumber daya, dan hambatan koordinasi tim, sehingga dapat dirumuskan langkah perbaikan yang sistematis dan berkelanjutan.

3. **Ronde Keperawatan Edukatif**, yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi perawat melalui diskusi kasus dan pembelajaran klinis berbasis praktik. Ronde ini berfungsi sebagai sarana pendidikan berkelanjutan (*continuing nursing education*) di lingkungan kerja. Dalam ronde keperawatan edukatif, perawat mendiskusikan kasus-kasus keperawatan yang menarik, kompleks, atau memiliki nilai pembelajaran tinggi, serta mengaitkannya dengan teori, standar praktik, dan bukti ilmiah terkini. Ronde ini juga mendorong perawat untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, pengambilan keputusan klinis, serta refleksi terhadap praktik keperawatan yang telah dilakukan. Dengan demikian, ronde keperawatan edukatif berkontribusi pada peningkatan profesionalisme perawat dan mutu asuhan keperawatan secara berkelanjutan.
4. **Ronde Keperawatan Multidisiplin**, yang melibatkan tenaga kesehatan lain seperti dokter, apoteker, dan ahli gizi untuk dalam pembahasan kondisi pasien dan pengambilan keputusan terpadu. Ronde ini bertujuan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang terpadu, komprehensif, dan berorientasi pada kebutuhan pasien. Dalam ronde keperawatan multidisiplin, setiap profesi menyampaikan perspektif dan rekomendasi sesuai dengan bidang keahliannya, sehingga rencana perawatan yang disusun bersifat holistik dan terkoordinasi. Ronde ini juga memperkuat kolaborasi interprofesional, meningkatkan efektivitas komunikasi tim, serta meminimalkan risiko kesalahan akibat kurangnya koordinasi antarprofesi. Dengan demikian, ronde keperawatan multidisiplin menjadi instrumen penting dalam meningkatkan keselamatan pasien dan mutu pelayanan kesehatan secara keseluruhan.

Contoh aplikatif, di ruang perawatan intensif, dilakukan ronde multidisiplin pada pasien kritis dengan ventilator. Perawat menyampaikan hasil pengkajian keperawatan, sementara tenaga kesehatan lain memberikan masukan sesuai bidangnya. Hasil diskusi digunakan untuk menyusun rencana perawatan terpadu yang berfokus pada stabilisasi kondisi pasien.

## **E. Peran dan Tanggung Jawab dalam Ronde Keperawatan**

Pelaksanaan ronde keperawatan melibatkan beberapa peran penting. Kepala ruangan berperan sebagai koordinator dan supervisor, memastikan ronde berjalan sesuai standar serta memberikan arahan dan umpan balik. Perawat primer atau perawat pelaksana bertanggung jawab menyampaikan kondisi pasien, masalah keperawatan, dan hasil asuhan yang telah diberikan. Perawat senior atau clinical instructor berperan sebagai fasilitator pembelajaran dan pembimbing klinis. Kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain diperlukan untuk memperkuat pengambilan keputusan yang komprehensif. Mahasiswa keperawatan, jika terlibat, berperan sebagai peserta pembelajaran dengan tetap berada di bawah supervisi perawat profesional. Keterlibatan mahasiswa bertujuan meningkatkan pemahaman klinik dan keterampilan komunikasi profesional.

Contoh aplikatif, dalam ronde pagi, perawat primer memaparkan kondisi pasien stroke, sementara perawat pelaksana menyampaikan perkembangan kemampuan mobilisasi pasien. Kepala ruangan kemudian memberikan arahan terkait penyesuaian rencana asuhan dan dokumentasi keperawatan.

## **F. Tahapan Pelaksanaan Ronde Keperawatan**

Pelaksanaan ronde keperawatan dilakukan melalui tahapan yang sistematis yang saling berkesinambungan, dimulai dari tahap persiapan, meliputi penentuan waktu, pemilihan pasien, penyiapan data klinis, dan pembagian peran tim, menetapkan tujuan ronde, serta menyiapkan data dan dokumentasi keperawatan yang diperlukan. Persiapan yang baik akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan ronde.

Tahap berikutnya adalah tahap pelaksanaan, dengan kunjungan langsung ke pasien, penyampaian kondisi pasien oleh perawat, observasi langsung, dan diskusi singkat di sisi tempat tidur pasien dengan melibatkan pasien. Pada tahap ini, perawat menyampaikan kondisi pasien, mendiskusikan masalah keperawatan, serta merumuskan rencana asuhan secara kolaboratif. Pelaksanaan ronde harus memperhatikan etika, komunikasi terapeutik, dan keselamatan pasien.

Setelah pelaksanaan, dilakukan tahap diskusi dan klarifikasi. Tim keperawatan mendalami hasil temuan, mengkaji alternatif intervensi, serta menyepakati rencana tindak lanjut. Tahap ini penting untuk memastikan bahwa setiap anggota tim memiliki pemahaman yang sama.

Tahap akhir adalah evaluasi dan tindak lanjut, yaitu menilai efektivitas ronde dan implementasi hasil diskusi ke dalam praktik keperawatan. Hasil ronde kemudian didokumentasikan secara sistematis sebagai bagian dari rekam medis dan evaluasi mutu pelayanan.

Contoh, pada ronde sore, tim keperawatan mengevaluasi pasien dengan risiko jatuh. Setelah diskusi, tim menyepakati penambahan intervensi pencegahan jatuh dan melakukan dokumentasi tindak lanjut pada catatan keperawatan.

## G. Latihan

Latihan pada bab ini disusun untuk membantu mahasiswa menguji pemahaman konseptual dan kemampuan aplikatif terkait pelaksanaan ronde keperawatan dalam praktik keperawatan profesional. Bentuk latihan meliputi soal pilihan ganda dan soal berbasis kasus atau pemecahan masalah dalam bentuk esai. Melalui latihan ini, mahasiswa diharapkan mampu mengintegrasikan teori dengan praktik klinik secara sistematis, kritis, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar pelayanan keperawatan, prinsip keselamatan pasien, serta bertanggungjawab terhadap etika profesi.

### Soal Latihan Pilihan Ganda

1. Ronde keperawatan didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh tim keperawatan untuk:
  - A. Menggantikan visite dokter dalam pelayanan pasien
  - B. Membahas kondisi pasien secara informal tanpa dokumentasi
  - C. Membahas kondisi pasien, masalah keperawatan, dan rencana asuhan secara sistematis
  - D. Menyampaikan laporan administrasi unit keperawatan
  - E. Melakukan audit keuangan unit pelayanan
2. Tujuan utama pelaksanaan ronde keperawatan dalam pelayanan kesehatan adalah untuk:
  - A. Meningkatkan jumlah tindakan keperawatan
  - B. Menjamin kesinambungan asuhan dan keselamatan pasien
  - C. Mengurangi beban kerja perawat
  - D. Mempercepat proses administrasi pasien
  - E. Menggantikan fungsi supervisi kepala ruangan



3. Ronde keperawatan yang berfokus pada pembahasan masalah keperawatan dan kondisi klinis pasien disebut:
  - A. Ronde keperawatan manajerial
  - B. Ronde keperawatan edukatif
  - C. Ronde keperawatan klinis
  - D. Ronde keperawatan multidisiplin
  - E. Ronde keperawatan administratif
  
4. Ronde keperawatan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perawat melalui diskusi kasus disebut:
  - A. Ronde keperawatan klinis
  - B. Ronde keperawatan manajerial
  - C. Ronde keperawatan multidisiplin
  - D. Ronde keperawatan edukatif
  - E. Ronde keperawatan struktural
  
5. Ronde keperawatan multidisiplin ditandai dengan:
  - A. Pelaksanaan ronde hanya oleh perawat pelaksana
  - B. Keterlibatan tenaga kesehatan lain dalam pengambilan keputusan
  - C. Fokus pada audit dokumentasi keperawatan
  - D. Penilaian kinerja perawat secara individu
  - E. Pembahasan aspek keuangan pelayanan
  
6. Perawat penanggung jawab asuhan (PPJA) dalam ronde keperawatan memiliki tanggung jawab utama untuk:
  - A. Menentukan diagnosis medis pasien
  - B. Memimpin diskusi dan menyampaikan kondisi pasien
  - C. Mengisi seluruh dokumentasi administrasi
  - D. Menilai kinerja dokter
  - E. Menyusun kebijakan rumah sakit

7. Salah satu peran utama kepala ruangan dalam ronde keperawatan adalah:
  - A. Melaksanakan seluruh tindakan keperawatan langsung
  - B. Mengawasi dan memastikan ronde berjalan sesuai standar
  - C. Menggantikan peran ketua tim
  - D. Menentukan terapi medis pasien
  - E. Menyampaikan laporan keuangan unit
8. Tahap awal dalam pelaksanaan ronde keperawatan adalah:
  - A. Evaluasi hasil asuhan
  - B. Diskusi tindak lanjut
  - C. Persiapan dan pembukaan ronde
  - D. Penyampaian masalah keperawatan
  - E. Dokumentasi hasil ronde
9. Salah satu prinsip utama dalam pelaksanaan ronde keperawatan adalah:
  - A. Berorientasi pada kepentingan organisasi semata
  - B. Berfokus pada pasien dan keselamatan pasien
  - C. Dilaksanakan hanya bila ada masalah
  - D. Tidak perlu dokumentasi tertulis
  - E. Dilaksanakan secara informal
10. Dokumentasi hasil ronde keperawatan berfungsi untuk:
  - A. Menggantikan catatan perkembangan pasien
  - B. Menjadi bukti akuntabilitas dan tindak lanjut pelayanan
  - C. Kepentingan administratif semata
  - D. Mengurangi beban kerja perawat
  - E. Menggantikan laporan shift

### Soal Esai Analitik

1. Di sebuah unit rawat inap, ditemukan bahwa beberapa perawat tidak mengikuti pelaksanaan ronde keperawatan secara rutin. Akibatnya, terjadi ketidaksinambungan asuhan dan kesalahan dalam pemberian intervensi keperawatan.

Pertanyaan:

- a. Jelaskan pengertian dan tujuan ronde keperawatan dalam konteks kasus tersebut.
  - b. Analisis dampak tidak terlaksananya ronde keperawatan terhadap keselamatan pasien dan mutu pelayanan.
  - c. Uraikan peran kepala ruangan dan PPJA dalam memperbaiki pelaksanaan ronde keperawatan di unit tersebut.
2. Dalam suatu ronde keperawatan multidisiplin, terjadi perbedaan pendapat antara perawat dan dokter mengenai prioritas tindakan pada seorang pasien dengan kondisi kritis.

Pertanyaan:

- a. Jelaskan pengertian dan karakteristik ronde keperawatan multidisiplin.
- b. Analisis bagaimana prinsip komunikasi efektif dan kolaborasi harus diterapkan dalam situasi tersebut.
- c. Uraikan langkah-langkah yang perlu dilakukan agar pengambilan keputusan tetap berorientasi pada keselamatan pasien.

### Kunci Jawaban:

- |      |       |
|------|-------|
| 1. C | 6. B  |
| 2. B | 7. B  |
| 3. C | 8. C  |
| 4. D | 9. B  |
| 5. B | 10. B |

## H. Rangkuman Materi

Ronde keperawatan merupakan metode manajemen pelayanan keperawatan yang dilaksanakan secara terstruktur melalui kunjungan langsung ke pasien untuk membahas kondisi klinis, masalah keperawatan, intervensi yang telah dan akan dilakukan, serta evaluasi hasil asuhan keperawatan. Kegiatan ini melibatkan komunikasi profesional, diskusi klinis, dan pengambilan keputusan berbasis bukti guna meningkatkan mutu pelayanan serta keselamatan pasien. Secara konseptual, ronde keperawatan menekankan penalaran klinis perawat dalam mengaitkan data objektif dan subjektif pasien dengan teori keperawatan, mengidentifikasi masalah aktual dan potensial, menetapkan prioritas tindakan, serta mengevaluasi luaran asuhan yang telah diberikan. Selain sebagai sarana pelayanan, ronde keperawatan juga berfungsi sebagai media pembelajaran klinik, supervisi, serta pengendalian mutu praktik keperawatan.

Tujuan umum ronde keperawatan adalah meningkatkan mutu asuhan keperawatan melalui pendekatan kolaboratif, sistematis, dan berfokus pada kebutuhan pasien. Secara khusus, ronde keperawatan bertujuan meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan penalaran klinis perawat melalui diskusi kasus berbasis kondisi nyata pasien, memperkuat komunikasi dan kolaborasi dalam tim keperawatan agar tercapai kesinambungan pelayanan dan pencegahan kesalahan klinis, serta meningkatkan keselamatan dan kepuasan pasien melalui keterlibatan aktif pasien dalam proses perawatan dan pengambilan keputusan klinis. Pelaksanaan ronde keperawatan harus berlandaskan pada prinsip berfokus pada pasien, profesionalisme, komunikasi efektif, kolaborasi, dan keselamatan pasien. Seluruh diskusi dan keputusan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan serta keselamatan pasien dengan

mempertimbangkan aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Profesionalisme menuntut perawat menyampaikan informasi berdasarkan data yang akurat, bukti ilmiah, dan hasil pengkajian yang dapat dipertanggungjawabkan, serta menjunjung tinggi etika dan kerahasiaan pasien. Komunikasi efektif dilakukan secara terbuka, saling menghargai, dan menggunakan bahasa profesional yang sistematis, dengan dianjurkan memanfaatkan model terstruktur seperti SBAR atau ISBAR. Prinsip kolaborasi menekankan keterlibatan aktif seluruh anggota tim keperawatan dan tenaga kesehatan lain dalam pengambilan keputusan terpadu, sedangkan prinsip keselamatan pasien mengutamakan pencegahan kesalahan, kepatuhan terhadap standar operasional prosedur, serta deteksi dini risiko klinis.

Berdasarkan tujuan dan fokus pembahasannya, ronde keperawatan diklasifikasikan menjadi ronde keperawatan klinis, manajerial, edukatif, dan multidisiplin. Ronde keperawatan klinis berfokus pada kondisi pasien, masalah keperawatan, respons terhadap intervensi, dan evaluasi luaran asuhan. Ronde keperawatan manajerial menitikberatkan pada pengawasan mutu pelayanan, kepatuhan terhadap standar, dan pengelolaan sumber daya di unit pelayanan. Ronde keperawatan edukatif bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi perawat melalui pembelajaran klinik berbasis kasus. Ronde keperawatan multidisiplin melibatkan berbagai profesi kesehatan untuk menyusun rencana perawatan terpadu yang holistik dan terkoordinasi.

Pelaksanaan ronde keperawatan melibatkan beberapa peran utama, yaitu kepala ruangan sebagai koordinator dan supervisor, perawat primer atau pelaksana sebagai penyampai kondisi pasien dan hasil asuhan, perawat senior atau clinical instructor sebagai fasilitator pembelajaran dan

pembimbing klinis, serta tenaga kesehatan lain sebagai mitra kolaborasi dalam pengambilan keputusan terpadu. Mahasiswa keperawatan, apabila terlibat, berperan sebagai peserta pembelajaran di bawah supervisi perawat profesional untuk meningkatkan pemahaman klinik dan keterampilan komunikasi profesional.

Ronde keperawatan dilaksanakan melalui tahapan sistematis yang meliputi tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap diskusi dan klarifikasi, serta tahap evaluasi dan tindak lanjut. Tahap persiapan mencakup penentuan waktu, pemilihan pasien, penyiapan data klinis, pembagian peran, dan penetapan tujuan ronde. Tahap pelaksanaan dilakukan melalui kunjungan langsung ke pasien, pemaparan kondisi pasien, observasi, dan diskusi singkat di sisi tempat tidur pasien dengan tetap memperhatikan etika dan keselamatan pasien. Tahap diskusi dan klarifikasi bertujuan mendalami temuan, mengkaji alternatif intervensi, dan menyepakati rencana tindak lanjut, sedangkan tahap evaluasi dan tindak lanjut dilakukan untuk menilai efektivitas ronde, mengimplementasikan hasil diskusi ke dalam praktik keperawatan, serta mendokumentasikan hasilnya secara sistematis.

Secara keseluruhan, ronde keperawatan merupakan metode strategis dalam manajemen pelayanan keperawatan yang berfungsi meningkatkan mutu asuhan, keselamatan pasien, dan profesionalisme perawat. Melalui prinsip berfokus pada pasien, komunikasi efektif, kolaborasi, dan keselamatan pasien, ronde keperawatan menjadi sarana klinis, manajerial, dan edukatif yang terintegrasi. Pelaksanaan ronde secara sistematis dan berkelanjutan mendukung tercapainya pelayanan keperawatan yang bermutu, holistik, dan berorientasi pada kebutuhan pasien.

## **Glosarium**

CI : *Clinical Instructor*

ISBAR : *Identification, Situation, Background, Assessment, Recommendation, dan Observation.*

SBAR : *Situation, Background, Assessment, Recommendation, dan Observation*

# BAB 5

## Discharge Planning

### Pendahuluan

*Discharge planning* merupakan salah satu komponen esensial dalam pelayanan keperawatan yang bertujuan menjamin kesinambungan asuhan pasien dari fasilitas pelayanan kesehatan ke lingkungan rumah atau layanan lanjutan lainnya. Proses ini tidak hanya berfokus pada waktu kepulangan pasien dari rumah sakit, tetapi mencakup perencanaan sistematis yang dimulai sejak awal pasien dirawat, dilaksanakan secara berkelanjutan, dan dievaluasi hingga pasien benar-benar mampu melanjutkan perawatan secara mandiri atau dengan dukungan keluarga dan tenaga kesehatan di komunitas. Dalam konteks pelayanan kesehatan modern yang menuntut mutu, efisiensi, dan keselamatan pasien, *discharge planning* menjadi strategi penting untuk mencegah kekambuhan, menurunkan angka rawat ulang (*readmission*), serta meningkatkan kualitas hidup pasien setelah keluar dari rumah sakit.

Perawat memiliki peran sentral dalam pelaksanaan *discharge planning* karena perawat merupakan tenaga kesehatan yang paling lama dan paling sering berinteraksi dengan pasien dan keluarga selama masa perawatan. Melalui proses keperawatan yang sistematis, perawat melakukan pengkajian kebutuhan pasien, mengidentifikasi masalah dan risiko pascapulang, menyusun rencana edukasi dan tindak lanjut, serta mengevaluasi kesiapan pasien dan keluarga dalam melanjutkan perawatan di rumah. Dengan demikian, *discharge planning* tidak hanya dipahami sebagai aktivitas administratif menjelang kepulangan pasien, tetapi sebagai bagian integral dari asuhan keperawatan yang berorientasi pada keselamatan pasien, pemberdayaan pasien dan keluarga, serta kesinambungan pelayanan.



Dalam praktik klinik, pelaksanaan discharge planning yang tidak optimal sering berdampak pada rendahnya kepatuhan pasien terhadap regimen terapi, kesalahan penggunaan obat, ketidaksiapan keluarga dalam memberikan perawatan lanjutan, serta meningkatnya risiko komplikasi dan rawat ulang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa discharge planning harus dilaksanakan secara terstruktur, terdokumentasi dengan baik, dan didukung oleh komunikasi terapeutik yang efektif antara perawat, pasien, keluarga, dan tim kesehatan lain. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai konsep, prinsip, tahapan, dan peran perawat dalam discharge planning menjadi kompetensi dasar yang wajib dimiliki oleh setiap perawat profesional.

Bab ini disusun untuk memberikan landasan konseptual dan operasional mengenai discharge planning dalam praktik keperawatan. Materi dalam bab ini mencakup pengertian dan tujuan discharge planning, prinsip-prinsip pelaksanaannya, tahapan proses discharge planning, peran dan tanggung jawab perawat, serta kolaborasi interprofesional dalam menjamin kesinambungan asuhan pasien. Selain itu, bab ini juga membahas tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan discharge planning serta strategi peningkatan mutu discharge planning di fasilitas pelayanan kesehatan. Penyajian materi dirancang secara sistematis dan berbasis praktik untuk membantu mahasiswa dan perawat memahami serta mengaplikasikan discharge planning secara efektif dan bertanggung jawab.

Secara pedagogis, bab ini diharapkan mampu mendukung pencapaian capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) dan sub-capaian pembelajaran mata kuliah (Sub-CPMK) pada pendidikan keperawatan sesuai standar SN DIKTI, khususnya dalam aspek penguasaan konsep keperawatan komunitas dan keperawatan medikal bedah, keterampilan komunikasi terapeutik, pengambilan keputusan klinis, serta penerapan prinsip keselamatan pasien. Dengan mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep discharge planning, menganalisis kebutuhan pasien pascapulung, menyusun rencana discharge planning yang komprehensif, serta menunjukkan sikap profesional dan etis dalam mendampingi pasien dan keluarga selama proses transisi perawatan.

Dengan demikian, discharge planning merupakan proses strategis dalam asuhan keperawatan yang berperan penting dalam menjamin kesinambungan pelayanan, meningkatkan keselamatan pasien, serta memperkuat peran perawat sebagai pendidik, advokat, dan koordinator pelayanan kesehatan. Pemahaman dan penerapan discharge planning secara tepat akan berkontribusi terhadap peningkatan mutu pelayanan keperawatan dan pencapaian luaran kesehatan pasien yang optimal.

## CPMK dan Sub-CPMK

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) pada bab ini adalah mahasiswa mampu menganalisis dan menerapkan konsep *discharge planning* secara komprehensif dan berkesinambungan sebagai bagian dari asuhan keperawatan profesional untuk meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan pasien, dan kesinambungan perawatan di berbagai tatanan pelayanan kesehatan. Adapun Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK) dirumuskan sebagai berikut:

1. Mahasiswa mampu menjelaskan dan merumuskan pengertian *discharge planning* sebagai proses keperawatan yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan sejak pasien masuk hingga keluar dari fasilitas pelayanan kesehatan.
2. Mahasiswa mampu menganalisis tujuan *discharge planning* dalam menjamin kontinuitas asuhan keperawatan, meningkatkan kemandirian pasien dan keluarga, serta mencegah komplikasi dan rehospitalisasi.
3. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan tahapan *discharge planning* yang meliputi pengkajian, perencanaan, implementasi, evaluasi, dan dokumentasi sesuai standar praktik keperawatan.
4. Mahasiswa mampu menganalisis peran *discharge planning* sebagai strategi peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien melalui edukasi, koordinasi lintas profesi, dan manajemen risiko pasca perawatan.
5. Mahasiswa mampu mengevaluasi dan mengembangkan inovasi *discharge planning* berbasis teknologi informasi, pelayanan berpusat pada pasien (*patient-centered care*), dan kolaborasi interprofesional dalam sistem pelayanan kesehatan modern.

Untuk mendukung pencapaian CPMK dan Sub-CPMK tersebut, berikut disajikan petunjuk pembelajaran yang perlu diperhatikan agar mahasiswa dapat menguasai materi yang dibahas dalam bab ini secara optimal.

- Mahasiswa membaca dan memahami CPMK, Sub-CPMK, serta pendahuluan sebagai acuan pembelajaran.
- Mahasiswa membaca materi pokok pembelajaran secara sistematis dan cermat.
- Mahasiswa mencermati konsep utama, istilah kunci, dan definisi pentingnya *discharge planning*.
- Mahasiswa mengaitkan materi dengan penerapan fungsi manajemen dalam praktik profesional.
- Mahasiswa melakukan diskusi untuk memperdalam pemahaman dan berpikir kritis.
- Mahasiswa mengerjakan tugas, latihan, atau refleksi pada akhir bab.
- Mahasiswa memanfaatkan sumber belajar tambahan yang relevan.

# Uraian Materi

---

## A. Pengertian *Discharge Planning*

*Discharge planning* merupakan suatu proses perencanaan asuhan keperawatan yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan berkesinambungan untuk mempersiapkan pasien dan keluarga dalam menghadapi transisi perawatan dari fasilitas pelayanan kesehatan ke rumah atau ke layanan kesehatan lainnya (Nursalam, 2015). *Discharge planning* tidak hanya berfokus pada saat pasien akan pulang, tetapi telah dimulai sejak awal pasien masuk ke fasilitas pelayanan kesehatan dan berlanjut hingga pasien mampu melakukan perawatan mandiri secara optimal.

*Discharge planning* merupakan suatu proses sistematis, terencana, dan terkoordinasi yang dimulai sejak pasien masuk ke fasilitas pelayanan kesehatan hingga pasien dipulangkan. Proses ini bertujuan untuk menjamin kontinuitas perawatan, meningkatkan kemandirian pasien dan keluarga, serta meminimalkan risiko komplikasi, kekambuhan, dan rehospitalisasi. Pelaksanaan *discharge planning* yang efektif membutuhkan keterlibatan aktif perawat sebagai koordinator asuhan, kolaborasi antarprofesi, serta partisipasi pasien dan keluarga sebagai pusat pengambilan keputusan dalam perawatan.

Secara konseptual, *discharge planning* dapat dipahami sebagai bagian integral dari proses keperawatan yang bertujuan menjamin kesinambungan asuhan (continuity of care). Melalui *discharge planning*, perawat bersama tim kesehatan lainnya mengidentifikasi kebutuhan pasien setelah keluar dari rumah sakit, merencanakan intervensi yang sesuai, serta memberikan edukasi dan dukungan yang diperlukan

agar pasien dan keluarga siap secara fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Dalam praktik keperawatan modern, *discharge planning* juga dipandang sebagai strategi pelayanan yang berorientasi pada pasien (*patient-centered care*) (Rosya, 2015). Hal ini berarti bahwa perencanaan kepulangan pasien disesuaikan dengan kondisi klinis, tingkat kemandirian, kemampuan keluarga, lingkungan tempat tinggal, serta sumber daya yang tersedia di masyarakat.. Dengan demikian, *discharge planning* bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan suatu proses profesional yang menuntut kemampuan klinis, komunikasi terapeutik, dan kolaborasi interprofesional.

## **B. Tujuan *Discharge Planning***

Pelaksanaan *discharge planning* memiliki tujuan yang luas dan komprehensif, baik bagi pasien, keluarga, tenaga kesehatan, maupun sistem pelayanan kesehatan secara keseluruhan (Ro'fi, et.al, 2015). Tujuan utama *discharge planning* adalah menjamin kesinambungan perawatan pasien setelah keluar dari fasilitas pelayanan kesehatan sehingga hasil asuhan yang telah dicapai selama perawatan dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Secara rinci tujuan tersebut sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesiapan pasien dan keluarga dalam menghadapi perawatan lanjutan di rumah atau di fasilitas kesehatan lain, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap.
2. Mencegah terjadinya komplikasi dan kekambuhan penyakit melalui edukasi yang tepat terkait pengobatan, perawatan mandiri, diet, aktivitas, serta tanda dan gejala yang perlu diwaspadai.
3. Menurunkan angka readmisi rumah sakit, khususnya readmisi yang disebabkan oleh ketidaksiapan pasien dan keluarga dalam melakukan perawatan lanjutan.

4. Meningkatkan kepatuhan pasien terhadap rencana terapi, termasuk penggunaan obat, kontrol lanjutan, dan perubahan gaya hidup.
5. Meningkatkan kepuasan pasien dan keluarga terhadap pelayanan keperawatan dan pelayanan kesehatan secara umum.
6. Mendukung efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan, dengan mengurangi lama hari rawat yang tidak perlu serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya.

Contoh aplikatif, pada pasien pasca stroke, *discharge planning* bertujuan memastikan pasien dan keluarga memahami program rehabilitasi, penggunaan alat bantu, serta jadwal kontrol. Dengan demikian, risiko komplikasi dan rawat ulang dapat ditekan.

### **C. Tahapan *Discharge Planning***

*Discharge planning* merupakan suatu proses yang berkesinambungan dan terintegrasi dengan proses keperawatan, yang dimulai sejak pasien pertama kali masuk ke rumah sakit hingga pasien dinyatakan siap pulang dan melanjutkan perawatan secara mandiri atau dengan dukungan keluarga serta layanan kesehatan lanjutan. Setiap tahapan *discharge planning* saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena hasil dari satu tahap menjadi dasar bagi pelaksanaan tahap berikutnya. Pelaksanaan *discharge planning* secara sistematis bertujuan menjamin kesinambungan asuhan, meningkatkan keselamatan pasien, mencegah komplikasi pascapulang, serta menurunkan angka rawat ulang. Tahapan *discharge planning* meliputi pengkajian, identifikasi masalah dan kebutuhan pasien, perencanaan, implementasi, dan evaluasi.

### 1. Pengkajian (Assessment)

Tahap pengkajian discharge planning dilakukan sejak awal pasien dirawat dan berlangsung secara berkelanjutan selama masa perawatan. Pada tahap ini, perawat mengumpulkan data komprehensif mengenai kondisi fisik pasien, seperti tingkat stabilitas klinis, kemampuan mobilisasi, status nutrisi, nyeri, serta adanya keterbatasan fungsi organ tertentu. Selain aspek fisik, pengkajian juga mencakup kemampuan fungsional pasien dalam melakukan aktivitas sehari-hari (*activities of daily living/ADL*), seperti makan, mandi, berpakaian, berpindah tempat, dan eliminasi.

Pengkajian aspek psikososial dilakukan untuk menilai kondisi emosional pasien, tingkat kecemasan, mekanisme koping, motivasi untuk sembuh, serta kesiapan mental menghadapi kepulangan. Perawat juga mengkaji dukungan keluarga, termasuk siapa yang akan menjadi caregiver utama, tingkat kemampuan keluarga dalam memberikan perawatan, serta ketersediaan waktu dan sumber daya keluarga. Selain itu, kondisi lingkungan rumah turut dikaji, seperti keamanan tempat tinggal, ketersediaan sarana sanitasi, akses air bersih, ventilasi, serta kemungkinan hambatan fisik yang dapat meningkatkan risiko jatuh atau cedera.

Pengkajian juga mencakup akses pasien terhadap fasilitas kesehatan lanjutan, seperti puskesmas, klinik, layanan home care, dan ketersediaan transportasi untuk kontrol ulang. Aspek penting lainnya adalah tingkat pemahaman pasien dan keluarga mengenai penyakit, terapi yang dijalani, penggunaan obat, diet, aktivitas yang dianjurkan atau dibatasi, serta tanda dan gejala kegawatan yang harus segera dilaporkan. Data yang diperoleh pada tahap ini harus dicatat secara sistematis dan menjadi dasar dalam penyusunan rencana discharge planning yang individual dan realistis.

## 2. Identifikasi Masalah dan Kebutuhan Pasien

Berdasarkan hasil pengkajian, perawat mengidentifikasi masalah dan kebutuhan pasien terkait persiapan kepulangan. Masalah tersebut dapat berupa keterbatasan kemampuan perawatan diri, kurangnya dukungan keluarga, keterbatasan akses pelayanan kesehatan, atau kurangnya pengetahuan tentang pengobatan dan perawatan lanjutan.

## 3. Perencanaan (*Planning*)

Pada tahap perencanaan, perawat menyusun rencana *discharge planning* secara individual dan realistis sesuai dengan kebutuhan pasien. Rencana ini mencakup edukasi kesehatan, rencana kontrol lanjutan, rujukan ke layanan kesehatan lain, serta koordinasi dengan tim kesehatan lain dan keluarga.

## 4. Implementasi (*Implementation*)

Tahap implementasi merupakan tahap pelaksanaan seluruh rencana *discharge planning* yang telah disusun. Pada tahap ini, perawat memberikan pendidikan kesehatan kepada pasien dan keluarga mengenai penyakit, terapi, penggunaan obat, perawatan mandiri, serta tanda dan gejala kegawatan. Perawat juga melatih pasien dan keluarga dalam keterampilan praktis, seperti penggunaan inhaler, suntikan insulin, perawatan luka, penggunaan alat bantu jalan, atau pengaturan posisi tubuh yang aman.

Implementasi *discharge planning* dilakukan melalui komunikasi terapeutik yang efektif dan partisipatif, sehingga pasien dan keluarga tidak hanya menerima informasi, tetapi juga memahami dan mampu mempraktikkannya secara mandiri.



Perawat berkoordinasi dengan dokter, farmasis, dan tenaga kesehatan lain untuk memastikan ketersediaan obat, alat kesehatan, rujukan layanan lanjutan, serta dukungan sosial yang dibutuhkan pasien. Pada tahap ini, perawat juga memastikan bahwa seluruh intervensi yang direncanakan telah dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur dan prinsip keselamatan pasien.

#### 5. Evaluasi (*Evaluation*)

Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas *discharge planning* yang telah diberikan. Perawat mengevaluasi tingkat pemahaman pasien dan keluarga, kesiapan pulang, serta kemampuan dalam melakukan perawatan mandiri. Hasil evaluasi ini menjadi dasar untuk perbaikan dan pengembangan *discharge planning* selanjutnya.

Sebagai contoh, pada pasien dengan penyakit paru kronis, perawat melakukan pengkajian terhadap kemampuan pasien menggunakan inhaler, tingkat pemahaman mengenai penyakit, dukungan keluarga, serta akses terhadap layanan kesehatan lanjutan. Berdasarkan hasil pengkajian, perawat mengidentifikasi adanya defisit keterampilan penggunaan inhaler dan kurangnya pengetahuan tentang pencegahan kekambuhan.

Perawat kemudian merencanakan edukasi dan pelatihan penggunaan inhaler, menyusun jadwal kontrol ulang, serta mengoordinasikan rujukan ke layanan rehabilitasi paru. Pada tahap implementasi, perawat melatih pasien menggunakan inhaler secara benar dan memastikan pasien mampu melakukan demonstrasi ulang. Tahap evaluasi dilakukan dengan menilai pemahaman pasien, keterampilan penggunaan inhaler, serta kesiapan pulang, kemudian mendokumentasikan seluruh proses *discharge planning* sebelum pasien dipulangkan.

## D. Upaya Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien

*Discharge planning* memiliki peran strategis dalam peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Transisi perawatan dari rumah sakit ke rumah merupakan fase yang rentan terhadap terjadinya kesalahan, seperti kesalahan penggunaan obat, ketidakpatuhan terapi, dan keterlambatan penanganan komplikasi. Oleh karena itu, *discharge planning* yang efektif dapat meminimalkan risiko tersebut.

Melalui *discharge planning*, perawat memastikan bahwa informasi penting terkait kondisi pasien, terapi, dan rencana tindak lanjut disampaikan secara jelas dan akurat kepada pasien dan keluarga. Hal ini sejalan dengan prinsip keselamatan pasien, khususnya dalam aspek komunikasi efektif dan kesinambungan asuhan. Selain itu, *discharge planning* juga mendukung pencapaian indikator mutu rumah sakit, seperti penurunan angka readmisi, peningkatan kepuasan pasien, dan peningkatan kepatuhan terhadap standar pelayanan. Dengan demikian, *discharge planning* bukan hanya tanggung jawab individu perawat, tetapi merupakan bagian dari sistem mutu pelayanan kesehatan yang memerlukan dukungan kebijakan, standar operasional prosedur, serta kolaborasi lintas profesi.

Contoh aplikatif, pada pasien lanjut usia dengan risiko jatuh, *discharge planning* difokuskan pada edukasi pencegahan jatuh di rumah, pengaturan lingkungan, serta penggunaan alat bantu, sehingga keselamatan pasien tetap terjaga setelah pulang.

## **E. Arah Pengembangan dan Inovasi *Discharge Planning* di Era Pelayanan Kesehatan Modern**

Perkembangan pelayanan kesehatan modern yang ditandai oleh kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, serta meningkatnya tuntutan mutu dan keselamatan pasien menuntut pelaksanaan *discharge planning* yang adaptif, responsif, dan inovatif. *Discharge planning* tidak lagi dipahami sebagai aktivitas administratif menjelang kepulangan pasien, tetapi sebagai proses transisi perawatan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berorientasi pada kebutuhan individu pasien. Dalam konteks ini, pengembangan *discharge planning* diarahkan pada pemanfaatan teknologi informasi, penguatan pendekatan *patient-centered care*, peningkatan kolaborasi interprofesional, serta integrasi layanan berbasis komunitas untuk menjamin kesinambungan asuhan pasien.

Salah satu arah utama pengembangan *discharge planning* adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung proses edukasi, pemantauan, dan tindak lanjut pasien pascapulung. Penggunaan aplikasi kesehatan, sistem rekam medis elektronik, dan platform *telehealth* memungkinkan perawat dan tenaga kesehatan lain memberikan edukasi berkelanjutan, memantau kondisi pasien dari jarak jauh, serta mendeteksi dini tanda-tanda komplikasi atau kekambuhan. Teknologi ini juga memfasilitasi pengingat penggunaan obat, jadwal kontrol ulang, serta penyampaian informasi kesehatan yang mudah diakses oleh pasien dan keluarga. Dengan demikian, *discharge planning* berbasis teknologi berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan pasien terhadap regimen terapi, pengurangan risiko rawat ulang, serta peningkatan efisiensi pelayanan kesehatan.

Sejalan dengan paradigma pelayanan kesehatan modern, pendekatan *patient-centered care* menjadi landasan penting dalam pengembangan *discharge planning*. Pendekatan ini

menegaskan bahwa pasien dan keluarga harus diposisikan sebagai subjek aktif dalam proses perencanaan pemulangan, bukan sekadar sebagai penerima informasi. Dalam praktiknya, perawat perlu melibatkan pasien dan keluarga dalam pengambilan keputusan, menghargai nilai, preferensi, budaya, serta keyakinan pasien, dan menyesuaikan rencana discharge planning dengan kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis pasien. Inovasi dalam discharge planning diarahkan pada penyusunan rencana pemulangan yang lebih personal, fleksibel, dan realistis, sehingga rencana tersebut benar-benar dapat diterapkan oleh pasien dan keluarga di lingkungan rumah.

Kolaborasi interprofesional juga menjadi fokus utama dalam pengembangan discharge planning di era modern. Sinergi antara perawat, dokter, farmasis, ahli gizi, fisioterapis, pekerja sosial, dan tenaga kesehatan lain memungkinkan penyusunan rencana pemulangan yang komprehensif dan terintegrasi. Setiap profesi memberikan kontribusi sesuai dengan kompetensinya, seperti pengaturan terapi medis, manajemen obat, rehabilitasi, dukungan psikososial, dan rujukan layanan lanjutan. Kolaborasi ini bertujuan meminimalkan fragmentasi pelayanan, mencegah kesalahan komunikasi, serta menjamin bahwa seluruh aspek kebutuhan pasien pascapulang telah dipertimbangkan secara menyeluruh.

Selain kolaborasi interprofesional, discharge planning berbasis komunitas menjadi salah satu inovasi strategis dalam meningkatkan kesinambungan asuhan. Pendekatan ini menekankan keterlibatan layanan kesehatan primer, seperti puskesmas, klinik keluarga, dan layanan home care, dalam proses tindak lanjut pasien setelah keluar dari rumah sakit. Integrasi antara rumah sakit dan layanan kesehatan komunitas memungkinkan pasien memperoleh pemantauan dan pendampingan berkelanjutan, terutama bagi pasien dengan penyakit kronis, disabilitas, atau keterbatasan akses pelayanan kesehatan. Discharge planning berbasis komunitas

juga memperkuat peran keluarga dan masyarakat sebagai sistem pendukung utama dalam proses pemulihan pasien.

Pengembangan model discharge planning berbasis komunitas dan kolaborasi dengan layanan kesehatan primer menempatkan pasien sebagai mitra aktif dalam perawatan serta memperkuat peran keluarga dan masyarakat dalam mendukung kesehatan pasien. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip promosi dan pencegahan penyakit dalam pelayanan kesehatan primer, serta mendukung keberlanjutan sistem kesehatan secara keseluruhan. Dengan adanya kesinambungan layanan dari rumah sakit ke komunitas, risiko kekambuhan, komplikasi, dan rawat ulang dapat ditekan secara signifikan.

Ke depan, discharge planning diharapkan berkembang menjadi suatu sistem yang lebih holistik, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan individu pasien. Pengembangan ini harus selaras dengan paradigma pelayanan kesehatan yang berfokus pada mutu, keselamatan pasien, efisiensi, dan keberlanjutan. Discharge planning tidak hanya bertujuan mempersiapkan kepulangan pasien, tetapi juga memastikan bahwa pasien memiliki kapasitas, sumber daya, dan dukungan yang memadai untuk mempertahankan status kesehatannya dalam jangka panjang.

Dalam kerangka tersebut, pengembangan discharge planning di era modern juga menuntut peningkatan kompetensi perawat, khususnya dalam penggunaan teknologi informasi, komunikasi terapeutik, dan kolaborasi interprofesional. Perawat perlu dibekali kemampuan literasi digital, keterampilan edukasi kesehatan berbasis teknologi, serta kemampuan menjalin kemitraan dengan pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan lain. Peningkatan kompetensi ini sejalan dengan capaian pembelajaran lulusan pendidikan keperawatan sesuai standar SN DIKTI, terutama dalam aspek penguasaan IPTEKS, keterampilan komunikasi profesional,

pengambilan keputusan klinis, dan penerapan prinsip keselamatan pasien.

Sebagai contoh aplikatif, pada pasien dengan penyakit kronis, seperti diabetes melitus atau penyakit paru obstruktif kronis, pasien diberikan akses terhadap aplikasi kesehatan untuk memantau kondisi kesehatannya, menerima pengingat penggunaan obat, mencatat gejala harian, serta berkomunikasi dengan tenaga kesehatan setelah pulang dari rumah sakit. Melalui aplikasi tersebut, perawat dapat memantau kepatuhan pasien terhadap terapi, memberikan umpan balik, serta melakukan intervensi dini apabila ditemukan tanda-tanda perburukan kondisi. Inovasi ini menunjukkan bahwa discharge planning tidak berhenti pada saat pasien keluar dari rumah sakit, tetapi berlanjut sebagai proses pendampingan yang berkesinambungan dan berbasis teknologi.

## **F. Latihan**

### **Soal Pilihan Ganda**

1. *Discharge planning* dalam praktik keperawatan modern dipahami sebagai proses yang ...
  - A. Dilakukan hanya menjelang pasien pulang dari rumah sakit
  - B. Bersifat administratif dan tidak terkait dengan proses keperawatan
  - C. Dimulai sejak pasien masuk hingga pasien mampu melakukan perawatan mandiri
  - D. Hanya melibatkan perawat sebagai pelaksana utama
  - E. Bertujuan mempercepat kepulangan pasien semata
2. Tujuan utama discharge planning adalah ...
  - A. Meningkatkan efisiensi kerja perawat
  - B. Menjamin kesinambungan perawatan pasien setelah keluar dari rumah sakit
  - C. Menurunkan beban kerja rumah sakit

- D. Mempercepat pemulangan pasien
  - E. Meningkatkan dokumentasi keperawatan
3. Pelaksanaan discharge planning yang efektif memerlukan keterlibatan aktif perawat sebagai ...
- A. Pelaksana tindakan medis
  - B. Koordinator asuhan dan fasilitator edukasi
  - C. Pengganti peran dokter
  - D. Penanggung jawab administratif
  - E. Pengawas mutu rumah sakit
4. Berikut ini merupakan salah satu tujuan khusus discharge planning, kecuali ...
- A. Meningkatkan kesiapan pasien dan keluarga
  - B. Mencegah komplikasi dan kekambuhan
  - C. Menurunkan angka readmisi rumah sakit
  - D. Meningkatkan kepuasan pasien dan keluarga
  - E. Meningkatkan lama hari rawat pasien
5. Tahap pengkajian discharge planning mencakup pengumpulan data mengenai ...
- A. Kondisi fisik pasien saja
  - B. Kondisi fisik, psikososial, dukungan keluarga, dan lingkungan rumah
  - C. Kondisi medis dan tindakan dokter
  - D. Status keuangan pasien
  - E. Kelengkapan administrasi rumah sakit
6. Identifikasi masalah dan kebutuhan pasien dalam discharge planning bertujuan untuk ...
- A. Menentukan diagnosis medis utama
  - B. Menetapkan prioritas intervensi persiapan kepulangan
  - C. Mempercepat proses pemulangan pasien
  - D. Menyusun jadwal visite dokter
  - E. Mengurangi biaya perawatan pasien

7. Pada tahap perencanaan discharge planning, perawat menyusun rencana yang ...
  - A. Bersifat umum dan seragam untuk semua pasien
  - B. Individual, realistis, dan sesuai kebutuhan pasien
  - C. Hanya berfokus pada edukasi obat
  - D. Hanya melibatkan pasien tanpa keluarga
  - E. Ditentukan sepenuhnya oleh dokter
  
8. Pelaksanaan edukasi kesehatan dan pelatihan keterampilan perawatan mandiri dilakukan pada tahap ...
  - A. Pengkajian
  - B. Identifikasi masalah
  - C. Perencanaan
  - D. Implementasi
  - E. Evaluasi
  
9. Evaluasi dalam discharge planning bertujuan untuk menilai...
  - A. kepuasan dokter terhadap perawat
  - B. efektivitas discharge planning dan kesiapan pasien pulang
  - C. kelengkapan administrasi rumah sakit
  - D. jumlah obat yang dikonsumsi pasien
  - E. lama hari rawat pasien
  
10. Discharge planning berbasis teknologi informasi bermanfaat terutama untuk ...
  - A. Menggantikan peran perawat
  - B. Mempercepat proses pemulangan
  - C. Memantau kondisi pasien dan meningkatkan kepatuhan terapi pascapulang
  - D. Mengurangi interaksi perawat dengan pasien
  - E. Meningkatkan beban kerja perawat



### Soal Esai Analitik

1. Seorang pasien laki-laki, usia 62 tahun, dirawat dengan diagnosis stroke iskemik. Pasien mengalami kelemahan ekstremitas kanan dan kesulitan berjalan. Istri pasien akan menjadi caregiver utama di rumah. Berdasarkan hasil pengkajian, diketahui bahwa keluarga belum memahami program rehabilitasi dan penggunaan alat bantu jalan.

Pertanyaan:

Jelaskan secara sistematis bagaimana perawat melaksanakan tahapan discharge planning pada kasus tersebut, mulai dari pengkajian hingga evaluasi, serta jelaskan peran perawat dalam menjamin kesinambungan asuhan pasien setelah pulang.

2. Seorang pasien perempuan, usia 55 tahun, dirawat dengan diagnosis penyakit paru obstruktif kronis (PPOK). Pasien akan dipulangkan dengan terapi inhaler dan obat oral. Pasien tinggal di daerah pinggiran kota dan memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan.

Pertanyaan:

Analisislah bagaimana discharge planning dapat berperan dalam meningkatkan keselamatan pasien dan menurunkan risiko rawat ulang pada kasus tersebut. Jelaskan pula bentuk inovasi discharge planning yang dapat diterapkan sesuai dengan perkembangan pelayanan kesehatan modern.

### Kunci Jawaban

- |      |       |
|------|-------|
| 1. C | 6. B  |
| 2. B | 7. B  |
| 3. B | 8. D  |
| 4. E | 9. B  |
| 5. B | 10. C |

## G. Rangkuman Materi

*Discharge planning* merupakan suatu proses perencanaan asuhan keperawatan yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan berkesinambungan untuk mempersiapkan pasien dan keluarga dalam menghadapi transisi perawatan dari fasilitas pelayanan kesehatan ke rumah atau ke layanan kesehatan lainnya. Proses ini dimulai sejak pasien masuk ke fasilitas pelayanan kesehatan dan berlanjut hingga pasien mampu melakukan perawatan mandiri secara optimal. Secara konseptual, *discharge planning* merupakan bagian integral dari proses keperawatan yang bertujuan menjamin kesinambungan asuhan (*continuity of care*) serta meningkatkan kemandirian pasien dan keluarga. Pelaksanaan *discharge planning* yang efektif menuntut keterlibatan aktif perawat sebagai koordinator asuhan, kolaborasi interprofesional, serta partisipasi pasien dan keluarga sebagai pusat pengambilan keputusan dalam perawatan. Dengan demikian, *discharge planning* bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan suatu proses profesional yang berorientasi pada *patient-centered care* dan menuntut kemampuan klinis, komunikasi terapeutik, serta kerja sama lintas profesi.

Tujuan *discharge planning* bersifat luas dan komprehensif, baik bagi pasien, keluarga, tenaga kesehatan, maupun sistem pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Tujuan utamanya adalah menjamin kesinambungan perawatan pasien setelah keluar dari fasilitas pelayanan kesehatan agar hasil asuhan yang telah dicapai selama perawatan dapat dipertahankan dan ditingkatkan. *Discharge planning* bertujuan meningkatkan kesiapan pasien dan keluarga dalam menghadapi perawatan lanjutan, mencegah komplikasi dan kekambuhan melalui edukasi yang tepat, menurunkan angka readmisi rumah sakit, meningkatkan kepatuhan pasien terhadap rencana terapi, serta

meningkatkan kepuasan pasien dan keluarga terhadap pelayanan keperawatan. Selain itu, *discharge planning* juga mendukung efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan dengan mengurangi lama hari rawat yang tidak perlu serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya.

*Discharge planning* dilaksanakan melalui tahapan yang saling berkaitan dan terintegrasi dengan proses keperawatan, yaitu pengkajian, identifikasi masalah dan kebutuhan pasien, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Tahap pengkajian dilakukan sejak awal pasien dirawat dan mencakup pengumpulan data komprehensif mengenai kondisi fisik, kemampuan fungsional, aspek psikososial, dukungan keluarga, kondisi lingkungan rumah, akses terhadap fasilitas kesehatan lanjutan, serta tingkat pemahaman pasien dan keluarga tentang penyakit dan terapi. Berdasarkan hasil pengkajian, perawat mengidentifikasi masalah dan kebutuhan pasien terkait persiapan kepulangan, seperti keterbatasan perawatan diri, kurangnya dukungan keluarga, keterbatasan akses pelayanan kesehatan, dan defisit pengetahuan. Pada tahap perencanaan, perawat menyusun rencana *discharge planning* yang individual dan realistis, mencakup edukasi kesehatan, rencana kontrol lanjutan, rujukan layanan, serta koordinasi dengan tim kesehatan dan keluarga. Tahap implementasi dilakukan melalui pemberian pendidikan kesehatan, pelatihan keterampilan perawatan mandiri, serta koordinasi interprofesional untuk memastikan ketersediaan obat, alat kesehatan, dan layanan lanjutan. Tahap evaluasi bertujuan menilai efektivitas *discharge planning*, tingkat pemahaman pasien dan keluarga, kesiapan pulang, serta kemampuan perawatan mandiri, yang hasilnya menjadi dasar perbaikan dan pengembangan *discharge planning* selanjutnya.

*Discharge planning* memiliki peran strategis dalam peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien, khususnya pada fase transisi perawatan dari rumah sakit ke rumah yang rentan terhadap kesalahan penggunaan obat, ketidakpatuhan terapi, dan keterlambatan penanganan komplikasi. Melalui *discharge planning*, perawat memastikan bahwa informasi penting terkait kondisi pasien, terapi, dan rencana tindak lanjut disampaikan secara jelas dan akurat kepada pasien dan keluarga, sejalan dengan prinsip komunikasi efektif dan kesinambungan asuhan. *Discharge planning* juga mendukung pencapaian indikator mutu rumah sakit, seperti penurunan angka readmisi, peningkatan kepuasan pasien, serta peningkatan kepatuhan terhadap standar pelayanan. Oleh karena itu, *discharge planning* bukan hanya tanggung jawab individu perawat, melainkan bagian dari sistem mutu pelayanan kesehatan yang memerlukan dukungan kebijakan, standar operasional prosedur, dan kolaborasi lintas profesi.

Di era pelayanan kesehatan modern, *discharge planning* berkembang menjadi proses yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan individu pasien. Pengembangan *discharge planning* diarahkan pada pemanfaatan teknologi informasi, penguatan pendekatan *patient-centered care*, peningkatan kolaborasi interprofesional, serta integrasi layanan berbasis komunitas. Penggunaan aplikasi kesehatan, rekam medis elektronik, dan *telehealth* memungkinkan edukasi berkelanjutan, pemantauan kondisi pasien dari jarak jauh, pengingat penggunaan obat, serta deteksi dini komplikasi. Pendekatan *patient-centered care* menempatkan pasien dan keluarga sebagai mitra aktif dalam perencanaan pemulangan, dengan rencana yang personal, fleksibel, dan realistis. Kolaborasi interprofesional dan *discharge planning* berbasis komunitas memperkuat kesinambungan layanan dari rumah sakit ke layanan kesehatan primer dan komunitas.

Kedepan, *discharge planning* diharapkan berkembang menjadi sistem yang holistik, adaptif, dan berkelanjutan, sejalan dengan paradigma pelayanan kesehatan yang berfokus pada mutu, keselamatan pasien, efisiensi, serta peningkatan kompetensi perawat dalam teknologi, komunikasi terapeutik, dan kolaborasi profesional.

## **Glosarium**

ADL : *Activities of Daily Living*

# Biodata Penulis



**Ns. Ari Sukma Nela, S.Kep., M.Kep.**

*Ari Sukma Nela* dilahirkan pada 7 Juli 1992 di sebuah desa kecil bernama Lolo. Ia merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, anak dari pasangan Bapak Ajis dan Ibu Fitrayanti. Sejak kecil, ia akrab disapa dengan panggilan Ayi. Ia merupakan lulusan dari Program Studi Magister Keperawatan Universitas Andalas Padang pada tahun 2020. Karier profesionalnya dimulai sejak tahun 2018 sebagai perawat di RSUP Dr. M. Djamil Padang. Pada tahun 2023, ia mulai mengabdikan diri sebagai dosen di bidang keperawatan. Di sela aktivitasnya mengajar, Ari juga aktif melakukan berbagai kegiatan ilmiah seperti penelitian, pengabdian dan penulisan buku, serta turut berperan aktif juga dalam organisasi profesi baik sebagai dosen maupun perawat. Komitmennya dalam dunia pendidikan dan pelayanan kesehatan menjadikan Ari sebagai sosok yang berdedikasi tinggi dalam pengembangan ilmu keperawatan di Indonesia.

Buku ini merupakan karya keempat dari penulis, setelah sebelumnya berhasil menerbitkan tiga buku referensi berjudul *Bandar D'Suka*: Buku Pedoman Tatalaksana Kegawatdaruratan Desa, buku Konsep Manajemen dan Kepemimpinan dalam Keperawatan dan buku monograf: Membangun Kepuasan Kerja Perawat melalui Implementasi Metode Tim yang Efektif. Melalui karya-karyanya, penulis terus menunjukkan konsistensinya dalam dunia literasi dan pengembangan pengetahuan, dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi para pembaca dan masyarakat luas.

# Daftar Pustaka

- Aditama, T. Y. (2004). *Manajemen administrasi rumah sakit*. UI Press.
- Bakri, M. H. (2017). *Manajemen keperawatan (Konsep dan aplikasi dalam praktik keperawatan profesional)*. Nuha Medika.
- Bass, B. M., & Riggio, R. E. (2006). *Transformational leadership* (2nd ed.). Psychology Press. <https://doi.org/10.4324/9781410617095>
- Cuya, M., & Bayona-Oré, S. (2022). From e-government to digital transformation: Leadership. *Lecture Notes in Networks and Systems*, 236, 147–155. [https://doi.org/10.1007/978-981-16-2380-6\\_13](https://doi.org/10.1007/978-981-16-2380-6_13)
- Dr. Ahmad Azmy, M.. (n.d.). *Teori dan Dasar Kepemimpinan*.
- Gillies, D. J. (1989). The floating interface: An international view. *Industry and Higher Education*, 3(4), 211–216. <https://doi.org/10.1177/095042228900300412>
- Ii, B. A. B., & Pustaka, T. (2012). Repository.unisba.ac.id (pp. 16–54).
- Kozier, B., Erb, G., & Berman, A. (2004). *Fundamentals of nursing: Concepts, process, and practice* (7th ed.). Pearson Prentice Hall.
- Meylda, S. D., & Izzati, U. A. (2025). Literature review: Kepuasan kerja pada karyawan. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(4), 7190–7199. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i4.9154>
- Nela, A. S. (2025). Manajemen dan kepemimpinan dalam keperawatan. In *Lingkar Edukasi Indonesia*.
- Nichols, A. L., Cook, C. L., & Cottrell, C. A. (2025). What do people desire in their leaders? An affordance management approach to trait desirability across domains. *Journal of Experimental Psychology: Applied*. <https://doi.org/10.1037/xap0000545>
- Nursalam. (2002). *Manajemen keperawatan: Aplikasi dalam praktik keperawatan profesional*. Salemba Medika.
- Nursalam. (2013). *Manajemen keperawatan: Aplikasi dalam praktik keperawatan profesional* (3rd ed.). Salemba Medika.

- Nursalam. (2015). *Manajemen keperawatan: Aplikasi dalam praktik keperawatan profesional* (5th ed.). Salemba Medika.
- Rofi'i, M., Hariyati, R. T. S., & Pujasari, H. (2013). Faktor personil dalam pelaksanaan discharge planning. *Jurnal Manajemen Keperawatan*, 1(2), 89–94.
- Rosya, E. (2015). *Discharge planning (Perencanaan pulang) di rumah sakit*. CV Pena Persada.
- Supervisi, D. (2011). *Swansburg (1990), melihat dimensi 5* (Issue 1998).
- Swansburg, R. C. (2000). *Pengantar kepemimpinan dan manajemen keperawatan untuk perawat klinis* (M. Ester, Ed.; S. Samba, Trans.). EGC.



## **Sinopsis**

Buku Konsep dan Praktik Manajemen Keperawatan hadir sebagai sumber pembelajaran yang komprehensif dalam memahami prinsip, fungsi, serta implementasi manajemen dalam praktik keperawatan. Disusun sebagai bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, buku ini mengintegrasikan konsep teoritis dengan aplikasi nyata di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit dan puskesmas.

Pembahasan dalam buku ini mencakup analisis teori manajemen dan kepemimpinan, fungsi-fungsi manajemen, hingga implementasi kegiatan manajerial keperawatan seperti pre conference, bedside handover, post conference, ronde keperawatan, serta discharge planning. Setiap bab dirancang secara sistematis untuk membantu pembaca memahami alur proses manajemen keperawatan secara utuh dan aplikatif.

Buku ini ditujukan bagi mahasiswa keperawatan, praktisi kesehatan, akademisi, serta peneliti yang ingin memperdalam pengetahuan dan keterampilan dalam bidang manajemen keperawatan. Dengan pendekatan yang mudah dipahami dan berbasis praktik, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat dalam meningkatkan mutu pelayanan keperawatan.

Buku Konsep dan Praktik Manajemen Keperawatan hadir sebagai sumber pembelajaran yang komprehensif dalam memahami prinsip, fungsi, serta implementasi manajemen dalam praktik keperawatan. Disusun sebagai bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, buku ini mengintegrasikan konsep teoritis dengan aplikasi nyata di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit dan puskesmas.

Pembahasan dalam buku ini mencakup analisis teori manajemen dan kepemimpinan, fungsi-fungsi manajemen, hingga implementasi kegiatan manajerial keperawatan seperti pre conference, bedside handover, post conference, ronde keperawatan, serta discharge planning. Setiap bab dirancang secara sistematis untuk membantu pembaca memahami alur proses manajemen keperawatan secara utuh dan aplikatif.

Buku ini ditujukan bagi mahasiswa keperawatan, praktisi kesehatan, akademisi, serta peneliti yang ingin memperdalam pengetahuan dan keterampilan dalam bidang manajemen keperawatan. Dengan pendekatan yang mudah dipahami dan berbasis praktik, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat dalam meningkatkan mutu pelayanan keperawatan.

Penerbit:

**PT OPTIMAL UNTUK NEGERI**

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620



Optimal  
Untuk  
Negeri



IKATAN PERAWAT INDONESIA

ISBN 978-634-7556-87-5 (PDF)



9

786347

556875